Cardiologie

I. EPREUVES

SEPTEMBRE 2025 (RATTRAPAGE)

Q1. Endocardite infectieuse

Citez trois critères majeurs et deux critères mineurs de l'endocardite infectieuse selon Duke et Li.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q2. Infarctus du myocarde

Énumérez 5 complications de l'infarctus du myocarde.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q3. Syncope

Citer 3 étiologies de la syncope d'origine cardiaque.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q4. Troubles du rythme cardiaque

La tachycardie sinusale est une tachycardie :

A) Irrégulière.
B) Jonctionnelle.
C) Régulière.
D) Supraventriculaire.
E) Toujours physiologique.

Q5. Troubles du rythme cardiaque

Quelle est la fréquence cardiaque normale au repos chez l'adulte ?

A) Entre 40 et 60 battements/minute.
B) Entre 60 et 80 battements/minute.
C) Entre 80 et 100 battements/minute.
D) Entre 100 et 120 battements/minute.
E) Supérieur à 120 battements/minute.

Q6. Troubles du rythme cardiaque

La bradycardie correspond à :

A) Une excitation atrial prématurée.
B) Une excitation ventriculaire prématurée.
C) Un rythme cardiaque supérieur à 100/minute.
D) Un rythme cardiaque irrégulier.
E) Un rythme cardiaque inférieur à 60/minute.

Q7. Troubles du rythme cardiaque

L'extrasystole atriale :

A) Est une excitation atriale prématurée.
B) Favorise les tachycardies atriales.
C) Favorise la fibrillation atriale.
D) Peut se manifester par des palpitations.
E) Survient toujours sur coeur pathologique.

Q8. Échographie transthoracique

L'échocardiographie est un moyen d'exploration du coeur qui se base sur :

A) Les positrons.
B) Les rayons X.
C) Les rayons Gamma.
D) La résonnance magnétique.
E) Les ultrasons.

Q9. Échographie transthoracique

En échocardiographie transthoracique, la fenêtre apicale comporte les incidences suivantes ?

A) 1 cavité.
B) 2 cavités.
C) 3 cavités.
D) 4 cavités.
E) 5 cavités.

Q10. Échographie transthoracique

En échocardiographie transthoracique, la fenêtre parasternale en coupe grand axe met en évidence :

A) L'aorte descendante.
B) La continuité septo-aortique.
C) La racine de l'aorte.
D) La continuité mitro-aortique.
E) L'oreillette droite.

Q11. Électrocardiogramme

Quelle(s) anomalie(s) relevez-vous à partir de l'ECG de Mme Hafida ?

A) Un flutter atrial.
B) Une fibrillation atriale.
C) Une hypertrophie ventriculaire gauche.
D) Un sus décalage typique du segment ST dans le territoire inférieur.
E) Une Hypertrophie auriculaire droite.

Q12. Rétrecissement mitral

Quelle(s) anomalie(s) relevez-vous à partir de la radiographie thoracique de cette patiente ?

A) Une cardiomégalie importante V4.
B) Un élargissement médiastinal.
C) Un arc moyen gauche en double bosse.
D) Un débord de l'Arc inférieur droit.
E) Un bouton aortique très calcifié.

Q13. Rétrecissement mitral

Le compte rendu d'échocardiographie mentionne un remaniement de la valve mitrale en museau de tanche, quelle valvulopathie évoquez vous ?

A) Insuffisance Mitrale.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Mitrale.
D) Fente Mitrale.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q14. Rétrecissement mitral

L'auscultation typique de cette valvulopathie est caractérisée par une triade appelée triade de DUROZIER, de quoi est elle faite ?

A) Un éclat de B2 + Roulement diastolique + claquement de fermeture mitrale.
B) Un éclat de B1 + Roulement systolique + claquement de fermeture mitrale.
C) Un éclat de B1 + Roulement diastolique + claquement de fermeture mitrale.
D) Un éclat de B2 + Roulement diastolique + claquement d'ouverture mitrale.
E) Aucune des réponses ci-dessus.

Q15. Rétrecissement mitral

Sur le plan physiopathologique, l'adaptation cardiaque à cette valvulopathie entraine :

A) Une hypertension pulmonaire post-capillaire.
B) Une dilatation de l'aorte.
C) Une dilatation de l'oreillette gauche.
D) Une dilatation du ventricule gauche.
E) Une baisse de la précharge du ventricule gauche.

Q16. Rétrecissement mitral

L'accident vasculaire cérébral ischémique qu'a présenté votre patiente est une des complications habituelles de cette valvulopathie, quelles en sont les autres complications auxquelles est exposée cette patiente ?

A) Une insuffisance cardiaque droite.
B) Une Syncope.
C) Une surinfection bronchique.
D) Un infarctus splénique.
E) La mort subite.

Q17. Rétrecissement mitral

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui signent que votre valvulopathie est sévère échographiquement ?

A) Une surface valvulaire de < 2mm².
B) Une Surface valvulaire < 1cm².
C) Un gradient moyen > 12mmHg.
D) Un gradient moyen > 40mmHg.
E) La mise en évidence d'un thrombus intra auriculaire gauche.

Q18. Rétrecissement mitral

Vous demandez une échocardiographie transoesophagienne pour votre patiente qu'attendez-vous de cet examen ?

A) Evaluer une insuffisance mitrale associée.
B) Rechercher un thrombus intra auriculaire gauche.
C) Voir les artères coronaires.
D) Evaluer l'aorte initiale.
E) Aucune de ces propositions.

Q19. Rétrecissement mitral

Si la sévérité de votre valvulopathie est confirmée, quelles sont les options thérapeutiques à proposer chez votre patiente ?

A) Un traitement médicamenteux à base de bétabloquants.
B) Un traitement anticoagulation après stabilisation de l'accident vasculaire.
C) Un remplacement valvulaire percutané.
D) Un traitement de remplacement valvulaire chirurgical.
E) Une abstention thérapeutique.

Q20. Rétrecissement mitral

Compte tenu de l'âge jeune et de l'état de sa valve, il a été décidé de pratiquer un traitement percutané de la valve malade, quelles sont les contre-indications de cette technique ?

A) Le bloc auriculo-ventriculaire.
B) La grossesse.
C) Le Thrombus intra auriculaire gauche.
D) L'existence d'une insuffisance aortique massive.
E) Des valves massivement calcifiées.

Q21. Rhumatisme articulaire aigu

La Chorée de Sydenham dans sa forme typique est caractérisée par :

A) Un début insidieux.
B) Des crises tonico-cloniques localisées.
C) Des mouvements anormaux ne disparaissant pas à l'émotion.
D) Des séquelles neurologiques définitives.
E) D'aucune de ces propositions.

Q22. Rhumatisme articulaire aigu

Le traitement de la cardite rhumatismale sévère est basé sur :

A) L'utilisation de 1200000 UI de benzathine pénicilline chez l'enfant de < 30 Kg de poids.
B) La prescription du repos au lit.
C) L'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) pendant 3 semaines en phase d'attaque.
D) L'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) pendant 15 jours en phase d'attaque.
E) L'utilisation de la pénicilline V à raison de 2 millions d'UI en intra veineux.

Q23. Insuffisance aortique

Quels sont parmi les propositions suivantes, les signes cliniques de sévérité de l'insuffisance aortique :

A) Un double souffle crural de DUROZIER.
B) Un pincement de la pression différentielle.
C) Un claquement méso-diastolique ou pistol-shot.
D) Une PAD < 50mmHg.
E) Un roulement diastolique de Flint.

Q24. Insuffisance mitrale

A propos de l'Insuffisance Mitrale chronique :

A) Est toujours asymptomatique.
B) Le souffle diastolique intense est un signe de sévérité.
C) Comme traitement on peut proposer un remplacement valvulaire par prothèse mécanique.
D) Un volume régurgitant (VR) >= 60ml signe la sévérité.
E) Impose au ventricule gauche une surcharge barométrique.

Q25. Péricardites aigues

Les complications de la péricardite aiguë incluent :

A) La myocardite associée.
B) La tamponnade.
C) La péricardite constrictive.
D) L'endocardite infectieuse.
E) La récidive.

Q26. Péricardites aigues

Parmi les situations suivantes en cas de péricardite aigue, lesquelles imposent l'hospitalisation ?

A) L'épanchement péricardique > 20 mm.
B) La tamponnade péricardique.
C) La fièvre supérieure à 38°C.
D) Un patient sous anticoagulant.
E) Un patient immunocompétent.

Q27. Hypertension artérielle

Concernant les modalités diagnostiques de l'Hypertension artérielle, lesquelles sont exactes :

A) La MAPA permet de diagnostiquer une HTA masquée.
B) L'effet blouse blanche est défini par une TA élevée au cabinet médical et normale en dehors de ce contexte.
C) Une seule mesure au cabinet suffit si >160/90 mmHg.
D) L'automesure favorise l'observance au traitement.
E) La présence d'une atteinte des organes cibles est obligatoire pour retenir le diagnostic.

Q28. Hypertension artérielle

Quelles sont les classes thérapeutiques utilisés dans le traitement de l'Hypertension artérielle ?

A) Les IEC (Inhibiteurs de l'enzyme de conversion).
B) Les Antihistaminiques H1.
C) Les ARA II (Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
D) Les Inhibiteurs calciques.
E) Les Benzodiazépines.

Q29. Cardiomyopathie

A propos de la Cardiomyopathie hypertrophique (CMH) :

A) L'altération de la fonction diastolique est directement liée à l'hypertrophie ventriculaire gauche.
B) Le souffle de la CMH est méso-systolique, avec absence du click éjectionnel.
C) Il n'existe pas d'atteinte extra cardiaque dans les CMH.
D) L'hypertrophie ventriculaire gauche est considérée majeure si l'épaisseur du septum interventriculaire >= 30mm.
E) Un Gradient intraventriculaire gauche est considéré significatif s'il est > 10mmHg.

Q30. Cardiomyopathie

A propos de la Cardiomyopathie dilatée (CMD) :

A) L'IRM est l'examen le plus contributif dans le cadre du bilan étiologique.
B) La CMD est définie par la présence d'une dilatation du VG et d'une dysfonction systolique non expliqués par les conditions de charge ou une coronaropathie.
C) L'insuffisance mitrale fonctionnelle est très rare dans la CMD.
D) La maladie coronaire est la principale étiologie de la CMD acquise.
E) L'insuffisance mitrale grade 3 ou 4 et la thrombose intraventriculaire gauche sont des facteurs de mauvais pronostic.

Q31. AOMI

Devant ce tableau (Patient 64 ans, diabétique, tabagique), quelles sont les origines qui en peuvent être responsables ?

A) Origine traumatologique.
B) Origine articulaire.
C) Origine neurologique.
D) Origine artérielle.
E) Origine veineuse.

Q32. AOMI

Quelle est le diagnostic le plus probable (abolition de tous les pouls du côté droit) ?

A) Artérite oblitérante des membres inférieurs.
B) Arthrite du genou droit.
C) Hernie discale lombaire.
D) Ischémie aiguë du membre inférieur droit.
E) Pied diabétique.

Q33. AOMI

S'il s'agit d'une artérite, qu'elle classe de la classification de Leriche et Fontaine s'agit - il (Périmètre de marche 80 m) ?

A) Stade I.
B) Stade II a.
C) Stade II b.
D) Stade III.
E) Stade IV.

Q34. AOMI

Quel est votre diagnostic lésionnel au vu de l'image de reconstruction (angioscanner) ?

A) Une sténose courte à l'origine de l'artère iliaque primitive droite.
B) Une sténose courte à l'origine de l'artère iliaque externe droite.
C) Une sténose courte à l'origine de l'artère iliaque externe gauche.
D) Une occlusion courte à l'origine de l'artère iliaque primitive droite.
E) Une occlusion courte à l'origine de l'artère iliaque externe droite.

Q35. AOMI

Quel(s) traitement(s) médical vous proposé ?

A) Aspirine 500 mg une fois par jour.
B) Aspirine 160 mg une fois par jour.
C) L'héparine à la SAP.
D) Statine si bilan lipidique perturbé.
E) Antibiolhérapie.

Q36. AOMI

Si vous avez décidé de revasculariser votre patient, quels sont les moyens de revascularisation possibles ?

A) Une angioplastie avec stenting.
B) Une angioplastie sans stent.
C) Un pontage anatomique.
D) Un pontage extra anatomique.
E) Une thrombolyse.

Q37. AOMI

Quelle est le moyen le moins invasif, et le moins couteux pour ce patient ?

A) Une angioplastie avec stenting.
B) Une angioplastie sans stent.
C) Un pontage anatomique.
D) Un pontage extra anatomique.
E) Une thrombolyse.

Q38. AOMI

Mise en évidence d'une gangrène de l'avant-pied droit, quels est votre diagnostic ?

A) Artérite stade I de Leriche et Fontaine.
B) Artérite stade IIa de Leriche et Fontaine.
C) Artérite stade IIb de Leriche et Fontaine.
D) Artérite stade III de Leriche et Fontaine.
E) Artérite stade IV de Leriche et Fontaine.

Q39. AOMI

Quel est votre diagnostic lésionnel (image reconstruction angioscanner 2) ?

A) Occlusion de l'artère fémorale commune droite avec reprise sur l'artère poplitée supra articulaire.
B) Occlusion de l'artère fémorale commune droite avec reprise sur l'artère poplitée inter articulaire.
C) Occlusion de l'artère fémorale commune droite avec reprise sur l'artère poplitée sous articulaire.
D) Occlusion de l'artère fémorale commune droite avec reprise sur le 1/3 inférieur de l'artère fémorale superficielle droite.
E) Occlusion de l'artère fémorale superficielle droite à son origine avec reprise sur le 1/3 inférieur de l'artère fémorale superficielle droite.

Q40. AOMI

Après discussions au staff, vous avez décidé de faire une revascularisation chirurgicale, quel type de pontage vous allez faire ?

A) Un pontage en PTFE anatomique.
B) Un pontage en PTFE extra anatomique.
C) Un pontage aortique.
D) Un pontage distal en PTFE.
E) Un pontage distal en veine.

Q41. AOMI

La gangrène est limitée à les racines des 5 orteils, quel geste d'amputation à faire ?

A) Pas de place d'amputation.
B) Amputation transmétatarsienne droite.
C) Amputation de jambe droite.
D) Amputation des trois premiers orteils.
E) Amputation des deux premiers orteils.

Q42. AOMI

Quelles complications à court terme peut survenir ?

A) Une thrombose de pontage.
B) Une infection de l'abord chirurgical.
C) Une péritonite.
D) Un hématome de scarpa.
E) Un hématome rétro péritonéal.

Q43. Dissection aortique aigue

La dissection aortique aigue :

A) Est une urgence médico-chirurgicale.
B) Plus fréquente chez les hommes.
C) Chez les patients non pris en charge la mortalité peut atteindre 1% à 2% par heure pendant les premières 48 heures.
D) La perfusion des organes dépend du vrai chenal.
E) Le traitement est toujours chirurgical.

Q44. Dissection aortique aigue

Concernant le diagnostic de la dissection aortique aigue :

A) La douleur thoracique peut être absente.
B) La Radiographie thoracique peut montrer un épanchement pleural.
C) L'échocardiographie transthoracique permet toujours le diagnostic.
D) L'angioscanner confirme le diagnostic et précise l'extension.
E) Les complications peuvent retarder le diagnostic.

Q45. Dissection aortique aigue

Le traitement de la dissection aortique de type A :

A) Le traitement médical est toujours indiqué.
B) La chirurgie est indiquée en cas de complications.
C) Nécessite l'utilisation d'une Circulation Extracorporelle (CEC).
D) Peut nécessiter un remplacement valvulaire aortique associée.
E) Aucune réponse n'est juste.

Q46. Dissection aortique aigue

Concernant un patient traité pour dissection aortique de type B :

A) Il y a un risque d'étendre la dissection.
B) Il y a un risque de développer un anévrisme de l'aorte abdominale.
C) Un traitement endovasculaire est parfois indiqué.
D) Un contrôle de la pression artérielle est obligatoire.
E) Il peut présenter une ischémie aiguë du membre inférieur.

Q47. Coarctation de l'aorte

Concernant la coarctation de l'aorte chez l'adulte :

A) Le diagnostic est suspecté devant une HTA chez un adulte jeune.
B) Elle est souvent mal tolérée.
C) C'est une urgence médico-chirurgicale.
D) Peut être compliqué d'AVC hémorragique.
E) Le traitement est exclusivement chirurgical.

Q48. Chururgie valvulaire

Chez un patient porteur de prothèse valvulaire mitrale mécanique, le médecin traitant doit :

A) Contrôler l'INR régulièrement.
B) Ajuster le traitement anticoagulant pour que l'INR soit entre 2.5 et 3.
C) Rechercher des foyers infectieux à chaque consultation.
D) Rechercher des signes de surdosage en AVK.
E) Toutes les réponses sont justes.

Q49. Endocardite infectieuse

Concernant l'endocardite infectieuse sur prothèse valvulaire :

A) C'est une complication rare et sans gravité.
B) Elle peut survenir précocement ou tardivement après l'intervention chirurgicale.
C) Les germes fréquemment retrouvés sont d'origine dentaire ou digestive.
D) Elle survient uniquement sur prothèses mécaniques.
E) L'antibioprophylaxie est obligatoire avant les soins dentaires.

Q50. Chirurgie coronaire

Un patient diabétique de 67 ans suivis pour angor montre des sténoses significatives de l'IVA, de la circonflexe et de la coronaire droite :

A) Le traitement médical seul est suffisant.
B) Le pontage coronaire est indiqué.
C) Le pontage peut se faire sans circulation extracorporelle.
D) Le greffon veineux saphène n'est plus utilisé.
E) Le greffon artériel mammaire interne est meilleur.

JUIN 2025 (NORMALE)

Q51. Insuffisance mitrale

Cas clinique : Madame A. Fatima, 22ans se présente en consultation pour une dyspnée d'effort d'aggravation rapidement progressive. Elle ne prend aucun traitement actuellement. Son examen clinique retrouve une tension artérielle de 105/69 mmnHg, et une Fréquence cardiaque à 89 c/min, son poids est de 72 kg pour une taille de 168cm. L'auscultation cardiaque retrouve un souffle systolique, apexien, coté 5/6ème, irradiant vers l'aisselle. Un signe de Harzer positif, de discret oedèmes rétro malléolaire et une turgescence spontanée des veines jugulaires. L'auscultation pulmonaire est claire, et le reste de l'examen clinique est sans particularités. Son ECG s'inscrit en rythme sinusal avec un hémibloc antérieur gauche.

Question 1 : Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant cette auscultation cardiaque anormale ?

A) Maladie Mitrale.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Insuffisance Aortique.
D) Insuffisance Tricuspide.
E) Insuffisance Mitrale.

Q52. Insuffisance mitrale

Quels sont les signes cliniques habituellement retrouvés chez les porteurs de cette valvulopathie ?

A) Une Dyspnée paroxystique nocturne.
B) Une douleur thoracique.
C) Des palpitations.
D) Une dyspnée d'effort.
E) Une syncope.

Q53. Insuffisance mitrale

Sur le plan physiopathologique cette valvulopathie impose au ventricule gauche :

A) Une surcharge volumétrique d'abord puis barométrique.
B) Une surcharge volumérique pure.

C) Une surcharge mixte.
D) Aucune surcharge ce qui explique le caractère longtemps asymptomatique de cette valvulopathie.
E) Une surcharge barométrique pure.

Q54. Insuffisance mitrale

Quel examen paraclinique ne peut être en aucun cas normal devant cette valvulopathie quelle que soit sa sévérité ?

A) Le cathétérisme cardiaque droit.
B) L'échocardiographie trans-thoracique.
C) L'électrocardiogramme.
D) La coronarographie.
E) La radiographie pulmonaire.

Q55. Insuffisance mitrale

Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui signe que votre valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?

A) La SOR retrouvée est < 20 mm².
B) La SOR retrouvée est < 40 mm².
C) La SOR retrouvée et entre 20 et 40 mm².
D) La SOR retrouvée est >= 40 mm².
E) La SOR n'est pas un paramètre de sévérité de cette valvulopathie.

Q56. Insuffisance mitrale

Sur son compte rendu l'échographiste trouve que l'un des feuillets de la valve responsable de l'anomalie est perforé de quel type de la classification de Carpentier s'agit-il ?

A) Type I.
B) Type II.
C) Type III.
D) Type I et III.
E) Aucune des réponses.

Q57. Insuffisance mitrale

Si votre diagnostic clinique se confirme, Quelle est la seule proposition parmi ces propositions qui vous décourageront à proposer une chirurgie à votre patiente même si elle est symptomatique ?

A) La présence de signes d'insuffisance cardiaque droite.
B) La présence d'une fibrillation auriculaire.
C) L'augmentation des pressions de remplissage du Ventricule Gauche.
D) L'altération de la fonction systolique avec une FE < 30%.
E) L'hypertension pulmonaire sévère.

Q58. Insuffisance mitrale

Parmi les moyens thérapeutiques dont vous disposez quels sont ceux que vous proposerez à cette patiente :

A) Un traitement médicamenteux.
B) Un remplacement valvulaire si la valve est jugée irréparable.
C) Un traitement instrumental type mitra-clip.
D) Une thérapie de resynchronisation type CRT.
E) Une antibioprophylaxie systématique contre l'endocardite infectieuse.

Q59. Insuffisance mitrale

La valvulopathie dont souffre cette patiente l'expose à plusieurs complications parmi lesquelles on trouve :

A) Une insuffisance cardiaque globale.
B) Une endocardite infectieuse.
C) Une fibrillation auriculaire.
D) Un accident vasculaire thrombo-embolique.
E) La Rechute de rhumatisme articulaire aigu.

Q60. Insuffisance mitrale

Cette patiente consulte aux urgences dans un tableau de choc cardiogénique sur aggravation brutale de sa valvulopathie, quelles sont les mesures à instaurer chez elle en urgence pour améliorer son tableau clinique ?

A) Un traitement médicamenteux à base de bétabloquants.
B) Un traitement par drogues vasoactives.
C) Un traitement Chirurgical après stabilisation rapide.
D) Un traitement par Inhibiteurs calciques pour réduire la post-charge.
E) Un traitement à base de diurétiques de l'anse de Henlé en cas de signes congestifs.

Q61. Rhumatisme articulaire aigu

Le traitement du rhumatisme articulaire aigu est basé sur :

A) L'utilisation de 600000 UI de benzathine pénicilline quel que soit le poids de votre patient.
B) L'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroidiens (AINS) chez les patients porteurs d'une cardite.
C) L'utilisation de la corticothérapie chez les patients porteurs d'une cardite.
D) L'utilisation de moyens physiques comme les vessies de glace pour refroidir l'inflammation.
E) L'utilisation de l'érythromycine en cas d'allergie à la pénicilline.

Q62. Insuffisance aortique

Quels sont parmi les propositions suivantes, les signes de sévérité clinique d'une Insuffisance Aortique chronique :

A) Un pincement de la pression différentielle.
B) Un souffle coté 5/6ème.
C) Une insuffisance ventriculaire Gauche.
D) Un roulement diastolique de Flint.
E) Une hyperpulsatilité artérielle.

Q63. Insuffisance cardiaque de l'adulte

L'insuffisance cardiaque (IC) à fraction d'éjection réduite est définie en 2021 par la Société européenne de cardiologie par :

A) La présence des signes et des symptômes d'IC uniquement.
B) L'association des signes et des symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection > 45%.
C) Une fraction d'éjection < 40%.
D) La présence des signes et symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection <= 50%.
E) Aucune de ces propositions.

Q64. Thrombose & Embolie

Un patient de 40 ans est admis aux urgences pour douleur thoracique, on suspecte chez lui une embolie pulmonaire. Sa probabilité clinique est jugée intermédiaire, l'examen paraclinique de première intention à demander est :

A) Le dosage des D-dimères par méthode ELISA.
B) L'électrocardiogramme.
C) L'angioscanner thoracique.
D) L'échocardiographie transthoracique.
E) L'échographie doppler veineuse des membres inférieurs.

Q65. Péricardites aigues

Le diagnostic de péricardite aiguë repose sur la présence d'au moins deux des éléments suivants :

A) Douleur thoracique typique.
B) Frottement péricardique.
C) Épanchement péricardique à l'échocardiographie.
D) Sus-décalage du segment ST concave et diffus.
E) Élévation des enzymes cardiaques.

Q66. Tamponnade

Quelles sont les éléments de la triade de Beck, caractéristique de la tamponnade ?

A) Cyanose, fièvre, crépitants pulmonaires.
B) Bradycardie, sueurs, hypotension.
C) Hypotension, turgescence jugulaire, bruits du coeur assourdis.
D) Dyspnée, tachycardie, douleur thoracique.
E) Douleur, épanchement pleural, souffle.

Q67. Hypertension artérielle

L'hypertension artérielle chez l'adulte, cochez les réponses exactes :

A) Elle est définie par une PAS >= 140 mmHg et/ou PAD >= 90 mmHg.
B) Elle peut être confirmée par automesure tensionnelle.
C) Elle est suspectée dès que la TA > 120/80 mmHg.
D) Elle nécessite obligatoirement une atteinte d'organe cible pour être définie.
E) Elle peut être diagnostiquée par MAPA 24h.

Q68. Hypertension artérielle

Parmi les signes suivants, lesquels traduisent une atteinte d'organes cibles liée à l'Hypertension artérielle ?

A) La présence de l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG.
B) Une microalbuminurie persistante.
C) Une rétinopathie hypertensive stade 1.
D) Une hypokaliémie isolée.
E) la présence de claudications intermittentes aux membres inférieurs.

Q69. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) :

A) La présence d'une obstruction dynamique à l'éjection du VG a un impact pronostique.
B) Les signes fonctionnels surviennent surtout au repos.
C) La présence d'un click éjectionnel au niveau du foyer aortique différencie le souffle de l'obstruction de celui du rétrécissement aortique valvulaire.
D) La présence d'un gradient d'obstruction inta-VG > 50mmHg signifie la présence d'un retentissement hémodynamique.
E) La valve mitrale est épargnée dans cette pathologie.

Q70. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie dilatée (CMD) :

A) Des thrombi intracavitaires peuvent exister surtout au niveau de l'apex.
B) Les artères coronaires sont souvent les plus touchées.
C) L'hémochromatose peut donner une CMD.
D) Le Traitement repose globalement sur les mêmes principes du traitement de l'insuffisance cardiaque.
E) La resynchronisation cardiaque ne fait pas partie des moyens de prise en charge de la CMD.

Q71. Troubles de conduction

cas clinique n1: Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s) :

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auricule-ventriculaire de premier degré.
C) Il existe une tachycardie sinusale.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe un sous décalage ST.

Q72. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Une seule hémoculture positive à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Auscultation cardiaque normale.
E) Protéinurie positive.

Q73. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de douleur de L'infarctus myocardique sont bien connus. Une seule proposition ci-dessous est juste ?

A) Douleur à la palpation.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) Sensible à la trinitrine.
D) Toujours à l'effort.
E) De durée brève.

Q74. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications rythmiques de l'infarctus du myocarde ?

A) Le bloc auriculo ventriculaire.
B) Les tachycardies ventriculaires.
C) Le thrombus du ventricule gauche.
D) La rupture septale.
E) Crise d'asthme.

Q75. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :

A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q76. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance brutale.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une crise polyurique.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q77. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 6 dérivations de bases.
D) 2 complexes par dérivation.
E) Papier non millimétré.

Q78. Syncope

Parmi les étiologies d'une syncope d'origine cardiaque :

A) Le rétrécissement aortique.
B) La tachycardie sinusale.
C) Le bloc auriculo ventriculaire complet.
D) L'origine vaso-vagale.
E) Tachycardie ventriculaire.

Q79. Syncope

Dans l'Etude de Framingham :

A) les patients inclus étaient tous jeunes.
B) La fréquence des syncopes est de 3%.
C) La prévalence des syncopes augmente avec l'âge.
D) Le diabète favorise la survenue de syncope d'origine cardiaque.
E) L'âge n'est pas un critère valide.

Q80. Infarctus du myocarde

Précisez une étiologie de l'infarctus du myocarde :

A) Athérosclérose.
B) infection.
C) Dissection aortique.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Hyperleucocytose.

Q81. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?

A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q82. Troubles du rythme cardiaque

Les troubles du rythme peuvent se manifester par :

A) Syncope.
B) Lipothymie.
C) Douleur thoracique.
D) Dyspnée.
E) Palpitations.

Q83. Infarctus du myocarde

Les autres diagnostics à éliminer avant de retenir l'IDM :

A) L'ulcère perforé.
B) La pancréatite aigue.
C) La dissection aortique.
D) La péricardite aigue.
E) L'embolie pulmonaire.

Q84. Troubles du rythme cardiaque

Le rythme sinusal :

A) Est le rythme cardiaque physiologique.
B) Est un rythme régulier.
C) Est un rythme jonctionnel.
D) Est compris entre 60 et 80 bpm au repos.
E) Nait du noeud sinusal.

Q85. Troubles du rythme cardiaque

La tachycardie sinusale est une tachycardie :

A) Irrégulière.
B) Jonctionnelle.
C) Régulière.
D) Supraventriculaire.
E) Toujours physiologique.

Q86. Troubles du rythme cardiaque

A l'électrocardiogramme, une tachycardie sinusale se distingue par des complexes QRS :

A) De morphologie normale.
B) Précédés par une onde « P ».
C) Précédés par un intervalle « PR » constant.
D) Toujours larges.
E) Toujours fins.

Q87. Troubles du rythme cardiaque

L'extrasystole atriale :

A) Est une excitation atriale prématurée.
B) Favorise les tachycardies atriales.
C) Favorise la fibrillation atriale.
D) Peut se manifeste par des palpitations.
E) Survient toujours sur coeur pathologique.

Q88. Troubles du rythme cardiaque

Le Flutter atrial est une tachycardie :

A) Atriale.
B) Irrégulière.
C) Jonctionnelle.
D) Régulière.
E) Supraventriculaire.

Q89. Echographie transthoracique

L'échocardiographie tansthoracique est un examen :

A) Invasif.

B) hémodynamique.
C) morphologique.
D) expérience dépendant.
E) opérateur dépendant.

Q90. Echographie transthoracique

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des fenêtres acoustiques (voies d'abord) à l'échocardiographie tansthoracique :

A) apicale.
B) infrasternale.
C) parasternale.
D) suprasternale.
E) Sous costale.

Q91. AAA

Dans les anévrysmes de l'aorte abdominale on distingue selon l'aspect :

A) Les anévrismes vrais.
B) Les anévrismes sacciformes.
C) Les Faux anévrismes.
D) Les anévrismes disséquants.
E) Les anévrismes fusiformes.

Q92. AAA

Dans les anévrysmes de l'aorte abdominale, le signe de De Bakey :

A) On le cherche à l'examen clinique à la phase de percussion.
B) S'il est positif, il signifie la localisation sus rénale de l'anévrysme.
C) S'il est positif, il signifie la localisation sous rénale de l'anévrysme.
D) S'il est positif, il signifie la localisation inter rénale de l'anévrysme.
E) Aucune réponse juste.

Q93. AOMI

Les facteurs de risque cardio-vasculaires validés sont :

A) L'Age jeune.
B) Le Sexe féminin.
C) Le Tabac.
D) Le Diabète.
E) La Sédentarité.

Q94. AOMI

L'Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) :

A) Le plus souvent consécutive à des lésions athéromateuses.
B) Provoque une diminution de la lumière des artères, et favorisant la formation de thrombose, depuis l'aorte abdominale jusqu'aux artères distales des deux membres inférieurs.
C) Est une atteinte obstructive des artères destinées aux membres inférieurs.
D) Une origine inflammatoire est possible.
E) Entraine une diminution de débit sanguin en distalité.

Q95. IAMI

L'Ischémie aigue du membre inferieur :

A) Est une interruption brutale du courant sanguin artériel du membre inferieur.
B) L'endartériectomie est le traitement chirurgical.
C) Son traitement médical est basé sur l'héparine.
D) Remonte à moins de 15 jours.
E) On peut la traiter par voie endovasculaire.

Q96. IAMI

La douleur lors d'une ischémie aigue du membre inférieur est :

A) De début brutal.
B) Rebelle aux antalgiques.
C) Soulagée par la palpation.
D) Soulagée par surélévation du membre.
E) Le mécanisme athéromateux est le plus fréquent.

Q97. AAA

Indications du traitement d'un anévrysme fusiforme de l'aorte abdominal sous rénal :

A) Diamètre à 7cm.
B) Anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal non compliqué de 6 cm de diamètre.
C) Anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal compliqué de 6 cm de diamètre.
D) Augmnentation de diamètre de 2,5 cm en 6 mois.
E) Anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal en pré rupture.

Q98. AAA

On peut traiter un anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal par :

A) Une voie chirurgicale.
B) Pontage extra anatomique.
C) Une voie endovasculaire.
D) Un stent nu.
E) Par une veine saphène interne inversée.

Q99. Varices des membres inférieurs

L'échodoppler en cas d'insuffisances veineuse chronique superficielle des membres inférieurs :

A) Est un examen paraclinique inutile.
B) Permet une étude de la continence valvulaire.
C) Permet le diagnostic d'un reflux pathologique.
D) Permet le diagnostic d'un reflux veineux profond.
E) Sera plus performant en cas d'injection du produit de contraste.

Q100. Varices des membres inférieurs

Les varices on peut les traiter par :

A) Une angioplastie par voie endoveineuse.
B) Un stripping comme traitement médical.
C) Des phlébectomies comme traitement chirugical.
D) La radiofréquence par voie endoveineuse.
E) Une sclérothérapie intra veineuse.

Q101. Varices des membres inférieurs

L'insuffisances veineuse chronique superficielle des membres inférieurs :

A) Est une Dilatation permanente des veines accompagnée d'altération de leur paroi et de leurs valvules.
B) L'incontinence signifie que le sang veineux circule vers la périphérie.
C) Dans laquelle un traitement endovasculaire est possible.
D) Dans laquelle les varices constituent la classe C3 de la classification CEAP.
E) Dans laquelle un ulcère peut constituer une complication.

Q102. AOMI

On peut traiter une AOMI par :

A) Une dilatation artérielle avec ballon.
B) Une angioplastie artérielle sans stent.
C) Un pontage artériel en fogarty.
D) Un pontage artériel en veine saphène interne.
E) Clopidogrel.

Q103. Chururgie valvulaire

Les patients porteurs de valves mécaniques :

A) Nécessitent un traitement anticoagulant pendant 3 mois.
B) Nécessitent une antibiothérapie à vie.
C) Ne nécessitent aucun traitement anticoagulant.
D) Nécessitent un traitement anticoagulant à vie.
E) Ne font jamais de complications.

Q104. Chururgie valvulaire

La surveillance des malades porteurs de valves biologiques :

A) Nécessite un contrôle mensuel de l'INR.
B) Nécessite un contrôle quotidien de l'INR.
C) Nécessite un contrôle annuel de l'INR.
D) Nécessite un contrôle de la NFS.
E) Ne nécessite aucun contrôle de l'INR après le 6ème mois post-opératoire si le rythme est sinusal.

Q105. Chirurgie coronaire

Le pontage coronaire :

A) Est indiqué en cas de sténose du tronc commun > 30%.
B) Est indiqué en cas d'atteinte tritronculaire avec des sténoses significatives.
C) Les greffons utilisés peuvent être artériels ou veineux.
D) Peut être réalisé sur un coeur battant.
E) Toutes les réponses sont justes.

Q106. Coarctation de l'aorte

Concernant la coarctation de l'aorte chez le nouveau-né :

A) Elle est souvent asymptomatique de découverte fortuite.
B) Elle est souvent mal tolérée.
C) C'est une urgence médico-chirurgicale.
D) L'échocardiographie transthoracique confirme le diagnostic.
E) Le traitement est exclusivement chirurgical.

Q107. Dissection aortique aigue

Selon la classification de Stanford :

A) La dissection aortique type A intéresse l'aorte ascendante.

B) La dissection aortique type A est limitée à l'aorte ascendante.
C) La dissection aortique type A ne touche pas l'aorte descendante.
D) La dissection aortique type B ne touche pas l'aorte ascendante.
E) La dissection aortique type B s'arrête au-dessus du diaphragme.

Q108. Dissection aortique aigue

Concernant le diagnostic de la dissection aigue de l'aorte :

A) Il est suspecté devant une douleur rétrosternale intense d'apparition brutale.
B) Une asymétrie tensionnelle entre les deux bras confirme le diagnostic.
C) L'ECG peut être normal.
D) L'angioscanner aortique confirme le diagnostic.
E) L'échocardiographie transthoracique permet de confirmer le diagnostic et préciser son type et son extension.

Q109. Dissection aortique aigue

La prise en charge médicale de la dissection aortique aigue comporte :

A) Un traitement antalgique.
B) Un traitement de l'HTA.
C) Un traitement anticoagulant.
D) Un traitement symptomatique d'une décompensation cardiaque associée.
E) Aucune réponse n'est juste.

Q110. Dissection aortique aigue

Chez les patients traités pour dissection aortique aigue :

A) Une surveillance spécialisée à vie est à vie n'est pas nécessaire.
B) Un angioscanner est réalisé avant la sortie, à 1 mois, 6 mois puis annuellement.
C) Un contrôle tensionnel est indispensable.
D) Il n' y a pas de risque de développer un anévrisme aortique.
E) Il y a un risque d'étendre la dissection.

DÉCEMBRE 2024 (RATTRAPAGE)

Q111. Insuffisance aortique

Citer les signes cliniques de sévérité de l'insuffisance aortique chronique.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q112. Rhumatisme articulaire aigu

Citer les critères diagnostiques du rhumatisme articulaire aigu.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q113. Infarctus du myocarde

Citez trois complications précoces et trois complications tardives de l'infarctus du myocarde.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q114. Syncope

Définissez la syncope et citez 4 étiologies de la syncope d'effort.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q115. IAMI

Définissez une ischémie aiguë du membre inférieur.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q116. AAA

Citez trois complications d'un anévrysme de l'aorte abdominale.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q117. Dissection aortique aigue

Concernant la dissection de l'aorte type A : donnez la définition et le diagnostic clinique et paraclinique.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

DÉCEMBRE 2024 (NORMALE)

Q118. Rétrecissement aortique

Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant cette auscultation cardiaque anormale ?

A) Insuffisance Aortique.

B) Rétrécissement Aortique.
C) Maladie Aortique.
D) Insuffisance Mitrale.
E) Insuffisance Pulmonaire.

Q119. Rétrecissement aortique

Quels sont les signes électriques habituellement retrouvés lors de cette valvulopathie ?

A) Un flutter auriculaire.
B) Une hypertrophie auriculaire droite.
C) Une hypertrophie ventriculaire gauche type systolique.
D) Un bloc de branche droit.

Q120. Rétrecissement aortique

Quel examen paraclinique vous permettra d'apprécier la sévérité de votre valvulopathie ?

A) Le cathétérisme cardiaque droit.
B) L'échocardiographie trans-thoracique.
C) Le scanner cardiaque.
D) La coronarographie.
E) La radiographie pulmonaire.

Q121. Insuffisance mitrale

Parmi les paramètres échocardiographiques suivants quels sont ceux qui permettent une quantification de votre valvulopathie ?

A) Le volume régurgitant (VR).
B) La PHT (pressure half time).
C) Le rayon de PISA.
D) La surface de l'orifice régurgitant (SOR).
E) Aucune des propositions.

Q122. Insuffisance mitrale

Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui signe que votre valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?

A) La SOR retrouvée est > 20 mm².
B) La SOR retrouvée est <40 mm².
C) La SOR retrouvée et entre 20 et 40 mm².
D) La SOR retrouvée est ? 40mm².
E) Aucune de ces propositions.

Q123. Rétrecissement aortique

Sur le compte rendu l'échographiste trouve une anomalie congénitale qui pourrait constituer l'étiologie de cette valvulopathie de quelle anomalie s'agit-il ?

A) Coarctation de l'Aorte.
B) Fente Mitrale.
C) Unicuspidie.
D) Bicuspidie.
E) Aucune des réponses.

Q124. Rétrecissement aortique

Quelle est l'étiologie la plus probable de cette valvulopathie chez cette patiente ?

A) Dégénérative.
B) Endocarditique.
C) Ischémique.
D) Médicamenteuse.
E) Rhumatismale.

Q125. Rétrecissement aortique

Si votre diagnostic clinique se confirme, Quelle est la seule proposition parmi ces propositions qui vous poussera à proposer une chirurgie à votre patiente même si elle est asymptomatique ?

A) Altération de la fonction systolique avec une FE?50%.
B) Sévérité de la valvulopathie à l'échocardiographie et un VG dilaté.
C) Augmentation des pressions de remplissage du Ventricule Gauche.
D) Râles crépitants à l'auscultation pulmonaire.
E) L'hypertension pulmonaire.

Q126. Rétrecissement aortique

Cette patiente est admise 6 mois plus tard pour syncope, dans son histoire naturelle, la valvulopathie dont souffre la patiente a désormais une survie moyenne de ?

A) Six ans.
B) Quatre ans.
C) Six mois.
D) Deux ans.
E) Deux mois.

Q127. Chirurgie valvulaire

Quel bilan d'opérabilité vous prescrirez à cette patiente ?

A) Une coronarographie.
B) Un groupage ABO- rhésus.
C) Un examen gynécologique complet.
D) Un examen ORL et Odontologique.
E) Un scanner Thoracique.

Q128. Rhumatisme articulaire aigu

A propos du rhumatisme articulaire aigu, quels sont parmi les critères suivants ceux qui sont jugés mineurs dans les critères diagnostiques de JONES modifiés.

A) La fièvre.
B) La chorée de Sydenham.
C) L'érythème marginé de Besnier.
D) Un Allongement de l'espace PR sur ECG.
E) La polyarthrite migratrice et fugace.

Q129. Insuffisance aortique

A propos de l'insuffisance Aortique aigue :

A) C'est une valvulopathie fuyante en systole.
B) C'est une valvulopathie fuyante en diastole.
C) Peut entrainer une dilatation du ventricule Gauche.
D) Peut entrainer une hypertrophie du ventricule gauche.
E) Peut entrainer une fermeture prématurée de la valve mitrale.

Q130. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie dilatée (CMD) :

A) Est définie par une dilatation ventriculaire droite avec ou sans dysfonction du VG.
B) Est définie par une altération de la fonction systolique uniquement.
C) Est définie par une dilatation ventriculaire avec dysfonction du VG.
D) Dans la CMD primitive la dilatation ventriculaire n'est pas expliquée par les conditions de charge.
E) La CMD peut se compliquer de mort subite.

Q131. Rétrecissement mitral

A propos du Rétrécissement Mitral :

A) Peut se compliquer d'insuffisance ventriculaire gauche.
B) Peut être traité par voie percutanée.
C) Entraine une surcharge volumétrique.
D) Donne lieu à un roulement diastolique de flint.
E) Est jugé sévère si la surface mitrale est < 2cm².

Q132. Thrombose & Embolie

Devant une suspicion d'embolie pulmonaire, chez un patient instable sur le plan hémodynamique, l'examen paraclinique de première intention à demander est :

A) L'angioIRM thoracique.
B) Les d-dimères par méthode ELISA.
C) L'angiographie pulmonaire.
D) L'échocardiographie transthoracique.
E) L'échographie doppler veineuse des membres inférieurs.

Q133. Hypertension artérielle

Le Diagnostic de l'hypertension artérielle systémique est posé, selon l'ESH 2018, au cabinet devant :

A) Une pression artérielle systolique PAS ? 135 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ? 85 mmHg.
B) Une pression artérielle systolique PAS ? 140 mmHg et une pression artérielle diastolique (PAD) ? 90 mmHg.
C) Une pression artérielle systolique isolée PAS ? 130 mmHg.
D) Une pression artérielle diastolique PAD ? 80 mmHg.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q134. Rétrecissement aortique

Le rétrécissement aortique est un obstacle systolique, il peut se manifester cliniquement par :

A) Une dyspnée d'effort.
B) La triade de Harzer.
C) Un angor d'effort.
D) Un éclat de B2 au foyer pulmonaire.
E) Une syncope ou une lipothymie.

Q135. Péricardites aigues

Au cours de la péricardite aiguë, la douleur thoracique est :

A) Exacerbée en position de décubitus dorsal et soulagée en antéflexion du tronc.
B) Exacerbée en antéflexion du tronc et soulagée en position de décubitus dorsal.
C) Exacerbée pendant l'effort et soulagée par le repos.
D) Soulagée par la prise de dérivés nitrés (douleur nitro-sensible).
E) Non soulagée par la prise de dérivés nitrés (douleur nitro-résistante).

Q136. Péricardites aigues

Parmi les complications de la péricardite aiguë, cochez les propositions correctes :
A) L'endocardite infectieuse.
B) La péricardite constrictive.
C) La myocardite.
D) La tamponnade.
E) la récidive.

Q137. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) :
A) Elle est définie par une épaisseur myocardique ? 15mmHg chez un patient hypertendu ;
B) Elle est obligatoirement obstructive ;
C) Elle peut se compliquer de mort subite ;
D) Elle se manifeste cliniquement dans sa forme obstructive par un souffle systolique ;
E) On peut retrouver un B4 télédiastolique comme bruit surajouté à l'auscultation.

Q138. Électrocardiogramme

Vous réalisez un ECG de repos chez un homme de 50 ans, admis pour douleur thoracique, dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s):
A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe une onde Q de nécrose en V1-V4.
C) Il existe une tachycardie ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une extrasystole.

Q139. Traitement de l'infarctus du myocarde

Le diagnostic d'un infarctus du myocarde antérieur a été retenu, quelles prises en charge est envisagée chez le patient :
A) Reperfusion par Angioplastie avec pose de stent (intervention coronaire percutanée) ;
B) Aucun traitement et le malade peut rentrer chez lui ;
C) Hospitalisation ;
D) Traitement antibiotique ;
E) Echocardiographie Transthoracique pour évaluer l'importance de l'infarctus.

Q140. Troubles du rythme cardiaque

Les troubles du rythme peuvent se manifester par :
A) Syncope ;
B) Lipothymie ;
C) Douleur thoracique ;
D) Dyspnée ;
E) Palpitations ;

Q141. Troubles de conduction

Parmi les étiologies des troubles de conductions :
A) IDM aigu;
B) Endocardite infectieuse;
C) Cause Métabolique;
D) BAV congénital;
E) Cause dégénérative ;

Q142. Syncope

La mortalité lors de la syncope est évaluée :
A) Entre 0 et 12% pour les syncopes d'origine cardiaque;
B) Entre 19 et 33% pour les syncopes d'origine non cardiaque;
C) Entre 19 et 33% pour les syncopes d'origine cardiaque;
D) A 6% pour les syncopes d'origine cardiaque;
E) Entre 19 et 33% pour les syncopes d'origine indéterminée;

Q143. Syncope

La syncope se définit par :
A) Perte de connaissance progressive ;
B) Précédée par des prodromes ;
C) Accompagnée constamment d'une crise polyurique;
D) Une récupération spontanée après la chute ;
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q144. Syncope

Parmi les causes des syncopes cardiaque d'effort :
A) Le rétrécissement aortique serré;
B) La bradycardie;
C) Le froid;
D) La tamponnade;
E) L'âge élevé.

Q145. Syncope

Dans l'Etude de Framingham :
A) Les patients inclus étaient tous jeunes ;
B) La fréquence des syncopes est de 3% ;
C) La prévalence des syncopes augmente avec l'âge ;
D) Le diabète favorise la survenue de syncope d'origine cardiaque ;
E) L'âge n'est pas un critère valide.

Q146. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :
A) Indolore ;
B) Invasif ;
C) Rapide ;
D) Nécessite une anesthésie ;
E) Couteux.

Q147. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications du syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST ?
A) La mort subite;
B) La dysfonction du VG à bas bruit;
C) L'infarctus du myocarde;
D) L'embolie pulmonaire;
E) L'angor stable.

Q148. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications rythmiques de l'infarctus du myocarde :
A) Le bloc auriculo ventriculaire ;
B) Les tachycardies ventriculaires ;
C) Le thrombus du ventricule gauche ;
D) La rupture septale ;
E) Crise d'asthme.

Q149. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation antéro-septale se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :
A) En D2-D3-AVF ;
B) De V1 à V4 ;
C) En D1-AVL ;
D) De V1 à V6 et En D2-D3-AVF ;
E) V7-V8-V9 ;

Q150. Coarctation de l'aorte

Parmi les étiologies susceptibles d'entrainer une cardiopathie congénitale, on note :
A) La rubéole congénitale;
B) Le tabac;
C) Les médicaments antiépileptiques ;
D) Le froid;
E) La prédisposition génétique;

Q151. Coarctation de l'aorte

Parmi les cardiopathies non cyanogènes :
A) Communication inter auriculaire ;
B) Communication interventriculaire ;
C) Canal artériel ;
D) Coarctation de l'aorte ;
E) Canal atrio ventriculaire.

Q152. Infarctus du myocarde

Précisez deux étiologies de l'infarctus du myocarde :
A) Athérosclérose coronaire.
B) Spasme coronaire.
C) Péricardite.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Hyperleucocytose.

Q153. AOMI

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?
A) Tabagisme ;
B) Hypertension artérielle ;
C) Diabète ;
D) Obésité ;
E) L'activité physique.

Q154. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus myocardique sont bien connus. deux propositions ci-dessous sont justes.

Lesquelles ?
A) Douleur à la palpation ;
B) De siège thoracique médian rétrosternal ;
C) Résistante à la trinitrine ;
D) Toujours à l'effort ;
E) De durée brève.

Q155. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :
A) Tracé parasité ;
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv ;
C) 6 dérivations de bases ;
D) 2 complexes par dérivation ;
E) Papier non millimétré.

Q156. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :
A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI ;
B) Présences de phénomènes immunologiques : nodosité d'Osler et/ou taches de Roth ;
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès ;
D) Auscultation cardiaque normale ;
E) Protéinurie positive.

Q157. Thrombose & Embolie

Parmi les molécules suivantes laquelle ou lesquelles sont des anticoagulants par voie orale :
A) Dabigatran ;
B) Rivaroxabon ;
C) Acenocoumarol (sintrom);
D) Ticagrelor ;
E) Tirofiban.

Q158. AOMI

Quels diagnostics évoquez-vous devant ce tableau clinique (patient 41 ans, tabac, nécrose 4ème orteil, abolition des pouls jambiers) ?
A) Une artérite stade 2 du membre inférieur droit.
B) Une artérite stade 4 du membre inférieur droit.
C) Gangrène du diabétique.
D) Une artérite stade 3 du membre inférieur droit.
E) Une artérite INFLAMMATOIRE.

Q159. AOMI

Quel examen radiologique demandez-vous en première intention ?
A) Une longueur IRM.
B) Une artériographie des membres inférieurs.
C) Un angioscanner de l'aorte et des membres inférieurs.
D) Une scintigraphie artérielle.
E) Une radiologie standard de l'orteil.

Q160. AOMI

Quel diagnostic retenez vous devant ses données (occlusion iliaque droite sans calcification chez un jeune fumeur) ?
A) Une artériopathie athéromateuse.
B) Une artériopathie inflammatoire.
C) Une artériopathie infectieuse.
D) Une artériopathie tabagique.
E) Aucune réponse juste.

Q161. AOMI

Quel bilan biologique vous demandez pour confirmer votre diagnostic ?
A) CRP.
B) VS.
C) Créatinine.
D) Troponine.
E) ALAT ASAT.

Q162. AOMI

Au cours de l'artérite oblitérante des membres inférieurs :
A) L'origine inflammatoire est la plus fréquente.
B) L'origine athéromateuse est la plus fréquente.
C) On peut revasculariser par chirurgie.
D) On peut revasculariser par voie endovasculaire.
E) La prescription de l'aspirine au cas d'origine athéromateuse est bénéfique.

Q163. AOMI

En cas de nécrose d'un orteil au cours d'une artérite oblitérante des membres inférieurs :

A) L'amputation est obligatoire.
B) On peut garder l'orteil en cas de revascularisation pour une régénération et cicatrisation.
C) Une revascularisation est obligatoire pour assurer la cicatrisation du moignon après l'amputation.
D) Une cicatrisation est obtenue après une amputation sans besoin de revasculariser en cas d'occlusion artérielle Ilio fémorale.
E) La nécrose est irréversible.

Q164. AOMI

Index de pression systolique : IPS

A) Est un moyen clinique pour dépister les varices des membres inférieurs.
B) C'est le résultat de la division de la pression artérielle systolique de la cheville sur la pression artérielle systolique humérale.
C) C'est le résultat de la division de la pression artérielle systolique humérale sur la pression artérielle systolique de la cheville.
D) Un IPS inférieur à 0,3 est en faveur d'une artérite sévère.
E) Un IPS inférieur à 0,3 est en faveur d'une insuffisance veineuse superficielle sévère.

Q165. AOMI

L'Artériographie :

A) Est un examen non invasif.
B) L'injection du produit de contraste se fait par une voie veineuse de gros calibre.
C) Permet le diagnostic topographique précis des lésions artérielles.
D) Permet l'évaluation de la qualité du lit d'aval.
E) Lors du diagnostic d'une lésion artérielle par l'artériographie dans le cadre d'AOMI, on peut traiter cette lésion par les procédures endovasculaires en même temps.

Q166. AOMI

Le pied diabétique :

A) Est la conjonction de complications Neurologiques, Infectieuses avec ou sans composante Ischémique.
B) Est la conséquence de la microangiopathie et la macroangiopathie du diabétique.
C) En cas d'artérite chez un diabétique, les artères les plus touchées sont les artères fémorales profondes et les axes de jambes.
D) On appelle un pied déformé par l'ostéoarthropathie nerveuse diabétique : un pied de Rachot.
E) L'amputation est inutile en cas de nécrose et gangrène du pied et de la jambe chez un diabétique.

Q167. AOMI

L'Artérite juvénile de Leo burger :

A) Est une artérite du sujet âgé.
B) Est une artérite athéromateuse du sujet jeune.
C) Caractérisée par une évolution par poussées et rémissions.
D) Ne touche pas les artères des membres supérieurs.
E) Ne se traduit par aucune lésion artérielle à l'artériographie.

Q168. IAMI

Le traitement de l'ischémie aigue des membres inférieurs :

A) Est une urgence médico chirurgicale.
B) Basé sur la thrombo-embolectomie à la sonde de fogarty.
C) Possible par voie endovasculaire pour certains cas.
D) Nécessite un abord chirurgical en cas d'embolectomie.
E) Nécessite un abord chirurgical en cas de thrombo aspiration.

Q169. Varices des membres inférieurs

L'Ulcère variqueux :

A) Est d'évolution aigue.
B) Est superficiel.
C) Est Très douloureux.
D) Peut être accompagnée d'une dermite ocre ou d'une atrophie cutanée blanche.
E) Toutes les réponses sont justes.

Q170. Coarctation de l'aorte

Concernant la Coarctation de l'aorte chez de l'enfant :

A) La découverte peut être fortuite à l'occasion d'une HTA.
B) Est souvent mal tolérée.
C) Peut se manifester par une dyspnée d'effort.
D) Peut se compliquer d'AVC hémorragique.
E) Le pouls radial est aboli et les pouls fémoraux sont diminués.

Q171. Chirurgie valvulaire

Parmi les facteurs suivants, quel est celui qui influence le plus la décision de choisir une prothèse biologique plutôt qu'une prothèse mécanique pour le remplacement de la valve aortique ?

A) L'âge du patient.
B) La présence d'antécédents d'AVC.
C) Le risque de thrombose de la prothèse mécanique.
D) La non-observance du traitement anticoagulant.
E) Le coût élevé du traitement anticoagulant à vie.

Q172. Chirurgie valvulaire

Chez un patient porteur de valve mécanique mitrale :

A) L'INR doit être entre 2 et 3.
B) Des épistaxis, gingivorragies doivent faire suspecter un surdosage aux AVK.
C) L'antibioprophylaxie est recommandée lors des soins dentaires.
D) Une fièvre prolongée doit faire suspecter une endocardite.
E) L'absence de surveillance de l'INR expose au risque de thrombose de la valve.

Q173. Chirurgie coronaire

Le pontage coronaire :

A) Est indiqué en cas de sténose du tronc commun >50%.
B) Est indiqué en cas d'atteinte tritronculaire avec des sténoses > 70%.
C) Utilise uniquement des greffons artériels.
D) Nécessite toujours une pompe de circulation extracorporelle et un coeur arrêté.
E) Aucune réponse n'est juste.

Q174. Dissection aortique aigue

Concernant la dissection de l'aorte de type B :

A) Le pronostic à court terme est plus favorable que celui des dissections de type A.
B) Le traitement est médical à base d'hypotenseur et de bradycardisant en espérant la thrombose du faux chenal.
C) Elle peut se compliquer d'AVC.
D) Le traitement chirurgical n'est de mise qu'en cas de complications majeures.
E) Elle peut se compliquer d'une ischémie aiguë des membres inférieurs.

Q175. Dissection aortique aigue

La dissection de l'aorte type A est :

A) Touche l'aorte ascendante quelque soit son étendue.
B) Est plus grave et nécessite une chirurgie immédiate.
C) Est dûe le plus souvent à une cause traumatique.
D) Se manifeste souvent par une douleur rétro-sternale irradiant vers le cou et l'épaule.
E) Peut se compliquer de tamponnade.

Q176. Dissection aortique aigue

Parmi les examens suivants, lequel est considéré comme le plus rapide et le plus efficace pour diagnostiquer une dissection aortique en urgence ?

A) L'échocardiographie transthoracique.
B) La radiographie thoracique.
C) La tomodensitométrie (TDM) avec injection de produit de contraste.
D) L'IRM cardiaque.
E) l'échocardiographie transoesophagienne.

Q177. Dissection aortique aigue

La surveillance d'une dissection aortique de type A traitée par remplacement de l'aorte ascendante par une prothèse nécessite une attention particulière aux complications suivantes :

A) Insuffisance rénale aiguë.
B) Dissection secondaire dans l'aorte descendante.
C) Embolie pulmonaire.
D) Insuffisance mitrale aiguë.
E) AVC ischémique.

JUIN 2024

Q178. Rétrecissement mitral

Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant cette auscultation cardiaque anormale ?

A) Insuffisance Aortique.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Mitrale.
D) Insuffisance Mitrale.
E) Insuffisance Pulmonaire.

Q179. Rétrecissement mitral

Quels sont les signes électriques habituellement retrouvés chez les porteurs de cette valvulopathie ?

A) Une fibrillation auriculaire.
B) Une hypertrophie auriculaire gauche.
C) Une hypertrophie ventriculaire gauche type systolique.
D) Un bloc de branche gauche.
E) Un bloc auriculo-ventriculaire.

Q180. Rétrecissement mitral

Quel examen paraclinique vous permettra d'apprécier la sévérité de votre valvulopathie ?

A) Le cathétérisme cardiaque droit.

B) L'échocardiographie trans-thoracique.
C) Le scanner cardiaque.
D) La coronarographie.
E) La radiographie pulmonaire.

Q181. Rétrecissement mitral

Parmi les paramètres échocardiographiques suivants quels sont ceux qui permettent une quantification de votre valvulopathie ?

A) Le volume régurgitant (VR).
B) Le gradient mitral.
C) Le rayon de PISA.
D) La surface de l'orifice régurgitant (SOR).
E) Aucune des propositions.

Q182. Rétrecissement mitral

Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui signe que votre valvulopathie est sévère échographiquement ?

A) Le gradient mitral retrouvé est > 5 mmHg.
B) Le gradient mitral retrouvé est > 12 mmHg.
C) La SOR retrouvée est entre 20 et 40 mm².
D) La SOR retrouvée est ? 40mm².
E) Aucune de ces propositions.

Q183. Rétrecissement mitral

Quelle est l'étiologie la plus probable de cette valvulopathie chez cette patiente ?

A) Dégénérative.
B) Endocarditique.
C) Ischémique.
D) Médicamenteuse.
E) Rhumatismale.

Q184. Rétrecissement mitral

Si la sévérité de votre valvulopathie se confirme, Quelle est la seule proposition parmi ces propositions qui vous poussera à proposer une chirurgie à votre patiente en première intention ?

A) Altération de la fonction systolique avec une FE < 30%.
B) Sévérité de la valvulopathie à l'échocardiographie et un VG dilaté.
C) Augmentation des pressions de remplissage du Ventricule Gauche.
D) Râles crépitants à l'auscultation pulmonaire.
E) L'existence d'une valvulopathie aortique sévère.

Q185. Rétrecissement mitral

Cette patiente est admise 6 mois plus tard dans un tableau d'hémiplégie gauche, de quelle complication s'agit-il compte tenu de l'histoire clinique de cette patiente ?

A) Un Abcès cérébral.
B) Une Endocardite infectieuse.
C) Un Accident vasculaire cérébral ischémique.
D) Une chorée de Sydenham.
E) Une hémorragie intracérébrale.

Q186. Rétrecissement mitral

Quel bilan d'opérabilité vous prescrirez à cette patiente ?

A) Une coronarographie.
B) Un groupage ABO- rhésus.
C) Un examen gynécologique complet.
D) Un examen ORL et Odontologique.
E) Un scanner Thoracique.

Q187. Rétrecissement mitral

Compte tenu de l'âge jeune de votre patiente et de l'état de sa valve, il a été décidé chez elle après discussion médico-chirurgicale de tenter un traitement percutané de la valve malade, quelles sont les contre-indications de cette technique ?

A) Le bloc auriculo-ventriculaire.
B) La grossesse.
C) Le Thrombus intra auriculaire gauche.
D) Un trouble de l'hémostase.
E) Des valves massivement calcifiées.

Q188. Rhumatisme articulaire aigu

A propos du rhumatisme articulaire aigu, quels sont parmi les critères suivants ceux qui sont jugés majeurs dans les critères diagnostiques de JONES modifiés.

A) La fièvre.
B) La chorée de Sydenham.
C) L'érythème marginé de Besnier.
D) Un Allongement de l'espace PR sur ECG.
E) La polyarthrite migratrice et fugace.

Q189. Insuffisance aortique

A propos de l'insuffisance Aortique chronique :

A) C'est une valvulopathie fuyante en systolo-diastole.
B) C'est une valvulopathie fuyante en diastole.
C) Elle est jugée sévère cliniquement en présence d'un élargissement de la différentielle de la pression artérielle.
D) Peut entrainer une hypertrophie du ventricule gauche.
E) Elle est Jugée sévère à l'échocardiographie si le VR ? 30ml.

Q190. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) :

A) Est définie par une augmentation de l'épaisseur myocardique chez un patient hypertendu.
B) Est définie par une augmentation de l'épaisseur myocardique abstraction faite des conditions de charge.
C) Est caractérisée par une fonction systolique supranormale.
D) Est caractérisée par une fonction diastolique toujours normale.
E) Elle peut se compliquer de mort subite.

Q191. Insuffisance mitrale

A propos de l'insuffisance mitrale :

A) Peut se compliquer d'insuffisance ventriculaire gauche.
B) Peut être traité par voie percutanée.
C) Entraine une surcharge barométrique.
D) Donne lieu à un souffle diastolique continue.
E) Est jugé sévère si la SOR (surface de l'orifice régurgitant) est ? 40 mm^2.

Q192. Thrombose & Embolie

Devant une suspicion d'embolie pulmonaire, chez un patient stable sur le plan hémodynamique, avec une probabilité clinique faible, l'examen paraclinique de première intention à demander est :

A) L'angioscanner thoracique.
B) Les d-dimères par méthode ELISA.
C) L'angiographie pulmonaire.
D) L'échocardiographie transthoracique.
E) L'échographie doppler veineuse des membres inférieurs.

Q193. Hypertension artérielle

Le Diagnostic de l'hypertension artérielle systémique est posé, selon l'ESH 2018, à domicile devant :

A) Une pression artérielle systolique PAS ? 135 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ? 85 mmHg.
B) Une pression artérielle systolique PAS ? 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ? 90 mmHg.
C) Une pression artérielle systolique isolée PAS ? 130 mmHg.
D) Une pression artérielle diastolique PAD ? 80 mmHg.
E) Une pression artérielle Moyenne PAM ? 90 mmHg.

Q194. Rétrecissement mitral

Le rétrécissement mitral est un obstacle diastolique, il se manifeste cliniquement par :

A) La Dyspnée d'effort.
B) La triade de Durozier à l'auscultation.
C) Un roulement systolique.
D) Un éclat de B2 au foyer pulmonaire.
E) Un frémissement cataire au niveau de la pointe à la palpation.

Q195. Péricardites aigues

La péricardite aigue est une inflammation du péricarde, elle est diagnostiquée devant la présence de 2 des critères suivants sauf un lequel :

A) Epanchement péricardique.
B) Douleur thoracique péricardique.
C) Turgescence spontanée des veines jugulaires.
D) Nouveau sus décalage ST diffus ou sous décalage PQ à l'ECG.
E) Frottement péricardique.

Q196. Hypertension pulmonaire

A propos de l'Hypertension pulmonaire (HTP) :

A) Est définie hémodynamiquement par une PAPm > 25mmHg au repos mesurée par échocardiographie.
B) Est définie hémodynamiquement par une PAPm > 20mmHg au repos mesurée par échocardiographie.
C) Est définie hémodynamiquement par une PAPm > 20mmHg au repos mesurée par cathétérisme droit.
D) Est définie hémodynamiquement par une PAPm ? 20mmHg au repos mesurée par cathétérisme droit.
E) Est définie hémodynamiquement par une PAPm > 25mmHg au repos mesurée par cathétérisme droit.

Q197. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie dilatée (CMD) :

A) Est définie par une dilatation ventriculaire avec ou sans dysfonction du VG.
B) Est définie par une altération de la fonction systolique uniquement.
C) Est définie par une dilatation ventriculaire avec dysfonction du VG en présence d'une coronaropathie.
D) Dans la CMD la dysfonction systolique peut être biventriculaire.
E) La CMD peut se compliquer de choc cardiogénique.

Q198. Électrocardiogramme

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s):

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auricule-ventriculaire de premier degré.
C) Il existe une tachycardie ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une extrasystole.

Q199. Électrocardiogramme

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s):

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auricule-ventriculaire de 3eme degré.
C) Il existe une extrasystole ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une onde Q de nécrose.

Q200. Infarctus du myocarde

L'attitude médicale initiale à réaliser est :

A) Examiner et évaluer l'état hémodynamique.
B) Injecter un béta bloquant.
C) Adresser pour revascularisation en salle de cathétérisme cardiaque.
D) Faire une échographie cardiaque.
E) Surveiller sans rien faire.

Q201. Traitement de l'infarctus du myocarde

Le diagnostic d'un infarctus du myocarde antérieur consommé a été retenu, quelles prises en charge sont envisagées chez le patient :

A) Angioplastie avec pose de stent (intervention coronaire percutanée).
B) Sonde de stimulation provisoire.
C) Thrombolyse.
D) Traitement anti thrombotique.
E) Traitement anticoagulant.

Q202. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance progressive.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une crise polyurique.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q203. Syncope

Dans l'étude de Framingham :

A) Les patients inclus étaient tous jeunes.
B) La fréquence des syncopes est de 3%.
C) La prévalence des syncopes augmente avec l'âge.
D) Le diabète favorise la survenue de syncope d'origine cardiaque.
E) L'âge n'est pas un critère valide.

Q204. Électrocardiogramme

L'ECG d'effort (épreuve d'effort) est positif si :

A) Survenue de douleur thoracique pendant l'exercice.
B) Sous décalage du segment ST.
C) Sus décalage du segment ST.
D) Modifications non significatives de l'onde T.
E) Sous décalage de l'espace PQ.

Q205. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter auriculaire :

A) Se définit par une disparition de l'onde P remplacée par l'onde F.
B) Se complique d'un AVC.
C) Est une micro-réentrée.
D) Est une macro-réentrée.
E) Se complique d'insuffisance cardiaque.

Q206. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :

A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q207. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?

A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q208. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications rythmiques de l'infarctus du myocarde ?

A) Le bloc auriculo ventriculaire.
B) Les tachycardies ventriculaires.
C) Le thrombus du ventricule gauche.
D) La rupture septale.
E) Crise d'asthme.

Q209. Coarctation de l'aorte

Parmi les étiologies susceptibles d'entrainer une cardiopathie congénitale, on note :

A) La rubéole congénitale.
B) Le tabac.
C) Les médicaments antiépileptiques.
D) Le froid.
E) La prédisposition génétique.

Q210. Infarctus du myocarde

Précisez deux étiologies de l'infarctus du myocarde :

A) Athérosclérose coronaire.
B) Spasme coronaire.
C) Dissection aortique.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Hyperleucocytose.

Q211. Infarctus du myocarde

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?

A) Tabagisme.
B) Hypertension artérielle.
C) Diabète.
D) Rétrécissement mitral.
E) L'activité physique.

Q212. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus myocardique sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est juste. Laquelle ?

A) Douleur à la palpation.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) Sensible à la trinitrine.
D) Toujours à l'effort.
E) De durée brève.

Q213. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 6 dérivations de bases.
D) 5 complexes par dérivation.
E) électrodes non inversés.

Q214. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries susceptibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q215. Syncope

Parmi les étiologies d'une syncope d'origine cardiaque :

A) Le rétrécissement aortique.
B) La tachycardie sinusale.
C) Le bloc auriculo ventriculaire complet.
D) L'origine vaso-vagale.
E) Tachycardie ventriculaire.

Q216. Traitement de l'infarctus du myocarde

L'acide acétylsalicylique est :

A) Un inhibiteur réversible de la cyclo-oxygénase 2 (Cox2).
B) Un inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) Actif pendant une durée de 21 jours.
D) Prescrit à une dose de 75-300 mg pour ses effets contre l'agrégation plaquettaire.
E) Prescrit dans l'infarctus du myocarde.

Q217. Troubles du rythme cardiaque

Parmi les molécules suivantes laquelle ou lesquelles sont des anticoagulants par voie orale :

A) Dabigatran.
B) Rivaroxaban.
C) Acenocoumarol (sintrom).
D) Ticagrelor.
E) Tirofiban.

Q218. AOMI

Les Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs : AOMI

A) Une sténose signifie une réduction de la lumière artérielle.
B) Il s'agit d'une atteinte non obstructive des artères destinées aux membres inférieurs.
C) Le mécanisme athéromateux qui est le plus fréquent.
D) Une origine inflammatoire n'est pas possible.
E) Son diagnostic est un marqueur de risque cardio vasculaire.

Q219. Traumatisme artériel des membres

Les éléments en faveur d'une lésion artérielle lors d'un traumatisme d'un membre sont :

A) Un syndrome inflammatoire.
B) La présence d'un Thrill à la palpation.
C) Une froideur du membre.
D) Un syndrome ischémique.
E) L'Extravasation du produit de contraste à l'angioscanner.

Q220. IAMI

L'ischémie aigue du membre inferieur :

A) Est une interruption brutale du courant sanguin veineux du membre inferieur.
B) L'embolectomie est le traitement chirurgical.
C) Son traitement médical est basé sur l'aspirine.
D) Remonte à plus de 30 jours.
E) Son traitement médical est basé sur l'héparine.

Q221. IAMI

La douleur lors d'une ischémie aigue du membre inférieur est :

A) De début progressif.
B) Calmée facilement par les antalgiques.
C) Exagérée par la palpation.
D) Une abolition des pouls en aval de l'occlusion et possible.
E) Le mécanisme embolique est le plus fréquent.

Q222. AAA

Indications du traitement d'un anévrysme fusiforme de l'aorte abdominale sous rénal :

A) Diamètre à 4cm.
B) Anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal compliqué.
C) Diamètre supérieur à 5cm.
D) Augmentation de diamètre de 2,5cm en 1 an.
E) Anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal en pré rupture.

Q223. AAA

On peut traiter un anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal par :

A) Une prothèse chirurgicale en dacron.
B) Une endoprothèse.
C) Une voie endovasculaire.
D) Une sonde de fogarty.
E) Mise à plat greffe chirurgicale.

Q224. AOMI

La Classification de Leriche et Fontaine :

A) Est une classification pour les Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs.
B) Le stade (III) correspond à des douleurs de décubitus.
C) Le stade (III) signifie une ischémie de repos.
D) On peut trouver un ulcère de la jambe dans le stade (IV).
E) On peut trouver une gangrène sèche du gros orteil dans le stade (IV).

Q225. AOMI

L'échodoppler artériel de l'aorte et des membres inférieurs :

A) Est un examen paraclinique utile dans les AOMI.
B) Permet une étude de la paroi des artères.
C) Permet le diagnostic d'une sténose artérielle à 90%.
D) Permet le diagnostic d'une occlusion artérielle.
E) Peut évaluer La courbe des vitesses d'écoulement artériel en aval d'une lésion artérielle sévère.

Q226. Varices des membres inférieurs

Les varices on peut les traiter par :

A) Une angioplastie par voie endoveineuse.
B) Un stripping comme traitement médical.
C) Des phlébectomies comme traitement chirurgical.
D) La radiofréquence par voie endoveineuse.
E) Une sclérothérapie intra veineuse.

Q227. Varices des membres inférieurs

L'insuffisances veineuse chronique superficielle des membres inférieurs :

A) Est une Dilatation permanente des veines accompagnée d'altération de leur paroi et de leurs valvules.
B) L'incontinence signifie que le sang veineux circule à contre-courant.
C) Dans laquelle la contention est la base du traitement.
D) Dans laquelle les varices constituent la classe C2 de la classification CEAP.
E) Dans laquelle l'echodoppler veineux peut objectiver un reflux.

Q228. AOMI

On traite une AOMI par :

A) Une dilatation artérielle sans stent.
B) Une angioplastie artérielle avec pose d'un stent.
C) Un pontage artériel en prothèse.
D) Un pontage artériel en veine.
E) Aspirine.

Q229. AOMI

Le pied diabétique :

A) Est la conséquence de la microangiopathie et la macroangiopathie du diabétique.
B) En cas d'artérite chez un diabétique, les artères les plus touchées sont les artères fémorales profondes et les axes de jambes.
C) Est la conjonction de complications Neurologiques, Infectieuses avec ou sans lésion artérielle ischémique.
D) On appelle un pied déformé par l'ostéoarthropathie nerveuse diabétique : un pied bot.
E) Toutes les réponses sont justes.

Q230. PAC : TECHNIQUES CHIRURGICALES

Le pontage coronaire est une chirurgie qui :

A) Nécessite souvent une Circulation extra corporelle.
B) Consiste à dilater les sténoses coronaires.
C) Est indiquée en cas de lésions tritronculaires chez le patient diabétique.
D) Utilise seulement des greffons artériels.
E) Qui peut se compliquer de médiastinite.

Q231. Coarctation de l'aorte

Concernant la coarctation de l'aorte chez l'enfant, quelles sont les propositions exactes ?

A) Elle est souvent mal tolérée.
B) Elle est souvent asymptomatique.
C) Le pouls radial est diminué ou aboli.
D) Le traitement est chirurgical.
E) Il y a un gradient tensionnel entre les membres supérieurs et inférieurs.

Q232. Chirurgie valvulaire

Mme K. âgée de 35 ans est porteuse d'une valve mécanique mitrale à double ailettes implantée pour maladie mitrale. Quelles sont les propositions exactes ?

A) Un traitement anticoagulant par antivitamine K est nécessaire à vie.
B) Un contrôle mensuel de l'INR est obligatoire.
C) L'INR cible est entre 2 et 3,5.
D) La valve expose à un risque thromboembolique élevé.
E) L'antibioprophylaxie en cas d'extraction dentaire n'est pas toujours indiquée.

Q233. Dissection aortique aigue

Concernant la dissection de l'aorte de type B, quelles sont les propositions exactes ?

A) La dissection concerne uniquement la crosse et l'aorte descendante.
B) Elle peut se compliquer d'insuffisance rénale aiguë.
C) Elle peut se compliquer d'ischémie des membres inférieurs.
D) Elle peut se compliquer de tamponnade.
E) Le traitement endovasculaire peut être indiqué en cas de malperfusion intestinale.

Q234. Dissection aortique aigue

Quel diagnostic redoutez vous ?
A) IDM.
B) Embolie pulmonaire.
C) Tamponnade.
D) Dissection aortique aiguë.
E) Coarctation de l'aorte.

Q235. Dissection aortique aigue

Quels sont les deux examens paracliniques que vous demandez en urgence :
A) Test à la trinitrine.
B) Rx du thorax.
C) Angioscanner de l'aorte.
D) D-Dimeres.
E) Echocardiographie.

Q236. Dissection aortique aigue

En attente de confirmation du diagnostic que proposez-vous en urgence ?
A) HBPM à dose préventive.
B) Soulager la douleur par des morphiniques.
C) Contrôle de la pression artérielle (PA systolique entre 100-120 mmHg).
D) Contrôle de la fréquence cardiaque par des bêtabloquants.
E) Remplissage vasculaire par des solutés salés.

Q237. Dissection aortique aigue

Brutalement le patient présente une douleur abdominale intense avec vomissements. Quelle complication craignez vous ?
A) IDM inférieur.
B) Ischémie mésentérique.
C) Perforation d'ulcère gastrique.
D) Occlusion intestinale.
E) Aucune réponse n'est juste.

2024

Q238. Infarctus du myocarde

Physiopathologie et complications de l'infarctus de myocarde.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q239. Rhumatisme articulaire aigu

Traitement de la cardite rhumatismale.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q240. AOMI

AOMI : diagnostic et traitement.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q241. Dissection aortique aigue

Dissection aortique : diagnostic et traitement.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

EXCEPTIONNEL 2024

Q242. Rétrecissement mitral

Rétrécissement mitral : diagnostic clinique et complications.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q243. Endocardite infectieuse

Diagnostic clinique et paraclinique de l'endocardite infectieuse.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q244. AAA

Citer 3 indications opératoires de l'anévrysme de l'aorte abdominale sous-rénal.
A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q245. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte : définissez-la, donnez les circonstances de découverte, les données de l'examen physique et 3 complications possibles si elle n'est pas prise en charge.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

JUIN 2023 (RATTRAPAGE)

Q246. Troubles du rythme cardiaque

Quelle (s) anomalie (es) relevez-vous à partir de l'ECG de cette patiente ?

A) Un flutter atrial.
B) Une Hypertrophie ventriculaire droite.
C) Une hypertrophie ventriculaire gauche.
D) Un sus décalage typique du segment ST dans le territoire Inférieur.
E) Une fibrillation atriale.

Q247. Insuffisance cardiaque de l'adulte

A quelle (s) anomalie (es) vous vous attendez sur la radiographie thoracique de cette patiente compte tenu de la description clinique ?

A) Une cardiomégalie importante.
B) Un élargissement médiastinal.
C) Des opacités floconneuses en ailes de papillon.
D) Des calcifications mitrales.
E) Des lignes de Kerley type B.

Q248. Hypertension artérielle

Compte tenu de la présentation clinique et des chiffres tensionnels élevés vous êtes devant ?

A) Une HTA maligne.
B) Une poussée hypertensive.
C) Une urgence hypertensive.
D) Une simple HTA blouse blanche.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q249. Rétrecissement aortique

L'auscultation au foyer aortique vous oriente vers quelle valvulopathie ?

A) Rétrécissement pulmonaire.
B) Rétrécissement mitral.
C) Insuffisance mitrale.
D) Insuffisance Aortique.
E) Aucune des réponses ci-dessus.

Q250. Rétrecissement aortique

Quel examen paraclinique permet de diagnostiquer cette valvulopathie ?

A) L'électrocardiogramme.
B) La radiographie thoracique.
C) La coronarographie.
D) L'Echocardiographie transthoracique.
E) Aucune de ces propositions.

Q251. Rétrecissement aortique

Quel (s) signe (s) vous oriente (ent) vers la sévérité de cette valvulopathie ?

A) Un élargissement de la différentielle.
B) Le pistol shot.
C) Le roulement de Flint.
D) L'abolition de B2 au foyer Aortique.
E) L'éclat de B1 au foyer pulmonaire.

Q252. Rétrecissement aortique

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui signent que votre valvulopathie est sévère échographiquement ?

A) Une surface valvulaire de < 2cm².
B) Une Surface valvulaire < 1cm².
C) Un gradient moyen > 12mmHg.
D) Un gradient moyen > 40mmHg.
E) Une présence de calcifications importantes sur la valve.

Q253. Rétrecissement aortique

Si la valvulopathie dont souffre votre malade est sévère, elle l'exposerait à des complications, lesquelles ?

A) L'insuffisance ventriculaire gauche.
B) Les saignements digestifs.
C) L'insuffisance tricuspide.
D) L'endocardite infectieuse.
E) La mort subite.

Q254. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quelles sont les médicaments à instaurer chez votre patiente pour améliorer son tableau clinique ?

A) Un traitement médicamenteux à base de bétabloquants.
B) Un traitement médicamenteux à base de dérivés nitrés.
C) Un traitement Chirurgical en urgence.
D) Un traitement par Inhibiteurs calciques pour faire baisser les chiffres tensionnels.
E) Un traitement à base de diurétiques de l'anse de Henlé.

Q255. Chirurgie valvulaire

Si la sévérité de la valvulopathie dont souffre la patiente se confirme quelles sont les options thérapeutiques à lui proposer ?

A) Remplacement valvulaire chirurgical par bioprothèse.
B) Remplacement valvulaire chirurgical par prothèse mécanique.
C) Valvuloplastie au ballon.
D) Remplacement valvulaire percutané type TAVI.
E) Abstention thérapeutique.

Q256. Rhumatisme articulaire aigu

Le Rhumatisme articulaire aigue est :

A) Une infection due à un streptocoque béta hémolytique du groupe B.
B) Une infection due à un streptocoque béta hémolytique du groupe A.
C) Une réaction inflammatoire suppurative et auto-immune tardive.
D) Une affection qui peut être responsable de séquelles neurologiques définitives.
E) D'aucune de ces propositions.

Q257. Rhumatisme articulaire aigu

Le traitement de la cardite rhumatismale sévère est basé sur :

A) L'utilisation de 600000 UI de benzathine pénicilline chez l'enfant de < 30 Kg de poids.
B) La prescription du repos au lit.
C) L'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) pendant 15 jours.
D) L'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) pendant 15 jours.
E) L'utilisation de la pénicilline V à raison de 2 millions d'UI en intra veineux.

Q258. Insuffisance aortique

Quelles sont parmi les propositions suivantes, les caractéristiques auscultatoires du souffle de l'insuffisance aortique ?

A) Il s'agit d'un souffle systolo-diastolique.
B) Est toujours précédé par un claquement méso-systolique.
C) Est toujours accompagné par un roulement diastolique de Flint.
D) Est maximal immédiatement après B2.
E) Est doux et aspiratif.

Q259. Rétrecissement mitral

Les diagnostics différentiels du rétrécissement mitral sont :

A) Le rétrécissement aortique.
B) La coarctation de l'aorte.
C) Le rétrécissement pulmonaire.
D) Le myxome de l'oreillette gauche.
E) Le roulement diastolique de Flint.

Q260. Insuffisance mitrale

A propos de l'insuffisance mitrale aigue :

A) Est toujours symptomatique.
B) Ne s'accompagne jamais d'une augmentation des pressions télédiastoliques du ventricule gauche.
C) L'ECG montre toujours une hypertrophie ventriculaire type diastolique.
D) Une Surface de l'orifice régurgitant (SOR) ? 10mm² signe la sévérité.
E) Peut-être causée par une fièvre.

Q261. Thrombose & Embolie

Une patiente de 67 ans suivie pour un cancer du sein se présente aux urgences pour une jambe rouge douloureuse, vous évoquez chez elle une phlébite surale quels sont les éléments en faveur de ce diagnostic ?

A) L'âge de la patiente est un facteur de risque majeur.
B) Le cancer est un facteur de risque majeur.
C) L'existence d'un signe d'une douleur à la dorsiflexion de la jambe.
D) Le caractère bilatéral de la présentation clinique.
E) Un dosage des D-dimères à 400µg/l.

Q262. Péricardites chroniques constrictives

A propos de la péricardite chronique constrictive :

A) C'est une gêne à l'expansion systolique du coeur.
B) C'est une gêne à l'expansion diastolique du coeur.
C) L'est une gêne à l'expansion systolo-diastolique du coeur.
D) C'est une asystolie.
E) Son principal diagnostic différentiel est la cardiomyopathie restrictive.

Q263. Cardiomyopathie dilatée

Les principales complications des cardiomyopathies dilatées (CMD) sont :

A) L'endocardite infectieuse.
B) Les troubles de rythme ventriculaire.
C) Le Choc hémorragique.
D) La mort subite.
E) Les accidents thromboemboliques.

Q264. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quels sont les symptômes typiques de l'insuffisance cardiaque (IC) parmi les symptômes suivants :

A) La toux nocturne.
B) Les palpitations.
C) La dyspnée paroxystique nocturne.
D) L'orthopnée.
E) Aucune de ces propositions.

Q265. Hypertension pulmonaire

L'Hypertension pulmonaire (HTP) est définie hémodynamiquement par une PAPm > 20mmHg au repos elle peut se manifester cliniquement par :

A) Une Dysphonie.
B) Une Dyspnée d'effort.
C) Une Hémoptysie.
D) Une Syncope.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q266. Électrocardiogramme

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte (s) ?

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré.
C) Il existe une tachycardie ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une extrasystole.

Q267. Coarctation de l'aorte

Parmi les étiologies susceptibles d'entrainer une cardiopathie congénitale, on note :

A) La rubéole congénitale.
B) Le tabac.
C) Les médicaments antiépileptiques.
D) Le froid.
E) La prédisposition génétique.

Q268. Coarctation de l'aorte

Parmi les cardiopathies non cyanogènes :

A) Communication inter auriculaire.
B) Communication interventriculaire.
C) Canal artériel.
D) Coarctation de l'aorte.
E) Canal atrio ventriculaire.

Q269. Syncope

La mortalité lors de la syncope est évaluée :

A) Entre 0 et 12% pour les syncopes d'origine cardiaque.
B) Entre 19 et 33% pour les syncopes d'origine non cardiaque.
C) Entre 19 et 33% pour les syncopes d'origine cardiaque.
D) A 6% pour les syncopes d'origine cardiaque.
E) Entre 19 et 33% pour les syncopes d'origine indéterminée.

Q270. Infarctus du myocarde

Précisez deux étiologies de l'infarctus du myocarde :

A) Athérosclérose coronaire.
B) Spasme coronaire.
C) Dissection aortique.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Hyperleucocytose.

Q271. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :

A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q272. Infarctus du myocarde

L'intérêt de l'échocardiographie dans l'infarctus du myocarde est de :

A) Confirmer le diagnostic (trouble de la contractilité).
B) Eliminer les autres diagnostics (péricardites, dissection).
C) Déceler les complications (rupture septale, IM ischémique).
D) Déterminer l'étiologie.
E) Objectiver la viabilité.

Q273. Infarctus du myocarde

Lors d'un infarctus du myocarde à la phase aigue, les 4 types d'anomalies spécifiques possibles sur l'ECG sont :

A) Ischémie sous endocardique.
B) Onde de Pardee (sus décalage ST).
C) Sus décalage de l'espace PQ.
D) Onde Q de nécrose.
E) Ischémie sous épicardique.

Q274. Infarctus du myocarde

Dans le syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST (NSTEMI), l'objectif de la stratification du risque est de :

A) Programmer la thrombolyse chez le patient.
B) Evaluer le risque d'évolution vers un IDM et la mort subite.
C) Proposer la stratégie thérapeutique adéquate.
D) Améliorer le pronostic.
E) Proposer la stratégie de suivi en consultation.

Q275. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications du syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST ?

A) La mort subite.
B) La dysfonction du VG à bas bruit.
C) L'infarctus du myocarde.
D) L'embolie pulmonaire.
E) L'angor stable.

Q276. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications rythmiques de l'infarctus du myocarde ?

A) le bloc auriculo ventriculaire.
B) les tachycardies ventriculaires.
C) le thrombus du ventricule gauche.
D) la rupture septale.
E) Crise d'asthme.

Q277. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 6 dérivations de bases.
D) 5 complexes par dérivation.
E) électrodes non inversés.

Q278. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation antéro-septale se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :

A) En D2-D3-AVF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-AVL.
D) De V1 à V6 et En D2-D3-AVF.
E) V7-V8-V9.

Q279. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter auriculaire :

A) Se définit par une disparition de l'onde P remplacée par l'onde F.
B) Se complique d'un AVC.
C) Est une micro-réentrée.
D) Est une macro-réentrée.
E) Se complique d'insuffisance cardiaque.

Q280. general

La Tétralogie de Fallot se caractérise par :

A) Une communication interventriculaire.
B) Une dextroposition aortique.
C) Une sténose pulmonaire.
D) Une hypertrophie du VD.
E) Une dilatation du ventricule gauche.

Q281. Infarctus du myocarde

Parmi les étiologies des MINOCA :
A) Le spasme coronaire.
B) La plaque vulnérable.
C) Le pont myocardique.
D) Le Takotsubo.
E) La myocardite.

Q282. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :
A) Deux hémocultures positives à des bactéries susceptibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une insuffisance mitrale grade I.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q283. Troubles du rythme cardiaque

Parmi les molécules suivantes laquelle ou lesquelles sont des anticoagulants par voie orale :
A) Dabigatran.
B) Rivaroxaban.
C) Acénocoumarol (sintrom).
D) Ticagrelor.
E) Tirofiban.

Q284. Infarctus du myocarde

L'acide acétylsalicylique est :
A) Un inhibiteur irréversible de la cyclo-oxygénase 1 (Cox1).
B) Inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) A une durée d'action de 21 jours.
D) prescrit à une dose de 75-500 mg pour ses effets anti-inflammatoires.
E) Doit être prescrit dans l'infarctus pulmonaire.

Q285. general

Parmi les molécules suivantes lesquelles sont des régulateurs de la coagulation :
A) Protéine S.
B) Protéine C.
C) Antithrombine III.
D) L'activateur tissulaire du plasminogène.
E) Les D-dimères.

Q286. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte chez l'adulte :
A) Est mal tolérée.
B) Est généralement bien tolérée.
C) Se manifeste par une hypertension artérielle.
D) Peut être découverte à l'occasion d'un accident vasculaire hémorragique suite à une rupture d'un anévrysme cérébral.
E) Peut être découverte à l'occasion d'un état de choc.

Q287. Coarctation de l'aorte

Le traitement de la coarctation de l'aorte peut se faire par :
A) Résection du segment rétréci suivie d'un rétablissement de la continuité par anastomose.
B) Elargissement du segment rétréci.
C) Résection avec interposition d'un tube prothétique.
D) Dilatation chirurgicale du segment rétréci.
E) Dilatation avec mise en place d'un stent par voie endovasculaire.

Q288. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) :
A) Est un dispositif d'assistance cardio-circulatoire et respiratoire.
B) Utilise une pompe et un oxygénateur.
C) Utilise le principe de vis d'Archimède.
D) Augmente la perfusion coronaire et diminue la consommation myocardique d'oxygène par le bais de la contre pulsion.
E) Peut être veino-veineuse.

Q289. Chirurgie valvulaire

La circulation extracorporelle :
A) Draine le sang veineux vers le réservoir.
B) Draine le sang artériel vers le réservoir.
C) Permet d'oxygéner le sang et de le ramener vers le patient.
D) Permet d'assurer les fonctions circulatoire et respiratoire au cours du geste chirurgical.
E) Permet de clamper l'aorte ascendante, au cours du geste chirurgical, en toute sécurité.

Q290. Chirurgie valvulaire

Parmi les moyens de la protection myocardique, on cite :

A) L'hypothermie.
B) L'induction d'une bradycardie.
C) L'éviction de la distension des cavités cardiaques par une décharge des cavités cardiaques.
D) L'administration via les artères coronaires d'une solution de hyperpotassique.
E) L'administration via les artères coronaires d'une solution de hypersodique.

Q291. Dissection aortique aigue

La présentation clinique d'une dissection aigue de l'aorte peut englober :
A) Une douleur rétrosternale intense migratrice.
B) Un tableau de tamponnade.
C) Un état de choc.
D) Une apparition soudaine d'un souffle d'insuffisance aortique.
E) Une apparition soudaine d'un souffle d'insuffisance mitrale.

Q292. Dissection aortique aigue

Le traitement de la dissection aortique de type « A » de la classification de Standford :
A) Est toujours chirurgical.
B) Peut se faire à coeur battant.
C) Consiste en un remplacement de l'aorte ascendante.
D) Consiste en un remplacement de l'aorte descendante.
E) Consiste en un remplacement de l'aorte ascendante et descendante.

Q293. Chirurgie valvulaire

Le remplacement valvulaire aortique :
A) Se fait sous circulation extracorporelle.
B) Nécessite une protection myocardique.
C) Peut se faire sans circulation extracorporelle.
D) Est indiqué lorsque la fuite aortique est légère.
E) Est associé à une conservation de l'appareil sous valvulaire.

Q294. Chirurgie valvulaire

Un enfant âgé de 15 ans suivi pour hémophilie et qui nécessite un remplacement valvulaire aortique, quelle prothèse vous lui proposeriez :
A) Une prothèse valvulaire mécanique à bille.
B) Une prothèse valvulaire mécanique à disques.
C) Une prothèse valvulaire mécanique à ailettes.
D) Une bioprothèse porcine.
E) Tube valvulé.

Q295. Chirurgie coronaire

Le pontage coronaire à coeur battant :
A) Se fait sous circulation extracorporelle et cardioplégie.
B) Permet d'éviter les effets de la CEC.
C) Est indiqué en cas de malade fragile et multi-taré.
D) Nécessite un stabilisateur.
E) Nécessite un ballon de contre pulsion intra-aortique.

Q296. Chirurgie coronaire

La mise en évidence de la sténose coronarienne :
A) Se fait par un ECG de repos et d'effort.
B) Se fait par une échocardiographie à la dobutamine.
C) Se fait par une coronarographie.
D) Se fait par un Coro-scanner.
E) Se fait par une IRM cardiaque à la gadolinium.

Q297. Tamponnade

La tamponnade :
A) Peut être d'origine néoplasique.
B) Peut faire suite à une dissection aigue de l'aorte ascendante.
C) Peut être d'origine infectieux.
D) Nécessite un drainage péricardique percutané ou chirurgical.
E) Nécessite un drainage sous circulation extracorporelle.

Q298. IAMI

Les conséquences physiopathologiques en cas d'ischémie aigue des membres inférieurs :
A) Sont seulement locales.
B) Sont Locales et générales.
C) Sont en rapport avec l'ischémie et la revascularisation après la prise en charge.
D) Engendre l'atteinte nécrotique du tissu cutané en premier.
E) Engendre l'atteinte du tissu nerveux avant la nécrose du tissu cutané.

Q299. IAMI

L'ischémie aigue du membre inferieur :

A) Est une interruption brutale du courant sanguin et de l'irrigation tissulaire du membre inferieur.
B) Remonte à moins de 15 jours.
C) Son traitement médical est basé sur les corticoïdes.
D) La sonde de joly a amélioré son pronostic.
E) Toutes les réponses sont fausses.

Q300. Varices des membres inférieurs

L'échodoppler :

A) Est un examen paraclinique à haut risque d'irradiation.
B) Permet une étude morphologique et hémodynamique des artères.
C) Permet le diagnostic d'une insuffisance veineuse superficielle.
D) Permet le diagnostic d'une occlusion artérielle.
E) Un bon moyen pour le dépistage d'AOMI.

Q301. Traumatisme artériel des membres

En cas de lésion artérielle suite à un traumatisme du membre, l'examen clinique peut objectiver :

A) Une abolition des pouls.
B) Une masse battante.
C) Un thrill.
D) Un hématome.
E) Toutes les réponses sont justes.

Q302. Varices des membres inférieurs

Les varices peuvent être traitées par :

A) Un pontage par voie chirurgicale.
B) Des phlébectomies.
C) Voie endoveineuse.
D) La contention élastique.
E) Une sclérothérapie.

Q303. Varices des membres inférieurs

Signes fonctionnels d'insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs sont :

A) Une lourdeur.
B) Une pesanteur majorée au réveil.
C) Accentués par la station debout.
D) Améliorés par la station debout.
E) Aggravée par la surélévation des membres.

Q304. AAA

Indications du traitement d'un anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal :

A) Augmentation de diamètre de 3cm en 1 an.
B) Anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal fissuré.
C) Diamètre supérieur à 4cm.
D) Anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal compliqué.
E) Diamètre inférieur à 5cm.

Q305. AAA

On peut traiter un anévrysme de l'aorte abdominal sous rénal par :

A) Une sonde de Joly.
B) Une prothèse chirurgicale en dacron.
C) Une endoprothèse.
D) Une voie endovasculaire.
E) Mise à plat greffe chirurgicale.

MAI 2023 (NORMALE)

Q306. Rétrecissement mitral

Quelle(s) anomalie(s) relevez-vous à partir de l'ECG de cette patiente ?

A) Un flutter atrial.
B) Une Hypertrophie auriculaire droite.
C) Une hypertrophie auriculaire gauche.
D) Un sus décalage typique du segment ST dans le territoire Inférieur.
E) Une fibrillation atriale.

Q307. Rétrecissement mitral

Quelle(s) anomalie(s) relevez-vous à partir de la radiographie thoracique de cette patiente ?

A) Une cardiomégalie importante.
B) Un élargissement médiastinal.
C) Une Opacité apicale.
D) Un débord de l'Arc inférieur droit.
E) Un arc moyen gauche convexe en double bosse.

Q308. Rétrecissement mitral

Vous adressez votre patiente à un cardiologue lequel mentionne dans son rapport de consultation l'existence d'un roulement diastolique au foyer mitral, quelle valvulopathie vous évoquerez en premier devant cette auscultation anormale ?

A) Maladie Aortique.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Mitrale.
D) Rétrécissement pulmonaire.
E) Rétrécissement aortique.

Q309. Rétrecissement mitral

L'auscultation typique de cette valvulopathie au foyer mitral est caractérisée par une triade appelée la triade de DUROZIER, de quoi est-elle faite ?

A) Un éclat de B2 + Roulement diastolique+ claquement de fermeture mitrale.
B) Un éclat de B1+ Roulement systolique+ claquement de fermeture mitrale.
C) Un éclat de B1+ Roulement diastolique+ claquement de fermeture mitrale.
D) Un éclat de B2+ Roulement diastolique+ claquement d'ouverture mitrale.
E) Aucune des réponses ci-dessus.

Q310. Rétrecissement mitral

Quel examen paraclinique permet de diagnostiquer cette valvulopathie ?

A) L'électrocardiogramme.
B) La radiographie thoracique.
C) La coronarographie.
D) L'Echocardiographie transthoracique.
E) Aucune de ces propositions.

Q311. Rétrecissement mitral

Sur le plan physiopathologique, l'adaptation cardiaque à cette valvulopathie entraîne :

A) Une dilatation de l'artère sous clavière.
B) Une dilatation de l'aorte.
C) Une dilatation de l'oreillette gauche.
D) Une dilatation du ventricule gauche.
E) Aucune de ces propositions.

Q312. Rétrecissement mitral

L'anomalie relevée sur l'ECG de cette patiente, expose à une complication typique de la valvulopathie dont elle souffre, laquelle ?

A) Une insuffisance cardiaque droite.
B) Une Syncope.
C) Une Insuffisance tricuspide.
D) Un accident vasculaire thrombo-embolique.
E) La mort subite.

Q313. Rétrecissement mitral

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui signent que votre valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?

A) Une Surface valvulaire de < 2cm2.
B) Une Surface valvulaire < 1cm2.
C) Un gradient moyen > 12mmHg.
D) Un gradient moyen > 40mmHg.
E) Une présence de calcifications importantes sur la valve.

Q314. Rétrecissement mitral

Si la sévérité de votre valvulopathie est confirmée, quelles sont les options thérapeutiques à proposer chez votre patiente ?

A) Un traitement médicamenteux à base de bétabloquants.
B) Un traitement médicamenteux à base de dérivés nitrés.
C) Un traitement percutané.
D) Un traitement de remplacement valvulaire chirurgical.
E) Une abstention thérapeutique.

Q315. Rétrecissement mitral

Compte tenu de l'âge jeune et de l'état de sa valve, elle a été décidé chez elle après discussion médico-chirurgicale de tenter une dilatation percutanée de la valve malade, quelles sont les contre-indications de cette technique ?

A) Le bloc auriculo-ventriculaire.
B) La grossesse.
C) Le Thrombus intra auriculaire gauche.
D) Un trouble de l'hémostase.
E) Des valves massivement calcifiées.

Q316. Rhumatisme articulaire aigu

La Chorée de Sydenham dans sa forme typique est caractérisée par :

A) Un début brutal.
B) Des crises tonico-cloniques généralisées.
C) Des mouvements anormaux qui disparaissent à l'émotion.
D) Des séquelles neurologiques définitives.

E) D'aucune de ces propositions.

Q317. Rhumatisme articulaire aigu

Le traitement de la cardite rhumatismale modérée est basé sur :

A) L'utilisation de 600000 UI de benzathine pénicilline chez l'enfant de < de 30 Kg de poids.
B) La prescription du repos au lit.
C) L'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) pendant 15jours.
D) L'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) pendant 15jours.
E) L'utilisation de la pénicilline V à raison de 2 millions d'UI en intra veineux.

Q318. Insuffisance aortique

Quels sont parmi les propositions suivantes, les signes cliniques de sévérité de l'insuffisance aortique ?

A) Un pincement de la pression différentielle.
B) Un claquement méso-diastolique.
C) Une PAD < 50mmHg.
D) Un roulement diastolique de Flint.
E) Un éclat de B1 à l'auscultation du foyer aortique.

Q319. Rétrecissement aortique

Les diagnostics différentiels du rétrécissement aortique sont :

A) Le rétrécissement mitral.
B) La coarctation de l'aorte.
C) Le rétrécissement tricuspide.
D) Le rétrécissement pulmonaire.
E) Le souffle fonctionnel d'une anémie profonde.

Q320. Insuffisance mitrale

A propos de l'Insuffisance Mitrale chronique :

A) Est toujours symptomatique.
B) Le souffle systolique intense est un signe de sévérité.
C) Le traitement est toujours un remplacement valvulaire par prothèse mécanique.
D) Une Surface de l'orifice régurgitant (SOR) >= 10mm2 signe la sévérité.
E) Impose au ventricule gauche une surcharge volumétrique.

Q321. Thrombose & Embolie

Une patiente de 46 ans se présente aux urgences pour une syncope, son interrogatoire retrouve une notion de chirurgie avec immobilisation il y a 1mois vous évoquez chez elle une embolie pulmonaire son score de WELLS est jugé intermédiaire, quel examen à demander en 1ère intention ?

A) Un électrocardiogramme.
B) Une échocardiographie transthoracique.
C) Un angioscanner thoracique.
D) Un cathétérisme cardiaque droit.
E) Aucun des examens ci-dessus.

Q322. Péricardites aigues

La péricardite aigue est diagnostiquée devant la présence de 2 des 4 critères suivants sauf un lequel ?

A) L'épanchement péricardique.
B) Le frottement péricardique.
C) L'abrasion de l'onde R en Antéro-septal.
D) La douleur thoracique péricarditique.
E) La présence d'un sous décalage de l'espace PQ à l'ECG.

Q323. Cardiomyopathie

Les principales complications de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) sont :

A) L'hypertension artérielle.
B) L'endocardite infectieuse.
C) Les troubles de rythme ventriculaire.
D) La mort subite.
E) La poussée d'insuffisance cardiaque.

Q324. Insuffisance cardiaque de l'adulte

L'insuffisance cardiaque (IC) à fraction d'éjection préservée est définit en 2021 par la Société européenne de cardiologie par :

A) La présence des signes et des symptômes d'IC uniquement.
B) L'association des signes et des symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection < 45%.
C) Une fraction d'éjection < 40%.
D) Une fraction d'éjection >= 50%.
E) Aucune de ces propositions.

Q325. Hypertension artérielle

Le bilan initial de l'hypertension artérielle, comprend :

A) Le dosage de la cortisolémie de 8h.
B) Le dosage de l'acide urique sanguin.
C) Le fond d'oeil.

D) Une échocardiographie transthoracique.
E) Aucune de ces propositions.

Q326. Syncope

La mortalité lors de la syncope est évaluée :

A) Entre 0 et 12 % pour les syncopes d'origine cardiaque.
B) Entre 19 et 33 % pour les syncopes d'origine non cardiaque.
C) Entre 19 et 33 % pour les syncopes d'origine cardiaque.
D) A 6 % pour les syncopes d'origine cardiaque.
E) Entre 19 et 33 % pour les syncopes d'origine indéterminée.

Q327. Syncope

Parmi les causes des syncopes cardiaques d'effort :

A) Le rétrécissement aortique serré.
B) La bradycardie.
C) La CMHO (cardiomyopathie hypertrophique obstructive).
D) La poussée hypertensive.
E) L'âge élevé.

Q328. Infarctus du myocarde

Les facteurs de vulnérabilité de la plaque d'athérome sont :

A) L'effort intense.
B) L'angor stable.
C) L'épaisseur et la structure de la chape fibreuse.
D) Taille du noyau lipidique.
E) L'inflammation.

Q329. Infarctus du myocarde

En dehors de l'athérosclérose coronaire quelles sont les autres étiologies possibles de l'infarctus du myocarde :

A) Dissection coronaire.
B) Embolie coronaire.
C) Spasme coronaire.
D) La tachycardie ventriculaire.
E) Les artérites inflammatoires.

Q330. Troubles du rythme cardiaque

Les troubles du rythme peuvent se manifester par :

A) Syncope.
B) Lipothymie.
C) Douleur thoracique.
D) Dyspnée.
E) Palpitations.

Q331. Troubles de conduction

Parmi les étiologies aigues des troubles de conductions :

A) IDM aigu.
B) Endocardite infectieuse.
C) Cause Métabolique.
D) BAV congénital.
E) Cause dégénérative.

Q332. Électrocardiogramme

l'Electrocardiogramme est un examen :

A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q333. Infarctus du myocarde

L'intérêt de l'échocardiographie dans l'infarctus du myocarde est de :

A) Confirmer le diagnostic (trouble de la contractilité).
B) Eliminer les autres diagnostics (péricardites, dissection).
C) Déceler les complications (rupture septale, IM ischémique).
D) Déterminer l'étiologie.
E) Objectiver la viabilité.

Q334. Infarctus du myocarde

Lors d'un infarctus du myocarde à la phase aigue, les 4 types d'anomalies spécifiques possibles sur l'ECG sont :

A) Ischémie sous endocardique.
B) Onde de Pardee (sus décalage ST).
C) Sus décalage de l'espace PQ.
D) Onde Q de nécrose.

E) Ischémie sous epicardique.

Q335. Infarctus du myocarde

Les autres diagnostics à éliminer avant de retenir l'IDM :

A) L'ulcère perforé.
B) La pancréatite aigue.
C) La dissection aortique.
D) La péricardite aigue.
E) L'embolie pulmonaire.

Q336. Infarctus du myocarde

Dans le syndrome coronaire aigu sans décalage du segment ST (NSTEMI), l'objectif de la stratification du risque est de :

A) Programmer la thrombolyse chez le patient.
B) Evaluer le risque d'évolution vers un IDM et la mort subite.
C) Proposer la stratégie thérapeutique adéquate.
D) Améliorer le pronostic.

Q337. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications du syndrome coronaire aigu sans décalage du segment ST ?

A) La mort subite.
B) La dysfonction du VG à bas bruit.
C) L'infarctus du myocarde.
D) La récidive ischémique.
E) L'angor stable.

Q338. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?

A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q339. Électrocardiogramme

Lors d'une angine de poitrine, l'ECG per critique objective :

A) Un sus décalage du segment ST.
B) Un sous décalage du segment ST.
C) Une fibrillation ventriculaire.
D) Modification de l'onde T.
E) Des torsades de pointes.

Q340. AOMI

Quelles sont les mesures à proposer pour contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire :

A) Arrêt du tabac.
B) Equilibrer le diabète.
C) Traiter la dyslipidémie.
D) Pratiquer l'activité physique.
E) Equilibrer l'hypertension artérielle.

Q341. AOMI

Parmi les principales localisations de l'athérosclérose, on note :

A) Les artères carotides.
B) Les veines jugulaires.
C) Les artères des membres inférieurs.
D) La veine cave supérieure.
E) Le creux axillaire.

Q342. Endocardite infectieuse

La Tétralogie de Fallot se caractérise par :

A) Une communication interventriculaire.
B) Une dextroposition aortique.
C) Une sténose pulmonaire.
D) Une hypertrophie du VD.
E) Une dilatation du ventricule gauche.

Q343. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques : nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q344. Traitement de l'infarctus du myocarde

L'acide acétylsalicylique est :
A) un inhibiteur irréversible de la cyclo-oxygénase 1 (Cox1).
B) Inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) A une durée d'action de 21jours.
D) prescrit à une dose de 75-300 mg pour ses effets anti-inflammatoires.
E) Doit être prescrit dans l'infarctus pulmonaire.

Q345. Hypertension pulmonaire

Parmi les molécules suivantes lesquelles sont des régulateurs de la coagulation :
A) Protéine S ;
B) Protéine C ;
C) Antithrombine III ;
D) L'activateur tissulaire du plasminogène ;
E) Les D-dimères ;

Q346. Chirurgie valvulaire

Le monitorage de la circulation extracorporelle nécessite :
A) Un ECG ;
B) Une pression artérielle sanglante et une pression veineuse centrale ;
C) Une surveillance du temps de prothrombine (TP) ;
D) Une surveillance des gaz du sang ;
E) Une surveillance du temps de céphaline activée (TCA).

Q347. Chirurgie valvulaire

Au cours de la circulation extracorporelle, la protection myocardique a pour but de :
A) Réduire le risque d'ischémie myocardique ;
B) Améliorer la contractilité ;
C) Maintenir un niveau énergétique suffisant pour la reprise de l'activité cardiaque en fin du geste opératoire ;
D) Assurer une bonne perfusion des différents organes ;
E) Améliorer la cicatrisation myocardique.

Q348. Chirurgie valvulaire

Les prothèses biologiques :
A) Peuvent être d'origine humain ;
B) Peuvent être d'origine porcine ;
C) Peuvent être d'origine bovine ;
D) Nécessite une anticoagulation sur durée de 12 mois ;
E) Ne requièrent pas d'antibioprophylaxie lors d'un examen endoscopique.

Q349. Chirurgie valvulaire

Chez un patient porteur de prothèse mitrale mécanique :
A) L'International Normalized Ratio (INR) cible doit se situer entre 3,5 à 4 ;
B) L'INR cible doit se situer entre 2 à 2,5 ;
C) Toute fièvre prolongée doit être considérer comme endocardite jusqu'à preuve du contraire ;
D) Toute fièvre prolongée nécessite des hémocultures ;
E) Toute fièvre prolongée nécessite une antibiothérapie à base de céphalosporine de troisième génération.

Q350. Chirurgie valvulaire

Le remplacement valvulaire par prothèse biologique nécessite :
A) Un traitement anticoagulant, à vie, à base d'antivitamine K ;
B) Une surveillance régulière du temps de céphaline activée (TCA) ;
C) Une surveillance régulière de l'International Normalized Ratio (INR) ;
D) Une surveillance régulière pour détecter une éventuelle dégénérescence de la bioprothèse ;
E) Une antibioprophylaxie lors d'une extraction dentaire.

Q351. Chirurgie valvulaire

Un rétrécissement mitral peut nécessiter :
A) Une dilatation mitrale percutanée ;
B) Une dilatation avec pose de stent ;
C) Un remplacement par une prothèse mécanique ;
D) Un remplacement par une prothèse biologique ;
E) Une commissurotomie à coeur ouvert (CCO).

Q352. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte du nouveau-né dans sa forme pré-ductale :
A) Est souvent mal tolérée ;
B) Est exceptionnellement associée à d'autres malformations cardiaques ;
C) Caractérisée par une cyanose de l'hémicorps inférieur ;
D) Caractérisée par une cyanose de l'hémicorps supérieur ;
E) Peut se présentée comme un tableau d'insuffisance cardiaque.

Q353. Dissection aortique aigue

La dissection aigue de l'aorte :

A) Correspond à une déchirure de l'intima et des couches médiales internes avec un clivage longitudinal de la média ;
B) De type A de STANFORD correspond à une dissection qui intéresse l'aorte ascendante quel que soit la porte d'entrée ;
C) Nécessite une prise charge chirurgicale lorsqu'elle intéresse l'aorte ascendante ;
D) Nécessite toujours une prise charge chirurgicale lorsqu'elle intéresse l'aorte descendante ;
E) Est toujours chirurgicale.

Q354. Dissection aortique aigue

La dissection aigue de type A de STANFORD peut se compliquer de :

A) Une insuffisance aortique ;
B) Une insuffisance mitrale aigue ;
C) Une ischémie des membres inférieurs ;
D) Une insuffisance rénale ;
E) Un choc cardiogénique.

Q355. Chirurgie coronaire

Lors de la chirurgie coronaire, le greffon idéal est :

A) L'artère mammaire interne ;
B) La veine saphène interne ;
C) L'artère radiale ;
D) L'artère gastro-épiploïque ;
E) La veine saphène externe.

Q356. Chirurgie coronaire

La chirurgie coronaire est indiquée en cas de :

A) Atteinte tri-tronculaire avec des lésions sténotiques >70%, surtout quand la fonction ventriculaire gauche est altérée ;
B) Atteinte tri-tronculaire avec des lésions sténotiques situées entre 50-70%. ;
C) Sténose serrée du tronc commun ;
D) Echec d'angioplasties ;
E) Toute lésion coronaire.

Q357. Tamponnade

La tamponnade :

A) Est définie comme une compression aiguë ou subaiguë des cavités cardiaques par un épanchement péricardique massif ou de constitution rapide ;
B) Entraine, dans un premier temps, une gêne systolique ;
C) Entraine une gêne du remplissage des cavités droites ;
D) Entraine une hypotension veineuse ;
E) Peut être traitée par une ponction-drainage percutané.

Q358. AOMI

Un ulcère de la jambe d'origine artérielle dans le cadre d'une AOMI :

A) Correspond à la classe IV de la classification de Leriche ;
B) Correspond à la classe III de la classification de Leriche.
C) Se caractérise par une tendance à une cicatrisation spontanée.
D) Définit une ischémie critique s'il est associé à une PAS de la cheville < 50 mmhg.
E) Définit une ischémie critique s'il est associé à une PAS du gros orteil < 70 mmhg.

Q359. AOMI

En cas d'ulcère de la jambe d'origine artérielle dans le cadre d'une AOMI, on peut proposer comme traitement de revascularisation :

A) Une angioplastie avec ballon.
B) Une angioplastie avec stent.
C) Une angioplastie avec ballon et stent.
D) Un pontage en veine.
E) Un pontage en prothèse.

Q360. IAMI

En cas d'ischémie aigue du membre inférieur :

A) Un mécanisme embolique est possible.
B) Un trouble de rythme cardiaque peut constituer une cause.
C) Une valvulopathie peut constituer une cause.
D) L'athérosclérose constitue la principale cause.
E) Le traitement se base sur l'aspirine.

Q361. AAA

Parmi les moyens diagnostiques d'un anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal, on peut citer :

A) Une fibroscopie digestive.
B) Un scanner abdominal.
C) Une échographie doppler abdominale.
D) Une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR).
E) Une artériographie.

Q362. AAA

Indications du traitement d'un anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal :

A) Diamètre > 5cm ;
B) Diamètre > 4cm ;
C) Augmentation de diamètre de 2cm en 1 an.
D) Anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal rompus.
E) Anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal symptomatique.

Q363. AAA

On peut traiter un anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal par :
A) Une thrombectomie chirurgicale.
B) Une voie endovasculaire.
C) Mise à plat greffe chirurgicale.
D) Un ballon.
E) Une sonde de Fogarty.

Q364. Varices des membres inférieurs

En cas de varice des membres inférieurs :
A) Le phléboscaner est le premier examen paraclinique à demander.
B) On cherche un reflux des veines saphènes.
C) Un traitement par contention est indiqué.
D) L'anti agrégant plaquettaire est toujours indiqué.
E) Un traitement endoveineux est possible.

Q365. Varices des membres inférieurs

L'insuffisance veineuse chronique superficielle des membres inférieurs :
A) Correspond à une dilatation permanente des veines superficielles des membres inférieurs accompagnée d'altération de leur paroi et de leurs valvules.
B) Varice constitue la classe 3 de la classification CEAP.
C) Varice constitue la classe 4 de la classification CEAP.
D) Peut se compliquer par une thrombose.
E) Peut se compliquer par une rupture de varice.

JUIN 2022 (RATTRAPAGE)

Q366. Rétrecissement aortique

Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant cette auscultation cardiaque anormale ?
A) Maladie Aortique.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Mitrale.
D) Rétrécissement pulmonaire.
E) Rétrécissement aortique.

Q367. Rétrecissement aortique

Le patient présente à son admission une syncope :
A) Ce symptôme est habituel dans cette pathologie.
B) Ce symptôme n'est pas habituel dans cette pathologie.
C) Ce symptôme est dû à une chute du débit cérébral à cause d'un obstacle.
D) Ce symptôme traduit un stade évolué de cette valvulopathie.
E) Ce symptôme traduit un mauvais pronostic avec une survie moyenne de 4 ans.

Q368. Rétrecissement aortique

L'angor peut constituer un des signes cliniques de cette valvulopathie il est dû à :
A) Une coronaropathie toujours associée.
B) Une ischémie fonctionnelle due à l'anémie toujours associée à cette valvulopathie.
C) Une ischémie fonctionnelle due à la dilatation du Ventricule gauche.
D) Une ischémie fonctionnelle due à l'hypertrophie du Ventricule gauche.
E) Une association de tous ces éléments.

Q369. Rétrecissement aortique

Quel élément auscultatoire parmi les propositions suivantes témoigne du caractère sévère de votre valvulopathie ?
A) L'irradiation vers les vaisseaux du cou.
B) Le timbre rude râpeux du souffle.
C) L'abolition du B2 au 2ème espace intercostal droit.
D) L'abolition du B2 au 2ème espace intercostal gauche.
E) Aucune de ces propositions.

Q370. Rétrecissement aortique

Sur le plan physiopathologique cette valvulopathie impose au ventricule gauche :
A) Une surcharge barométrique pure.
B) Une surcharge volumétrique pure.
C) Une surcharge mixte.
D) Aucune surcharge ce qui explique le caractère longtemps asymptomatique de cette valvulopathie.

E) Une surcharge volumétrique d'abord puis barométrique.

Q371. Rétrecissement aortique

Sur le plan physiopathologique, l'adaptation cardiaque à votre valvulopathie est régie par :

A) La loi de Franck-Starling.
B) La loi de Poiseuille.
C) La loi de Bernoulli.
D) La loi de Laplace.
E) Aucune de ces propositions.

Q372. Rétrecissement aortique

Sur l'ECG de ce patient, une Hypertrophie ventriculaire gauche électrique a été relevée, elle est de type systolique elle est :

A) Toujours corrélée à une hypertrophie ventriculaire anatomique.
B) Caractérisée par des ondes T positives dans les précordiales gauches.
C) Caractérisée par des ondes T négatives dans les précordiales gauches.
D) Considérée comme un critère de sévérité de cette valvulopathie.
E) Caractérisée par un indice de sokolow-lyon <35mm.

Q373. Rétrecissement aortique

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui signent que votre valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?

A) Une SOR (surface de l'orifice régurgitant) > 20 mm^2.
B) Une Surface Aortique < 1cm^2.
C) Un gradient moyen <30mmHg.
D) Un gradient moyen >40mmHg.
E) Une présence de calcifications importantes sur la valve aortique.

Q374. Rétrecissement aortique

Si la sévérité de votre valvulopathie est confirmée, quelles sont les options thérapeutiques à proposer chez votre patient ?

A) Un traitement médicamenteux à base de bêtabloquant.
B) Un traitement symptomatique pour les précordialgies à base de dérivés nitrés.
C) Une reprise du sport.
D) Un traitement de remplacement valvulaire chirurgical.
E) Une abstention thérapeutique.

Q375. Rétrecissement aortique

Vous décidez d'opérer ce patient, dans son bilan d'opérabilité vous demandez une coronarographie, quels arguments justifient cette demande ?

A) L'âge du patient.
B) Le Tabagisme.
C) Une fonction ventriculaire normale.
D) Vous demandez systématiquement cet examen à tous les patients valvulaires.
E) L'existence du syndrome anémique chez votre malade.

Q376. Rhumatisme articulaire aigu

A propos du rhumatisme articulaire aigu, selon l'OMS, le premier épisode est confirmé devant la présence :

A) D'une preuve d'infection antérieure au streptocoque du groupe A uniquement.
B) D'une preuve d'infection antérieure au staphylocoque du groupe A uniquement.
C) De 2 manifestations majeures parmi les critères de Jones modifiés uniquement.
D) De 5 manifestations mineures parmi les critères de Jones modifiés uniquement.
E) D'aucune de ces propositions.

Q377. Rhumatisme articulaire aigu

Le traitement du rhumatisme articulaire aigu est basé sur :

A) L'utilisation de 600000 UI de benzathine pénicilline chez l'enfant de < 30 Kg de poids.
B) La prescription du repos au lit.
C) L'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) chez les patients porteurs d'une arthrite.
D) L'utilisation de l'Halopéridol en présence d'une chorée.
E) L'utilisation de la pénicilline V à raison de 2 millions d'UI en intra veineux.

Q378. Rétrecissement mitral

Quels sont parmi les propositions suivantes, les signes cliniques du Rétrécissement mitral :

A) Un pincement de la pression différentielle.
B) Un faciès Shattuck.
C) Un retard staturo-pondéral chez l'enfant.
D) Un roulement diastolique de Flint.
E) Un éclat de B1 à l'auscultation du foyer mitral.

Q379. Rétrecissement mitral

Les diagnostics différentiels du rétrécissement mitral sont :

A) Le Myxome de l'oreillette gauche.
B) Le coeur triatrial.
C) Le rétrécissement tricuspide.
D) Le rétrécissement pulmonaire.

E) Le roulement de flint de l'insuffisance aortique sévère.

Q380. Insuffisance mitrale

A propos de l'Insuffisance Mitrale chronique :

A) Peut-être longtemps asymptomatique.
B) Le souffle systolique intense est un signe de sévérité.
C) Le traitement est toujours un remplacement valvulaire par prothèse mécanique.
D) Une Surface de l'orifice régurgitant (SOR) >= 40mm² signe la sévérité.
E) Dans le type III de Carpentier, le mouvement valvulaire est normal.

Q381. Insuffisance aortique

A propos de l'insuffisance aortique chronique :

A) Impose au ventricule gauche une surcharge de pression uniquement.
B) Impose au ventricule gauche une surcharge volumétrique uniquement.
C) Le pincement de la différentielle de la tension artérielle est un signe de sévérité.
D) Peut entraîner un angor.
E) Un volume régurgitant (VR) >= 60ml signe la sévérité à l'échocardiographie.

Q382. Hypertension pulmonaire

Une patiente de 26 ans se présente pour un bilan de dyspnée d'effort, son interrogatoire retrouve une notion d'utilisation d'anorexigènes vous suspectez chez elle un tableau d'hypertension pulmonaire (HTP) quel examen paraclinique vous demandez en première intention ?

A) Un électrocardiogramme.
B) Une échocardiographie transthoracique.
C) Un angioscanner thoracique.
D) Un cathétérisme cardiaque droit.
E) Une fibroscopie oeso-gastro-duodénale.

Q383. Péricardites aigues

A propos de la péricardite aiguë :

A) L'épanchement péricardique est obligatoire au diagnostic.
B) Le frottement péricardique est toujours présent.
C) Elle est dite incessante quand elle dépasse 3 mois d'évolution.
D) La douleur thoracique péricarditique est toujours présente.
E) La recherche virologique du VIH est demandée en première intention.

Q384. Cardiomyopathie restrictive

Les principales complications de la cardiomyopathie restrictive (CMR) sont :

A) L'hypertension portale.
B) L'endocardite infectieuse.
C) Les troubles de rythme ventriculaire.
D) La mort subite.
E) La poussée d'insuffisance cardiaque.

Q385. Insuffisance cardiaque de l'adulte

L'insuffisance cardiaque (IC) à fraction d'éjection préservée est définie en 2021 par la Société européenne de cardiologie par :

A) La présence des signes et des symptômes d'IC uniquement.
B) L'association des signes et des symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection >45%.
C) Une fraction d'éjection <40%.
D) Une fraction d'éjection >= 50%.
E) Aucune de ces propositions.

Q386. Infarctus du myocarde

Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s) d'après l'ECG du patient (Cas clinique n°2) ?

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auricule-ventriculaire de 3ème degré.
C) Il existe un sus décalage du segment ST en inférieur.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une extrasystole auriculaire.

Q387. Infarctus du myocarde

La seule attitude urgente pour confirmer le diagnostic est :

A) Administrer du paracétamol.
B) Administrer de la trinitrine et refaire l'ECG.
C) Monitoring et surveillance.
D) Faire des prélèvements.
E) Surveiller sans rien faire.

Q388. Traitement de l'infarctus du myocarde

Le diagnostic d'un infarctus du myocarde a été retenu, quelle prise en charge est envisagée chez le patient ?

A) Angioplastie primaire (intervention coronaire percutanée).
B) Sonde de stimulation provisoire.
C) Thrombolyse.

D) Traitement anti thrombotique.
E) Traitement anticoagulant.

Q389. Traitement de l'infarctus du myocarde

On décide de faire une thrombolyse le malade à la Metalyse, quelle est votre attitude ?

A) Eliminer les contre indications à la thrombolyse.
B) Prendre le poids et la taille.
C) Réaliser une échographie trans thoracique pour éliminer un épanchement péricardique.
D) Traitement anti thrombotique.
E) Traitement anticoagulant.

Q390. Traitement de l'infarctus du myocarde

L'ECG réalisé 1 heure après thrombolyse est le suivant, quelles sont les deux réponses justes ?

A) Succès de thrombolyse.
B) Onde Q de nécrose en antéro septal.
C) Tachycardie ventriculaire.
D) PR allongé.
E) Bloc de branche gauche.

Q391. Insuffisance aortique

L'indice de Sokolow-Lyon est :

A) Un score équivalent au score de Framingham.
B) Utile pour détecter l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG.
C) Utile pour détecter l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'échographie cardiaque.
D) Positif si R (V5 ou V6) + S V1 > 35 mm.
E) Un souffle tricuspide.

Q392. Infarctus du myocarde

Précisez trois étiologies de l'allongement de l'espace QT à l'ECG :

A) Médicamenteuse (chloroquine).
B) Héréditaire.
C) Dissection aortique.
D) Infarctus du myocarde.
E) Hyperleucocytose.

Q393. Électrocardiogramme

L'ECG d'effort (épreuve d'effort) est positif si :

A) Survenue de douleur thoracique pendant l'exercice.
B) Sous décalage du segment ST.
C) Sus décalage du segment ST.
D) Modifications non significatives de l'onde T.
E) Sous décalage de l'espace PQ.

Q394. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter auriculaire :

A) Se définit par une disparition de l'onde P remplacée par l'onde F.
B) Se complique d'un AVC.
C) Est une micro-reentrée.
D) Est une macro-réentrée.
E) Se complique d'insuffisance cardiaque.

Q395. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?

A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Complications thrombo emboliques.

Q396. Infarctus du myocarde

Un infarctus du myocarde latéral haut se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :

A) En D2-D3-AVF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-AVL.
D) De V1 à V6 et En D2-D3-AVF.
E) V7-V8-V9.

Q397. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans Oesophagienne (ETO) ?

A) Spasme laryngé.
B) Pancréatite.
C) Reflexe vaso-vagale.
D) Perforation digestive.

E) Trouble de conduction.

Q398. Hypertension artérielle

Quel est le facteur non modifiable susceptible de favoriser l'athérosclérose ?

A) Le tabagisme.
B) L'Hypertension artérielle.
C) Le diabète.
D) L'âge.
E) L'activité physique.

Q399. Infarctus du myocarde

Parmi les étiologies des MINOCA :

A) Le spasme coronaire.
B) La plaque vulnérable.
C) Le pont myocardique.
D) Le Takotsubo.
E) La myocardite.

Q400. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 12 dérivations de bases.
D) 3 complexes par dérivation.
E) Onde P négative en DI (électrodes non inversés).

Q401. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries susceptibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques : nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q402. Infarctus du myocarde

Parmi ces propositions, quelles sont les étiologies de l'infarctus du myocarde ?

A) L'embolie coronaire.
B) L'athérosclérose.
C) La BPCO.
D) Le tabagisme.
E) La sédentarité.

Q403. Syncope

Parmi les étiologies d'une syncope :

A) Le rétrécissement aortique.
B) La tachycardie sinusale.
C) Le bloc auriculo ventriculaire complet.
D) L'origine vaso-vagale.
E) Tachycardie ventriculaire.

Q404. Endocardite infectieuse

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :

A) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
B) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et hémoculture négative.
E) En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile.

Q405. Traitement de l'infarctus du myocarde

L'acide acétylsalicylique est :

A) Un inhibiteur réversible de la cyclo-oxygénase 1 (Cox1).
B) Un Inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) Actif pendant une durée de 21 jours.
D) Prescrit à une dose de 75-300 mg pour ses effets contre l'inflammation.
E) Prescrit dans l'infarctus du myocarde.

Q406. Chirurgie coronaire

La circulation extracorporelle comporte :

A) Une pompe occlusive.
B) Un respirateur.
C) Un échangeur thermique.
D) Des tubes et canules en polychlorure de Vinyle ou en Silicone.
E) Un ballon de contre pulsion intra-aortique.

Q407. Chirurgie coronaire

La protection myocardique est basée sur la diminution des besoins myocardiques en oxygène et en ATP par :

A) L'arrêt de l'activité mécanique du coeur.
B) La diminution de la tension pariétale myocardique grâce à la décharge des cavités cardiaques.
C) La diminution du métabolisme myocardique de base grâce à l'hyperthermie.
D) L'augmentation de la perfusion coronaire.
E) La hémodilution.

Q408. Chirurgie valvulaire

La chirurgie valvulaire réparatrice (plastie valvulaire) :

A) Doit être privilégiée.
B) Conserve le tissu valvulaire natif (du malade).
C) Remplace totalement le tissu valvulaire natif.
D) Nécessite une anticoagulation à vie.
E) Nécessite une antibiothérapie au long cours.

Q409. Chirurgie valvulaire

Un patient âgé de 75 ans qui nécessite un remplacement valvulaire aortique, quelle prothèse vous lui proposeriez en première intention :

A) Une prothèse aortique mécanique à disque.
B) Une prothèse aortique mécanique à double ailettes.
C) Une prothèse aortique mécanique à bille.
D) Une bioprothèse aortique.
E) Un anneau prothétique.

Q410. Chirurgie valvulaire

Le remplacement valvulaire par prothèse biologique nécessite :

A) Un traitement anticoagulant, à vie, à base d'antivitamine K.
B) Une surveillance régulière du temps de céphaline activée (TCA).
C) Une antibiothérapie au long cours.
D) Une surveillance régulière de la vitesse de sédimentation.
E) Une antibioprophylaxie lors d'une extraction dentaire.

Q411. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte de l'adulte peut être traitée par :

A) Une résection de la coarctation avec interposition d'un tube prothétique.
B) Une résection de la coarctation avec remplacement de toute l'aorte descendante.
C) Une plastie d'élargissement par l'artère sub-clavière (intervention de Waldhausen).
D) Une plastie d'élargissement par un patch synthétique.
E) Une embolisation par voie endovasculaire.

Q412. Coarctation de l'aorte

Parmi les complications précoces de la chirurgie de la coarctation de l'aorte on cite :

A) Le chylothorax.
B) La paraplégie.
C) La paralysie du nerf phrénique.
D) La paralysie du nerf récurrent.
E) Le saignement.

Q413. Dissection aortique aigue

Une dissection aigue de l'aorte de type « A » selon la classification de Standford :

A) Correspond à une dissection intéressant l'aorte ascendante quelle que soit la situation de la porte d'entrée.
B) Correspond à une dissection intéressant exclusivement l'aorte ascendante.
C) Correspond à une dissection qui ne touche pas l'aorte ascendante.
D) Nécessite un traitement curatif à base d'anti-hypertenseurs et de bradycardisants.
E) Ne peut être traitée que par une prise en charge chirurgicale.

Q414. Dissection aortique aigue

Le diagnostic d'une dissection aigue de l'aorte ascendante :

A) Est suspecté devant une douleur rétrosternale, intense, migratrice chez un patient hypertendu.
B) Est suspecté devant une douleur rétrosternale, intense, migratrice chez un patient en état de choc.
C) Est confirmé par l'angioscanner.
D) Peut être confirmé par l'échocardiographie transoesophagienne.
E) Peut être confirmé par la scintigraphie myocardique au thallium.

Q415. Chirurgie coronaire

La chirurgie coronaire :

A) Peut se faire à coeur battant.
B) Peut utiliser des greffons synthétiques.
C) Est indiquée chez un patient qui présente une sténose de 30% du diamètre du tronc commun.
D) Peut se compliquer d'une médiastinite.
E) Peut se compliquer d'un infarctus du myocarde.

Q416. Chirurgie coronaire

Parmi les greffons suivants quels sont ceux qu'on peut utilisés lors de la chirurgie coronaire :

A) L'artère mammaire interne.
B) L'artère cubitale.
C) L'artère radiale.
D) La veine jugulaire interne.
E) La veine gastro-épiploïque.

Q417. Chirurgie coronaire

Lors de la chirurgie coronaire, la veine saphène interne utilisée comme greffon est une veine qui :

A) Est très spastique.
B) Ne peut être utilisée lorsqu'elle est variqueuse.
C) Présente un bon débit.
D) Présente une perméabilité ne dépassant pas 8 à 10 ans en moyenne.
E) Reste perméable, à 10 ans, chez 90 % des patients.

Q418. AOMI

Index de pression systolique : IPS

A) Est un moyen clinique pour dépister les varices des membres inférieurs.
B) C'est le résultat de la division de la pression artérielle systolique de la cheville sur la pression artérielle systolique humérale.
C) C'est le résultat de la division de la pression artérielle systolique humérale sur la pression artérielle systolique de la cheville.
D) Un IPS inférieur à 0,3 est en faveur d'une artérite sévère.
E) Un IPS inférieur à 0,3 est en faveur d'une insuffisance veineuse superficielle sévère.

Q419. AOMI

L'Artériographie :

A) Est un examen invasif.
B) L'injection du produit de contraste se fait par une voie veineuse de gros calibre.
C) Permet le diagnostic topographique précis des lésions artérielles.
D) Permet l'évaluation de la qualité du lit d'aval.
E) Lors du diagnostic d'une lésion artérielle par l'artériographie dans le cadre d'AOMI, on peut traiter cette lésion par les procédures endovasculaires en même temps.

Q420. AOMI

On traite une AOMI par :

A) Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires.
B) Une dilatation artérielle sans stent.
C) Une angioplastie artérielle avec pose d'un stent.
D) Un pontage artériel anatomique.
E) Un pontage artériel extra anatomique.

Q421. AOMI

Le pied diabétique :

A) Est la conjonction de complications Neurologiques, Infectieuses avec ou sans composante ischémique.
B) Est la conséquence de la microangiopathie et la macroangiopathie du diabétique.
C) En cas d'artérite chez un diabétique, les artères les plus touchées sont les artères fémorales profondes et les axes de jambes.
D) On appelle un pied déformé par l'ostéoarthropathie nerveuse diabétique : un pied de Rachot.
E) L'amputation est inutile en cas de nécrose et gangrène du pied et de la jambe chez un diabétique.

Q422. AOMI

L'Artérite juvénile de Leo burger :

A) Est une artérite du sujet âgé.
B) Est une artérite athéromateuse du sujet jeune.
C) Caractérisée par une évolution par poussées et rémissions.
D) Ne touche pas les artères des membres supérieurs.
E) Ne se traduit par aucune lésion artérielle à l'artériographie.

Q423. Ischémie aigue du membre inférieur

Le traitement de l'ischémie aigue des membres inférieurs :

A) Est une urgence médico chirurgicale.
B) Basé sur la thrombo-embolectomie à la sonde de fogarty.
C) Possible par voie endovasculaire pour certains cas.
D) Ne nécessite aucun abord chirurgical en cas d'embolectomie.
E) En cas d'embolectomie, une artériographie de contrôle est recommandée.

Q424. Varices des membres inférieurs

Parmi les Mesures recommandées dans le traitement des varices on trouve :

A) L'éviction de la station debout ou assise prolongée.
B) La surélévation des jambes du lit d'environ 10cm lors du sommeil.
C) Les bains très chauds.
D) La contention par une bande ou des bas.
E) La marche régulière.

Q425. Varices des membres inférieurs

L'ulcère variqueux :

A) Est d'évolution aigue.
B) Est superficiel.
C) Est Très douloureux.
D) Peut être accompagnée d'une dermite ocre ou d'une atrophie cutanée blanche.
E) Toutes les réponses sont justes.

MAI 2022 (NORMALE)

Q426. Insuffisance mitrale

Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant cette auscultation cardiaque anormale ?

A) Maladie Mitrale.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Aortique.
D) Insuffisance Mitrale.
E) Insuffisance Pulmonaire.

Q427. Insuffisance mitrale

Quels sont les signes cliniques habituellement retrouvés dans cette valvulopathie ?

A) Une dyspnée paroxystique nocturne.
B) Une douleur thoracique.
C) Des palpitations.
D) Une dyspnée d'effort.
E) Une syncope.

Q428. Insuffisance mitrale

Sur le plan physiopathologique cette valvulopathie impose au ventricule gauche :

A) Une surcharge barométrique pure.
B) Une surcharge volumétrique pure.
C) Une surcharge mixte.
D) Aucune surcharge ce qui explique le caractère longtemps asymptomatique de cette valvulopathie.
E) Une surcharge volumétrique d'abord puis barométrique.

Q429. Insuffisance mitrale

Quel examen paraclinique ne peut être en aucun cas normal devant cette valvulopathie quelle que soit sa sévérité ?

A) Le cathétérisme cardiaque droit.
B) L'échocardiographie trans-thoracique.
C) L'électrocardiogramme.
D) La coronarographie.
E) La radiographie pulmonaire.

Q430. Insuffisance mitrale

Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui signe que votre valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?

A) La SOR retrouvée est < 20 mm².
B) La SOR retrouvée est < 40 mm².
C) La SOR retrouvée est entre 20 et 40 mm².
D) La SOR retrouvée est $\ge$ 40 mm².
E) La SOR n'est pas un paramètre de sévérité de cette valvulopathie.

Q431. Insuffisance mitrale

Sur son compte rendu l'échographiste trouve que la valve responsable de l'anomalie est plutôt normale et que le mécanisme de cette valvulopathie est une dilatation de l'anneau de la valve de quel type de la classification de Carpentier s'agit-il ?

A) Type I.
B) Type II.
C) Type III.
D) Type I et III.
E) Aucune des réponses.

Q432. Insuffisance mitrale

Si votre diagnostic clinique se confirme, Quelle est la seule proposition parmi ces propositions qui vous décourageront à proposer une chirurgie à votre patiente même si elle est symptomatique ?

A) Altération de la fonction systolique avec une FE < 30%.
B) La présence d'une fibrillation auriculaire.
C) Augmentation des pressions de remplissage du Ventricule Gauche.
D) Râles crépitants à l'auscultation pulmonaire.
E) L'hypertension pulmonaire.

Q433. Cardiomyopathie

Cette valvulopathie est associée à une Cardiomyopathie dilatée (CMD), selon l'échocardiographiste, quelles sont les deux anomalies essentielles au diagnostic de CMD chez cette patiente ?

A) Dilation de l'anneau tricuspide.
B) Dilatation de l'oreillette gauche.
C) Dysfonction systolique du ventricule gauche.
D) Profil restrictif mitral.
E) Dilatation des cavités ventriculaires.

Q434. Cardiomyopathie

Quelles sont les complications de la CMD possibles chez cette patiente ?

A) La mort subite.
B) Une endocardite infectieuse.
C) Les accidents thrombo-emboliques.
D) Le choc cardiogénique.
E) Les troubles de rythme ventriculaires.

Q435. Cardiomyopathie

Parmi les moyens thérapeutiques dont vous disposez quels sont ceux que vous proposerez à cette patiente ?

A) Un traitement médicamenteux par diurétiques.
B) Un remplacement valvulaire si la valve est jugée irréparable.
C) Un traitement instrumental type mitra-clip.
D) Une thérapie de resynchronisation type CRT.
E) Une antibioprophylaxie systématique contre l'endocardite infectieuse.

Q436. Rhumatisme articulaire aigu

A propos du rhumatisme articulaire aigu, quels sont parmi les critères suivants ceux qui sont jugés mineurs dans les critères diagnostiques de JONES modifiés.

A) La fièvre.
B) La chorée de Sydenham.
C) L'érythème marginé de Besnier.
D) Un allongement de l'espace PR sur ECG.
E) La polyarthrite migratrice et fugace.

Q437. Rhumatisme articulaire aigu

Le traitement du rhumatisme articulaire aigu est basé sur :

A) L'utilisation de 600000 UI de benzathine pénicilline quel que soit le poids de votre patient.
B) L'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) chez les patients porteurs d'une cardite.
C) L'utilisation de la corticothérapie chez les patients porteurs d'une cardite.
D) L'utilisation de moyens physiques comme les vessies de glace pour refroidir l'inflammation.
E) L'utilisation de l'érythromycine en cas d'allergie à la pénicilline.

Q438. Insuffisance aortique

Quels sont parmi les propositions suivantes, les signes de sévérité clinique d'une Insuffisance Aortique chronique :

A) Un pincement de la pression différentielle.
B) Un souffle coté 5/6ème.
C) Une insuffisance ventriculaire Gauche.
D) Un roulement diastolique de Flint.
E) Une hyperpulsatilité artérielle.

Q439. Rétrecissement aortique

Les diagnostics différentiels du rétrécissement aortique sont :

A) L'insuffisance aortique.
B) L'insuffisance mitrale.
C) Le rétrécissement tricuspide.
D) Le rétrécissement pulmonaire.
E) Un souffle fonctionnel causé par une anémie profonde.

Q440. Insuffisance mitrale

A propos de l'insuffisance mitrale aiguë :

A) Peut être responsable d'un état de choc cardiogénique.
B) Ne donne jamais de souffle.
C) La cardiomégalie est toujours présente.
D) Une Surface de l'orifice régurgitant (SOR) $\ge$ 40mm² signe la sévérité.
E) Peut être d'origine ischémique.

Q441. Rétrecissement mitral

La triade auscultatoire du rétrécissement mitral comporte :

A) Un éclat de B1 au foyer mitral.
B) Un éclat de B2 au foyer aortique.
C) Un roulement systolique.
D) Un claquement d'ouverture de la valve mitrale.
E) Un frémissement cataire au niveau de la pointe à la palpation.

Q442. Thrombose & Embolie

Une patiente de 47 ans est admise aux urgences pour douleur thoracique, on suspecte chez elle une embolie pulmonaire. Sa

probabilité clinique est jugée intermédiaire, l'examen paraclinique de première intention à demander est :

A) Le dosage des D-dimères par méthode ELISA.
B) L'électrocardiogramme.
C) L'angioscanner thoracique.
D) L'échocardiographie transthoracique.
E) L'échographie doppler veineuse des membres inférieurs.

Q443. Hypertension artérielle

Le Bilan complémentaire initial pour les patients diagnostiqués porteurs d'une hypertension artérielle systémique doit comporter :

A) Une échographie doppler des artères rénales.
B) Un scanner cérébral.
C) Une Numération et Formule Sanguine (NFS).
D) Une Bandelette urinaire.
E) Une glycémie à jeun.

Q444. Cardiomyopathie

Les principales complications de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) sont :

A) L'hypertension artérielle.
B) L'endocardite infectieuse.
C) La fibrillation auriculaire.
D) La mort subite.
E) La poussée d'insuffisance cardiaque.

Q445. Insuffisance cardiaque de l'adulte

L'insuffisance cardiaque (IC) à fraction d'éjection réduite est définit en 2021 par la Société européenne de cardiologie par :

A) La présence des signes et des symptômes d'IC uniquement.
B) L'association des signes et des symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection > 45%.
C) Une fraction d'éjection < 40%.
D) La présence des signes et symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection $\le$ 50%.
E) Aucune de ces propositions.

Q446. Troubles de conduction

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s) :

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auriculo-ventriculaire de 3ème degré.
C) Il existe une extrasystole ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une extrasystole auriculaire.

Q447. Syncope

L'attitude urgente est :

A) Evaluer l'état hémodynamique.
B) Injecter un bêta-bloquant.
C) Adresser en salle de coronarographie.
D) Faire une radiographie thoracique.
E) Surveiller sans rien faire.

Q448. Troubles de conduction

Le diagnostic d'un trouble conductif compliquant un infarctus du myocarde a été retenu, quelle prise en charge est envisagée chez le patient :

A) Angioplastie primaire (intervention coronaire percutanée).
B) Sonde de stimulation provisoire.
C) Thrombolyse.
D) Traitement anti thrombotique.
E) Traitement anticoagulant.

Q449. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance progressive.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une crise polyurique.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q450. Syncope

Dans l'Etude de Framingham :

A) Les patients inclus étaient tous jeunes.
B) La fréquence des syncopes est de 3%.
C) La prévalence des syncopes augmente avec l'âge.
D) Le diabète favorise la survenue de syncope d'origine cardiaque.
E) L'âge n'est pas un critère valide.

Q451. Électrocardiogramme

L'ECG d'effort (épreuve d'effort) est positif si :
A) Survenue de douleur thoracique pendant l'exercice.
B) Sous décalage du segment ST.
C) Sus décalage du segment ST.
D) Modifications non significatives de l'onde T.
E) Sous décalage de l'espace PQ.

Q452. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter auriculaire :
A) Se définit par une disparition de l'onde P remplacée par l'onde F.
B) Se complique d'un AVC.
C) Est une micro-réentrée.
D) Est une macro-réentrée.
E) Se complique d'insuffisance cardiaque.

Q453. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :
A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q454. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?
A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q455. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation antéro-septale se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :
A) En D2-D3-AVF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-AVL.
D) De V1 à V6 et En D2-D3-AVF.
E) V7-V8-V9.

Q456. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans Oesophagienne (ETO) :
A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Réflexe vaso-vagale.
D) Accident vasculaire cérébral ischémique.
E) Trouble de rythme.

Q457. AOMI

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?
A) Tabagisme.
B) Hypertension artérielle.
C) Diabète.
D) Rétrécissement mitral.
E) L'activité physique.

Q458. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus du myocarde sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est juste. Laquelle ?
A) Douleur à la palpation.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) Sensible à la trinitrine.
D) Toujours à l'effort.
E) De durée brève.

Q459. Infarctus du myocarde

Précisez deux étiologies de l'infarctus du myocarde :
A) Athérosclérose coronaire.
B) Spasme coronaire.
C) Dissection aortique.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Hyperleucocytose.

Q460. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :
A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 6 dérivations de bases.
D) 5 complexes par dérivation.
E) Onde P négative en D1 (électrodes non inversés).

Q461. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :
A) Deux hémocultures positives à des bactéries susceptibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q462. Endocardite infectieuse

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf un. Lequel ?
A) Une splénomégalie.
B) Un purpura.
C) Un hippocratisme digital.
D) Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts.
E) Des adénopathies cervicales.

Q463. Syncope

Parmi les étiologies d'une syncope d'origine cardiaque :
A) Le rétrécissement aortique.
B) La tachycardie sinusale.
C) Le bloc auriculo ventriculaire complet.
D) L'origine vaso-vagale.
E) Tachycardie ventriculaire.

Q464. Traitement de l'infarctus du myocarde

L'acide acétylsalicylique est :
A) Un inhibiteur réversible de la cyclo-oxygénase 2 (Cox2).
B) Un inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) Actif pendant une durée de 21 jours.
D) Prescrit à une dose de 75-300 mg pour ses effets contre l'agrégation plaquettaire.
E) Prescrit dans l'infarctus du myocarde.

Q465. Thrombose & Embolie

Parmi les molécules suivantes laquelle ou lesquelles sont des anticoagulants par voie orale :
A) Dabigatran.
B) Rivaroxaban.
C) Acenocoumarol (sintrom).
D) Ticagrelor.
E) Tirofiban.

Q466. Chirurgie valvulaire

La circulation extracorporelle :
A) Est un dispositif d'assistance cardiorespiratoire de longue durée.
B) Qui comporte une pompe occlusive, un oxygénateur et un échangeur thermique.
C) Qui comporte une pompe Impella, un respirateur et un échangeur thermique.
D) Qui permet de réaliser la chirurgie à coeur ouvert.
E) Qui permet d'ouvrir les cavités cardiaques en toute sécurité.

Q467. Chirurgie valvulaire

La circulation extracorporelle nécessite :
A) Une anticoagulation par un antivitamine K (le Sintrom).
B) Une anticoagulation par l'héparine sodique.
C) Une hémodilution.
D) Une surveillance du temps de prothrombine (TP).
E) Une surveillance du temps de céphaline activée (TCA).

Q468. Chirurgie valvulaire

La cardioplégie est une solution :
A) Enrichie en Potassium.
B) Enrichie en Sodium.
C) Qui permet d'arrêter l'activité mécanique du coeur.
D) Qui permet de protéger le coeur contre les effets de l'ischémie.
E) Qui permet de protéger le coeur contre les effets inflammatoires de la circulation extracorporelle.

Q469. Chirurgie valvulaire

L'indication chirurgicale chez un patient ayant un vice valvulaire de type fuite importante et /ou rétrécissement serré :

A) Est toujours retenue.
B) Lorsqu'il nécessite une chirurgie conservatrice (chirurgie réparatrice).
C) Lorsqu'il est symptomatique malgré un traitement médical bien conduit.
D) Lorsqu'il est symptomatique ou asymptomatique avec de signes avancés de répercussion sur les cavités cardiaques ou de mauvaise tolérance.
E) Lorsqu'il présente une dysfonction sévère de ou des fonctions ventriculaire.

Q470. Chirurgie valvulaire

Le remplacement valvulaire par prothèse mécanique nécessite :
A) Un traitement anticoagulant, à vie, à base d'antivitamine K.
B) Une surveillance régulière du temps de céphaline activée (TCA).
C) Une surveillance régulière de l'International Normalized Ratio (INR).
D) Une surveillance régulière de la CRP.
E) Une antibioprophylaxie lors d'une extraction dentaire.

Q471. Chirurgie valvulaire

Un remplacement valvulaire aortique peut se faire par :
A) Un anneau prothétique.
B) Une prothèse valvulaire mécanique.
C) Une prothèse valvulaire biologique.
D) Un tube en dacron non valvé.
E) Une implantation percutanée d'une prothèse valvulaire biologique.

Q472. Coarctation de l'aorte

Parmi les signes cliniques de la coarctation de l'aorte de l'enfant on cite :
A) Un thorax athlétique et des membres inférieurs grêles et hypotrophes.
B) Un pouls radial ample avec des pouls fémoraux diminués ou abolis.
C) Une hypotension au niveau de l'hémicorps supérieur avec une HTA Sytolo-Diastolique au niveau des 2 membres inférieurs.
D) Un souffle continu au niveau de l'espace inter-scapulo- vertébral.
E) Un souffle diastolique au niveau de l'espace inter-scapulo- vertébral.

Q473. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte du nourrisson peut être traitée par :
A) Une résection de la coarctation avec anastomose directe.
B) Une résection de la coarctation avec interposition d'un tube prothétique.
C) Une plastie d'élargissement par l'artère sub-clavière (intervention de Waldhausen).
D) Une plastie d'élargissement par l'artère carotide commune gauche.
E) Dilatation par une sonde à ballonnet avec plus ou moins pose de stent.

Q474. Dissection aortique aigue

Le type « B » de la classification de Standford des dissections aigues de l'aorte correspond à la :
A) Dissection intéressant l'aorte ascendante quelle que soit la situation de la porte d'entrée.
B) Dissection intéressant exclusivement l'aorte ascendante.
C) Dissection intéressant l'aorte ascendante et la crosse aortique.
D) Dissection qui ne touche pas l'aorte ascendante.
E) Dissection intéressant exclusivement l'isthme aortique.

Q475. Chirurgie coronaire

Lors de la chirurgie coronaire, l'artère mammaire interne utilisé comme greffon est une artère qui :
A) Nécessite un test d'Allen avant son prélèvement.
B) Expose au risque de retard de cicatrisation du sternum.
C) N'expose pas au risque de médiastinite.
D) Présente une perméabilité > 90% à 10 ans.
E) Présente une perméabilité < 50% à 10 ans.

Q476. Tamponnade

La tamponnade peut être traitée par :
A) Un drainage péricardique sous circulation extracorporelle.
B) Une ponction-drainage percutanée.
C) Une péricardocentèse échoguidée.
D) Un drainage péricardique chirurgical par voie sous-xyphoidienne.
E) Un traitement diurétique.

Q477. Tamponnade

Parmi les signes suivants, quels sont ceux qu'on peut retrouver lors d'un tableau de tamponnade :
A) Un microvoltage.
B) Une hypotension veineuse.
C) Un pouls paradoxal de Kussmaul.
D) Une cardiomégalie à la radiographie du thorax.
E) Une dilatation de la veine cave inférieure à l'échocardiographie.

Q478. AOMI

Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs : AOMI

A) Il s'agit d'une atteinte obstructive des artères destinées aux membres inférieurs.
B) Le mécanisme embolique est le plus fréquent.
C) Une origine inflammatoire est possible.
D) Son diagnostic est un marqueur de risque cardiovasculaire.
E) Une sténose signifie une occlusion totale de la lumière artérielle.

Q479. Traumatisme artériel des membres

Les éléments en faveur d'une lésion artérielle lors d'un traumatisme d'un membre sont :
A) Un syndrome hémorragique.
B) Un syndrome infectieux.
C) Un syndrome ischémique.
D) L'Extravasation du produit de contraste à l'artériographie.
E) La présence d'un Thrill à la palpation.

Q480. IAMI

L'Ischémie aigue du membre inferieur :
A) Est une interruption brutale du courant sanguin et de l'irrigation tissulaire du membre inferieur sans menace de sa viabilité.
B) Remonte à plus de 15 jours.
C) Son traitement médical est basé sur l'aspirine.
D) Son traitement médical est basé sur l'héparine.
E) La sonde de fogarty a amélioré son pronostic.

Q481. IAMI

La douleur lors d'une ischémie aigue du membre inférieur est :
A) De début brutal.
B) Calmée facilement par les antalgiques.
C) Exagérée par la palpation.
D) Un signe clinique qui peut accompagner la pâleur, la paresthésie, la parésie et l'abolition des pouls.
E) Toutes les réponses sont justes.

Q482. AOMI

La Classification de Leriche et Fontaine :
A) Est une classification pour les ischémies aigues des membres inférieurs.
B) Le stade (III) correspond à des douleurs de décubitus.
C) Le stade (III) signifie une ischémie de repos.
D) On peut trouver un ulcère de la jambe dans le stade (IV).
E) On peut trouver une gangrène sèche du gros orteil dans le stade (IV).

Q483. AOMI

L'échodoppler artériel de l'aorte et des membres inférieurs :
A) Est un examen paraclinique inutile dans les AOMI.
B) Permet une étude morphologique des artères.
C) Permet le diagnostic d'une sténose artérielle à 60%.
D) Permet le diagnostic d'une occlusion artérielle.
E) Peut évaluer le retentissement hémodynamique en aval d'une lésion artérielle sévère.

Q484. Varices des membres inférieurs

Les varices on peut les traiter par :
A) Un stripping par voie chirurgicale.
B) Des phlébectomies.
C) Une angioplastie par voie endoveineuse.
D) La radiofréquence par voie endoveineuse.
E) Une sclérothérapie intra artérielle.

Q485. Varices des membres inférieurs

L'insuffisance veineuse chronique superficielle des membres inférieurs :
A) Est une Dilatation permanente des veines accompagnée d'altération de leur paroi et de leurs valvules.
B) Dans laquelle le sang circule à contre-courant.
C) Dans laquelle la contention n'a aucune place au traitement.
D) Dans laquelle les varices constituent la classe C2 de la classification CEAP.
E) Dans laquelle l'echodoppler veineux peut objectiver un reflux.

JUILLET 2021 (RATTRAPAGE)

Q486. Insuffisance cardiaque de l'adulte

À partir de l'énoncé, quel diagnostic évoquerez-vous chez ce patient ?
A) Syndrome oedemato-ascitique.
B) Syndrome d'épanchement pleural.
C) Bronchopneumopathie chronique obstructive.
D) Insuffisance cardiaque.
E) Cardiopathie ischémique.

Q487. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quels éléments que vous relevez de l'énoncé font partie de la définition de l'insuffisance cardiaque dans les recommandations de l'ESC 2016 ?

A) Souffle holosystolique.
B) Dyspnée.
C) OEdèmes des membres inférieurs.
D) Râles crépitants.
E) Anémie.

Q488. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quels sont les deux examens complémentaires qui vous seront utiles à la confirmation de votre diagnostic ?

A) Le dosage des troponines.
B) L'échocardiographie transthoracique.
C) Le scanner thoracique.
D) La radiographie thoracique.
E) Le dosage des peptides natriurétiques (BNP et NT-pro BNP).

Q489. Insuffisance mitrale

Le souffle systolique retrouvé chez votre patient est compatible avec quelle valvulopathie ?

A) L'insuffisance tricuspide.
B) Le rétrécissement mitral.
C) L'insuffisance aortique.
D) Le rétrécissement aortique.
E) L'insuffisance mitrale.

Q490. Insuffisance mitrale

Parmi les propositions suivantes laquelle signe la sévérité de votre valvulopathie cliniquement ?

A) L'existence de la dyspnée.
B) L'intensité du souffle coté à 3/6.
C) La turgescence jugulaire.
D) Le roulement diastolique mitral d'hyperdébit.
E) Aucune de ces propositions.

Q491. Insuffisance mitrale

L'échographiste trouve que le mécanisme de cette valvulopathie est une dilatation annulaire de quel type de la classification de Carpentier s'agit-il ?

A) Type I.
B) Type II.
C) Type III.
D) Type I et III.
E) Aucune des réponses.

Q492. Insuffisance cardiaque de l'adulte

L'échocardiographie transthoracique retrouve aussi une dilatation ventriculaire gauche avec un diamètre télédiastolique (DTD) à 67mm et une fraction d'éjection (FE) à 27 %. De quelle classe d'insuffisance cardiaque, de la classification ESC 2016, fait partie votre patient ?

A) Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse.
B) Insuffisance cardiaque globale.
C) Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.
D) Insuffisance cardiaque à haut débit.
E) Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection légèrement altérée.

Q493. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quelles sont les deux étiologies de cette insuffisance cardiaque à évoquer en premier chez votre patient ?

A) Myocardite.
B) Coronaropathie.
C) Péricardite constrictive.
D) Insuffisance mitrale.
E) Intoxication alcoolique.

Q494. Cardiomyopathie

Compte tenu des données échocardiographiques ce patient présente une cardiomyopathie dilatée quels sont les examens que vous demanderez dans le cadre de la recherche étiologique ?

A) Échocardiographie transoesophagienne.
B) TDM cérébrale.
C) IRM cardiaque.
D) Coronarographie.
E) Ferritinémie.

Q495. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quelles classes thérapeutiques font partie du traitement que vous proposerez chez ce patient ?

A) Anticoagulants.
B) Anti-aldostérone.

C) Diurétiques de l'anse.
D) Bétabloquants.
E) Inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Q496. Rhumatisme articulaire aigu

À propos du rhumatisme articulaire aigu, quels sont parmi les critères suivants ceux qui sont jugés mineurs dans les critères diagnostiques de JONES modifiés :

A) La fièvre.
B) La cardite rhumatismale.
C) La chorée de Sydenham.
D) L'augmentation de la Vitesse de sédimentation (VS).
E) Les nodules de Meynet.

Q497. Rétrecissement mitral

À propos du rétrécissement mitral :

A) C'est un obstacle à l'écoulement sanguin du ventricule gauche à l'oreillette gauche en diastole.
B) C'est une valvulopathie majoritairement rhumatismale.
C) Peut entraîner une dilatation du ventricule Gauche.
D) Peut entraîner une hypertrophie du ventricule gauche.
E) Il est jugé serré à l'échocardiographie si la surface mitrale est < 4cm².

Q498. Rétrecissement aortique

À propos du Rétrécissement Aortique :

A) C'est un obstacle à l'éjection sanguine du ventricule droit vers l'aorte en systole.
B) Peut se compliquer de la mort subite.
C) Entraine une hypertrophie ventriculaire gauche type diastolique.
D) C'est une valvulopathie majoritairement rhumatismale en Europe.
E) La bicuspidie aortique peut en être une étiologie.

Q499. Hypertension pulmonaire

L'hypertension pulmonaire (HTP) est définie hémodynamiquement par une :

A) PAPm > 25mmHg au repos mesurée au cathétérisme droit.
B) PAPs > 25mmHg au repos mesurée au cathétérisme droit.
C) PAPd > 25mmHg au repos mesurée au cathétérisme droit.
D) PAPs > 25mmHg au repos et/ou à l'effort à l'échocardiographie.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q500. Thrombose & Embolie

Une jeune femme de 28 ans suivie pour néoplasie du sein gauche traitée par radio-chimiothérapie se présente aux urgences pour une douleur basithoracique gauche, son score de probabilité clinique pour l'embolie pulmonaire est jugé intermédiaire, l'examen paraclinique de première intention à demander est :

A) L'échocardiographie transthoracique.
B) Les D-dimères par méthode ELISA.
C) L'angiographie pulmonaire.
D) L'échocardiographie transoesophagienne.
E) La scintigraphie pulmonaire ventilation-perfusion.

Q501. Thrombose & Embolie

En rapport avec la question précédente, les examens réalisés chez votre patiente ont confirmé le diagnostic de l'embolie pulmonaire et l'ont classé à risque intermédiaire faible quelles options thérapeutiques proposeriez-vous dans ce cas ?

A) Vous la traitez en ambulatoire.
B) Vous l'hospitalisez en soins intensifs.
C) Vous la mettez sous antiagrégants plaquettaires.
D) Vous lui proposez une fibrinolyse.
E) Vous la mettez sous anticoagulants.

Q502. Thrombose & Embolie

La phlébite surale se manifeste par :

A) Un oedème bilatéral des chevilles.
B) Un signe de Homans positif.
C) Une accélération de la fréquence cardiaque.
D) Une augmentation du ballottement du mollet.
E) Une absence de compressibilité de la veine à l'échographie doppler des membres inférieurs.

Q503. Hypertension artérielle

M. Jamal 56 ans consulte pour des acouphènes vous lui mesurez, à plusieurs reprises, sa tension artérielle elle est de 187 mmHg de systolique et 98mmHg de Diastolique, selon la classification ESH/ESC 2018, de quelle grade d'HTA s'agit-il ?

A) HTA normale haute.
B) HTA grade 1.
C) HTA grade 2.
D) HTA grade 3.
E) HTA Blouse blanche.

Q504. Insuffisance aortique

L'insuffisance aortique chronique sévère se manifeste cliniquement par :

A) Souffle Holosystolique.
B) Le roulement diastolique de flint.
C) Une pression artérielle diastolique < 50 mmHg.
D) Un éclat de B2 au foyer mitral.
E) Un bruit Galop 3.

Q505. Tamponnade

La tamponnade est une évolution possible de la péricardite aigue, elle se caractérise par :

A) La triade de Beck.
B) Une compression chronique des cavités cardiaques par un épanchement péricardique.
C) Un aspect collabé du ventricule droit en diastole à l'échocardiographie.
D) Un tableau d'adiastolie aigue.
E) Un Frottement péricardique.

Q506. Echographie transthoracique

Vous réalisez une ETT chez un patient et voici les images obtenues. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s):

A) Il s'agit d'une incidence (coupe) para sternale grand axe.
B) L'oreillette droite est visible sur cette incidence.
C) Le ventricule droit n'est pas visible sur cette incidence.
D) Cette incidence permet de visualiser le péricarde ainsi que les valves mitrale et aortique.
E) Cette incidence permet de mesurer les diamètres.

Q507. Troubles du rythme cardiaque

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte(s) :

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auriculo-ventriculaire complet.
C) Il existe une extrasystole ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une onde Q de nécrose dans le territoire inférieur.

Q508. Électrocardiogramme

Le holter ECG est un examen :

A) Douloureux.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une période de 24heures.
E) Excessivement cher.

Q509. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 6 dérivations de bases.
D) 5 complexes par dérivation.
E) Onde P positive en DI (électrodes non inversés).

Q510. Infarctus du myocarde

Le clopidogrel est :

A) Un inhibiteur réversible de la cyclo-oxygénase 2 (Cox2).
B) Un inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) Actif pendant une durée de 21 jours.
D) Prescrit à une dose de 1000 mg pour ses effets contre l'agrégation plaquettaire.
E) Prescrit dans l'infarctus du myocarde.

Q511. Thrombose & Embolie

La coagulation est sous le contrôle d'inhibiteurs spécifiques qui sont :

A) L'antithrombine III (AT III).
B) Les PPSB.
C) La plasmine.
D) Le système protéine C-protéine S.
E) Le cytochrome P450 2C9.

Q512. Troubles du rythme cardiaque

Parmi les molécules suivantes laquelle ou lesquelles sont des antivitaminique K :

A) Dabigatran.
B) Rivaroxaban.
C) Acenocoumarol (Sintrom).
D) Ticagrelor.
E) Tirofiban.

Q513. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation inférieur se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :
A) En D2-D3-AVF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-AVL.
D) De V1 à V6 et En D2-D3-AVF.
E) V7-V8-V9.

Q514. Hypertension artérielle

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?
A) L'Hypertension artérielle.
B) Le Diabète.
C) Le Tabagisme.
D) Le Rétrécissement tricuspide.
E) La bradycardie sinusale.

Q515. Syncope

Parmi les étiologies des syncopes d'origine cardiaque :
A) Le rétrécissement aortique.
B) La cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHO).
C) L'embolie pulmonaire.
D) Le bloc auriculo-ventriculaire complet.
E) L'hypotension orthostatique.

Q516. Coarctation de l'aorte

Parmi les cardiopathies cyanogènes :
A) La tétralogie de Fallot.
B) Le ventricule unique.
C) La transposition des gros vaisseaux.
D) L'anévrysme ischémique du ventricule gauche.
E) Le rétrécissement aortique rhumatismal.

Q517. Coarctation de l'aorte

La communication interauriculaire est :
A) Une cardiopathie cyanogène.
B) De type Ostium secundum.
C) De type sinus venosus.
D) De type ostium primum.
E) Caractérisée par un débit pulmonaire augmenté.

Q518. Chirurgie coronaire

Quelles sont les indications admises de l'Echocardiographie de stress :
A) Thrombus intra cardiaque.
B) Endocardite.
C) Evaluation d'une Prothèse valvulaire.
D) Foramen ovale perméable (FOP).
E) Cardiopathie ischémique.

Q519. Traitement de l'infarctus du myocarde

Parmi les contre-indications absolues à la thrombolyse :
A) Hypertension artérielle bien équilibrée.
B) Accident vasculaire cérébral récent.
C) Tumeur cérébrale.
D) Ponction non compressible.
E) Injection sous cutanée.

Q520. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter atrial est :
A) Un trouble de conduction mortel.
B) Asymptomatique parfois.
C) Responsable d'une insuffisance cardiaque.
D) Une trémulation de la ligne isoélectrique à l'ECG de base.
E) Est souvent responsable d'un pouls régulier à l'examen clinique.

Q521. Infarctus du myocarde

Parmi les étiologies de l'infarctus du myocarde quelle est la plus fréquente :
A) Le spasme coronaire.
B) Le rétrécissement aortique.
C) L'athérosclérose coronaire.
D) L'embolie coronaire.
E) Les artérites inflammatoires.

Q522. Endocardite infectieuse

Dans l'endocardite infectieuse, les deux critères majeurs dans la classification de DUKE et LI sont :

A) Les phénomènes vasculaires.
B) Les phénomènes immunologiques.
C) Les hémocultures positives.
D) L'accident vasculaire cérébral chez un jeune.
E) L'imagerie (échocardiographie/PET scanner) en faveur d'une endocardite.

Q523. Troubles du rythme cardiaque

Le Syndrome de Wolf Parkinson White est :
A) Une pré-excitation.
B) Une cardiopathie congénitale.
C) Souvent compliquée d'une tachycardie de Bouveret.
D) Une bradycardie sinusale.
E) Un syndrome coronaire à bas risque.

Q524. Infarctus du myocarde

La thrombose coronaire :
A) Débute par la rupture de la plaque d'athérome.
B) Est favorisée par une vulnérabilité de la plaque d'athérome.
C) L'inflammation n'intervient pas dans ce mécanisme.
D) Peut être favorisée par une poussée hypertensive.
E) Est responsable des syndromes coronaires.

Q525. Infarctus du myocarde

Parmi les complications tardives de l'infarctus du myocarde :
A) Insuffisance cardiaque.
B) Anévrysme du ventricule gauche.
C) Syndrome de Dressler.
D) Embolie pulmonaire.
E) Infarctus splénique.

Q526. IAMI

L'ischémie aiguë des membres inférieurs est caractérisée par :
A) Une symptomatologie alarmante.
B) L'interruption brutale du flux artériel au niveau d'un segment du membre ou tout le membre inférieur.
C) La présence d'un oedème qui prend le godet.
D) La prédominance de l'étiologie traumatique.
E) Un risque à la fois fonctionnel et vital.

Q527. IAMI

L'ischémie aiguë des membres inférieurs peut être :
A) D'origine thrombotique.
B) D'origine embolique.
C) D'origine iatrogène.
D) Une complication d'une dissection aigue de l'aorte étendue aux artères iliaques.
E) Une complication des varices.

Q528. IAMI

La thrombose artérielle aiguë in situ :
A) Est une cause de l'ischémie chronique des membres inférieurs.
B) Est une complication rare des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs.
C) Peut compliquer un traumatisme artériel.
D) Peut survenir sur une artère saine.
E) Constitue une urgence chirurgicale.

Q529. Varices des membres inférieurs

L'ulcère veineux est :
A) Peu profonds non creusant.
B) Profond et creusant.
C) Indolore sauf quand il est infecté.
D) Très douloureux.
E) Une complication aigue des varices des membres inférieurs.

Q530. Varices des membres inférieurs

Parmi les complications chroniques des varices des membres inférieurs on retrouve :
A) La lipodermatosclérose.
B) La gangrène.
C) La paraphlébite.
D) Le purpura.
E) Le syndrome post-thrombotique.

Q531. AOMI

La gangrène du pied en cas d'AOMI :
A) Correspond au stade 2 de l'AOMI.

B) Correspond au stade 4 de l'AOMI.
C) Peut ne pas être présente en cas d'ischémie critique.
D) Est plus grave quand elle est humide.
E) Peut nécessiter un geste chirurgical avant le geste de revascularisation.

Q532. AOMI

Le diagnostic de l'AOMI repose sur :
A) L'analyse des symptômes.
B) La palpation des axes artériels.
C) La mesure des IPS.
D) Une confirmation par échographie doppler vasculaire.
E) Une imagerie avec opacification artérielle.

Q533. AOMI

Le bilan d'extension de l'AOMI comporte :
A) Exploration cardiaque.
B) Exploration cérébro-vasculaire.
C) La recherche d'une sténose de l'artère rénale.
D) Exploration respiratoire.
E) Exploration des cavités rénales.

Q534. AOMI

L'index de pression systolique :
A) Rapport de pression systolique humérale sur la pression de la cheville.
B) Rapport de pression systolique de la cheville sur la pression humérale.
C) Valeur normale est de 0,9.
D) Valeur < 0,9 est signe d'oblitération artérielle.
E) Valeur < 0,5 définit l'ischémie critique.

Q535. AOMI

Le syndrome de Leriche :
A) Correspond à une occlusion de la bifurcation aortique.
B) Se traduit cliniquement par une abolition des pouls fémoraux.
C) Valeur de l'IPS est < 0,9.
D) Le patient présente un Dysfonctionnement érectile.
E) Peut se compliquer d'une péritonite.

Q536. Chirurgie valvulaire

La circulation extracorporelle (CEC) permet de :
A) Perfuser l'ensemble du corps.
B) Remplacer de façon temporaire la fonction cardiaque et pulmonaire.
C) Remplacer la fonction hépatique et la fonction rénale.
D) Ouvrir les cavités cardiaques en toute sécurité.
E) Réaliser la chirurgie à coeur ouvert.

Q537. Chirurgie valvulaire

La circulation extracorporelle nécessite :
A) Une héparinisation générale.
B) Un contrôle du temps de saignement.
C) Un contrôle du temps de céphaline activée (TCA).
D) Une neutralisation de l'héparine par la protamine après sevrage de la CEC.
E) Un traitement immunosuppresseur à base de la cyclosporine.

Q538. Chirurgie coronaire

La cardioplégie permet de :
A) Maintenir une fréquence cardiaque basse.
B) Arrêter l'activité cardiaque.
C) Réduire le risque d'ischémie myocardique.
D) De maintenir une perfusion coronaire au cours de la circulation extracorporelle.
E) Augmenter l'inotropisme myocardique.

Q539. Coarctation de l'aorte

Parmi les conséquences de la coarctation de l'aorte on retrouve :
A) L'hypertension artérielle au niveau de l'hémicorps supérieur.
B) L'hypertrophie du ventricule gauche.
C) L'hypertrophie du ventricule droit.
D) L'hypoperfusion de l'hémicorps inférieur.
E) Le développement des circulations collatérales intercostales, mammaires et péri-scapulaires.

Q540. Traumatisme artériel des membres

Le tableau clinique d'un traumatisme artériel à la phase aiguë peut englober :
A) Un syndrome hémorragique.
B) Un syndrome d'insuffisance veineuse.

C) Un syndrome ischémique.
D) Un faux anévrysme.
E) Un état de choc hémorragique.

Q541. Dissection aortique aigue

Le traitement de la dissection de type « B » de la classification de Stanford :

A) Est toujours chirurgical.
B) Est toujours médical.
C) Est un remplacement de l'aorte ascendante.
D) Peut-être un procédé endovasculaire.
E) Est associé à un traitement thrombolytique.

Q542. Chirurgie valvulaire

Parmi les complications liées aux prothèses valvulaires mécaniques on cite :

A) La défaillance non structurelle (Panus).
B) L'endocardite.
C) La thrombose de la prothèse.
D) La défaillance structurelle.
E) L'hémorragie.

Q543. Chirurgie valvulaire

Le remplacement valvulaire par prothèse mécanique nécessite :

A) Une surveillance régulière du temps de céphaline activée (TCA).
B) Une surveillance régulière de l'International Normalized Ratio (INR).
C) Un traitement anticoagulant à base d'antivitamine K.
D) Un traitement antibiotique au long cours.
E) Une antibioprophylaxie lors d'une extraction dentaire.

Q544. Chirurgie valvulaire

Une patiente âgée de 40 ans suivie une recto-colite hémorragique (RCH) et qui nécessite un remplacement valvulaire pour son rétrécissement mitral. Quelle prothèse vous lui proposeriez en premier lieu :

A) Une prothèse valvulaire mécanique à disque.
B) Une prothèse valvulaire mécanique à bille.
C) Une prothèse valvulaire biologique.
D) Un tube valvé.
E) Une prothèse valvulaire mécanique à ailettes.

Q545. Tamponnade

La tamponnade se manifeste par :

A) Hypotension veineuse.
B) Pouls ample.
C) Hypotension artérielle.
D) Un aspect d'écrasement diastolique des cavités droites à la radiographie du thorax.
E) Un aspect d'écrasement diastolique des cavités droites à l'échocardiographie.

MAI 2021 (NORMALE)

Q546. Insuffisance mitrale

Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant cette auscultation cardiaque anormale ?

A) Insuffisance Aortique.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Aortique.
D) Insuffisance Mitrale.
E) Insuffisance Pulmonaire.

Q547. Insuffisance mitrale

Quels sont les signes électriques habituellement retrouvés lors de cette valvulopathie ?

A) Une fibrillation auriculaire.
B) Une hypertrophie auriculaire gauche.
C) Une hypertrophie ventriculaire gauche type systolique.
D) Un bloc de branche droit.
E) Un bloc auriculo-ventriculaire.

Q548. Insuffisance mitrale

Quel examen paraclinique vous permettra d'apprécier la sévérité de votre valvulopathie ?

A) Le cathétérisme cardiaque droit.
B) L'échocardiographie trans-thoracique.
C) Le scanner cardiaque.
D) La coronarographie.
E) La radiographie pulmonaire.

Q549. Insuffisance mitrale

Parmi les paramètres échocardiographiques suivants quels sont ceux qui permettent une quantification de votre valvulopathie ?
A) Le volume régurgitant (VR).
B) La PHT (pressure half time).
C) Le rayon de PISA.
D) La surface de l'orifice régurgitant (SOR).
E) Aucune des propositions.

Q550. Insuffisance mitrale

Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui signe que votre valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?
A) La SOR retrouvée est > 20 mm².
B) La SOR retrouvée est < 40 mm².
C) La SOR retrouvée est entre 20 et 40 mm².
D) La SOR retrouvée est ? 40 mm².
E) Aucune de ces propositions.

Q551. Insuffisance mitrale

Sur le compte rendu l'échographiste trouve que le mécanisme de cette valvulopathie est une limitation des mouvements valvulaires (restriction) de quel type de la classification de Carpentier s'agit-il ?
A) Type I.
B) Type II.
C) Type III.
D) Type I et III.
E) Aucune des réponses.

Q552. Insuffisance mitrale

Quelle est l'étiologie la plus probable de cette valvulopathie chez cette patiente ?
A) Dégénérative.
B) Endocarditique.
C) Ischémique.
D) Médicamenteuse.
E) Rhumatismale.

Q553. Insuffisance mitrale

Si votre diagnostic clinique se confirme, Quelle est la seule proposition parmi ces propositions qui vous pousseront à proposer une chirurgie à votre patiente même si elle est asymptomatique ?
A) Altération de la fonction systolique avec une FE < 30%.
B) Sévérité de la valvulopathie à l'échocardiographie et un VG dilaté.
C) Augmentation des pressions de remplissage du Ventricule Gauche.
D) Râles crépitants à l'auscultation pulmonaire.
E) L'hypertension pulmonaire.

Q554. Endocardite infectieuse

Cette patiente est admise 6 mois plus tard dans un tableau de détresse respiratoire fébrile vous apprenez de l'entourage qu'elle vient de faire, il y a un mois, un curetage pour une fausse couche, de quelle complication s'agit-il compte tenu de l'histoire clinique de cette patiente ?
A) Un OEdème aigu pulmonaire.
B) Une Endocardite infectieuse.
C) Une crise d'asthme sévère.
D) Une embolie pulmonaire grave.
E) Une infection au SARS-COV 2.

Q555. Insuffisance mitrale

Quel bilan d'opérabilité vous prescrirez à cette patiente ?
A) Une coronarographie.
B) Un groupage ABO- rhésus.
C) Un examen gynécologique complet.
D) Un examen ORL et Odontologique.
E) Un scanner Thoracique.

Q556. Rhumatisme articulaire aigu

A propos du rhumatisme articulaire aigu, quels sont parmi les critères suivants ceux qui sont jugés majeurs dans les critères diagnostiques de JONES modifiés ?
A) La fièvre.
B) La chorée de Sydenham.
C) L'érythème marginé de Besnier.
D) Un Allongement de l'espace PR sur ECG.
E) La polyarthrite migratrice et fugace.

Q557. Insuffisance aortique

A propos de l'insuffisance Aortique chronique :
A) C'est une valvulopathie fuyante en systole.
B) C'est une valvulopathie fuyante en diastole.
C) Peut entraîner une dilatation du ventricule Gauche.

D) Peut entraîner une hypertrophie du ventricule gauche.
E) Elle est Jugée sévère à l'échocardiographie si le VR ? 60ml.

Q558. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie dilatée (CMD) :

A) Est définie par une dilatation ventriculaire avec ou sans dysfonction du VG.
B) Est définie par une altération de la fonction systolique uniquement.
C) Est définie par une dilatation ventriculaire avec dysfonction du VG.
D) Dans la CMD primitive la dilatation ventriculaire est toujours expliquée par les conditions de charge.
E) La CMD peut se compliquer de mort subite.

Q559. Rétrecissement aortique

A propos du Rétrécissement Aortique :

A) Peut se compliquer d'insuffisance ventriculaire gauche.
B) Peut être traité par voie percutanée.
C) Entraine une surcharge barométrique.
D) Donne lieu à un souffle diastolique losangique.
E) Est jugé sévère si la surface aortique est < 1cm².

Q560. Thrombose & Embolie

Devant une suspicion d'embolie pulmonaire, chez un patient stable sur le plan hémodynamique, avec une probabilité clinique forte, l'examen paraclinique de première intention à demander est :

A) L'angioscanner thoracique.
B) Les d-dimères par méthode ELISA.
C) L'angiographie pulmonaire.
D) L'échocardiographie transthoracique.
E) L'échographie doppler veineuse des membres inférieurs.

Q561. Hypertension artérielle

Le Diagnostic de l'hypertension artérielle systémique est posé, selon l'ESH 2018, au cabinet devant :

A) Une pression artérielle systolique PAS ? 135 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ? 85 mmHg.
B) Une pression artérielle systolique PAS ? 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ? 90 mmHg.
C) Une pression artérielle systolique isolée PAS ? 130 mmHg.
D) Une pression artérielle diastolique PAD ? 80 mmHg.
E) Une pression artérielle Moyenne PAM ? 90 mmHg.

Q562. Rétrecissement mitral

Le rétrécissement mitral est un obstacle diastolique, il se manifeste cliniquement par :

A) La Dyspnée d'effort.
B) La triade de Harzer.
C) Un roulement systolique.
D) Un éclat de B2 au foyer pulmonaire.
E) Un frémissement cataire au niveau de la pointe à la palpation.

Q563. Péricardites aigues

La péricardite aiguë est une inflammation du péricarde, elle est diagnostiquée devant la présence de 2 des critères suivants sauf un lequel :

A) Epanchement péricardique.
B) Douleur thoracique péricardique.
C) Turgescence spontanée des veines jugulaires.
D) Nouveau sus décalage ST diffus ou sous décalage PQ à l'ECG.
E) Frottement péricardique.

Q564. Hypertension pulmonaire

L'Hypertension pulmonaire (HTP) est définie hémodynamiquement par une PAPm > 20mmHg au repos elle peut se manifester cliniquement par :

A) Une Dysphonie.
B) Une Dyspnée d'effort.
C) Une Hémoptysie.
D) Une Syncope.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q565. Cardiomyopathie

A propos de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) :

A) Elle est définie par une épaisseur myocardique ? 15mm chez un patient hypertendu.
B) Elle est obligatoirement obstructive.
C) Elle peut se compliquer de mort subite.
D) Elle se manifeste cliniquement dans sa forme obstructive par un souffle diastolique.
E) Elle se manifeste cliniquement dans sa forme obstructive par un souffle systolique.

Q566. Infarctus du myocarde

Le syndrome coronaire sans sus décalage du segment ST avec instabilité rythmique et/ou hémodynamique :

A) Est à très haut risque d'IDM et/ou de mort subite.

B) Nécessite une prise en charge en salle de cardiologie interventionnelle dans un délai de moins de deux heures.
C) Nécessite une épreuve d'effort avant la coronarographie.
D) Nécessite une thrombolyse.
E) Peut être traité par médicaments antithrombotiques seulement.

Q567. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance progressive.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une morsure de langue.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q568. Insuffisance coronaire

Le syndrome coronaire chronique est :

A) L'équivalent du syndrome coronaire avec décalage ST chez le sujet âgé.
B) Une entité clinique englobant l'angor stable.
C) Une urgence immédiate.
D) Nécessite une coronarographie urgente.
E) Est constamment associé à une artériopathie des membres inférieurs.

Q569. Troubles du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire :

A) Peut avoir un rythme ventriculaire régulier lorsqu'elle s'associe un BAV complet.
B) Est de mécanisme catécholinergique lorsqu'elle survient en période post-prandiale.
C) Est à petites mailles dans le rétrécissement mitral.
D) Est plus fréquente chez le sujet jeune.
E) Permanente, augmente le risque de mortalité par insuffisance cardiaque et AVC.

Q570. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter auriculaire :

A) Se définit par une disparition de l'onde P remplacée par l'onde F.
B) Peut-être asymptomatique.
C) Est une micro-réentrée.
D) Est une macro-réentrée.
E) Se complique d'AVC.

Q571. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :

A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q572. Cardiopathie congénitale

La Tétralogie de Fallot se caractérise par :

A) Une communication interventriculaire.
B) Une dextroposition des gros vaisseaux.
C) Une sténose pulmonaire.
D) Une hypertrophie du VD.
E) Une dilatation du ventricule gauche.

Q573. Cardiopathie congénitale

Parmi les cardiopathies non cyanogènes :

A) Communication inter auriculaire.
B) Communication interventriculaire.
C) Canal artériel.
D) Coarctation de l'aorte.
E) Canal atrio-ventriculaire.

Q574. Cardiopathie congénitale

La communication inter auriculaire :

A) Est responsable d'un shunt gauche-droite.
B) Entraine une hypertension pulmonaire.
C) Augmente le débit pulmonaire.
D) Entraine une hypertrophie ventriculaire droite et gauche précoce.
E) Peut se présenter sous quatre formes anatomiques.

Q575. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les indications admises de l'Echographie Trans-OEsophagienne (ETO) :

A) Thrombus intra cardiaque.
B) Endocardite.

C) Evaluation d'une Prothèse valvulaire.
D) Infarctus du myocarde.
E) Hypertension artérielle.

Q576. Électrocardiogramme

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé (tracé irrégulier, ondes F de trémulation, complexe large précoce). Quelle (s) proposition (s) est (sont) exacte (s) :

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré.
C) Il existe une extrasystole ventriculaire.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une extrasystole auriculaire.

Q577. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?

A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q578. Électrocardiogramme

Le syndrome de Wellens est :

A) Un trouble de conduction intra ventriculaire.
B) Une préexcitation.
C) Caractérisé par des ondes T biphasiques en V1V2V3.
D) Nécessite une thrombolyse.
E) En rapport avec une sténose de l'artère de l'interventriculaire antérieure.

Q579. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation antéro-septale se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :

A) En D2-D3-AVF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-AVL.
D) De V1 à V6 et En D2-D3-AVF.
E) V7-V8-V9.

Q580. Traitement de l'infarctus du myocarde

L'acide acétylsalicylique est :

A) Un inhibiteur irréversible de la cyclo-oxygénase 1 (Cox1).
B) Un inhibiteur de la fixation de l'ADP sur les récepteurs GP IIb IIIa de la plaquette.
C) Actif pendant 21jours.
D) Prescrit à une dose de 75-300 mg pour ses effets anti-inflammatoires.
E) Prescrit dans l'infarctus pulmonaire.

Q581. Troubles du rythme cardiaque

En cas de surdosage en antivitaminique K :

A) Il faut toujours faire un saut de prise médicamenteuse.
B) Quand c'est asymptomatique il faut transfuser.
C) Les PPSD sont indiqués si surdosage et hémorragie grave.
D) La vitamine K par voie orale à la dose de 1 ; 2 ; 5 ou 10 mg peut être administrée selon l'état clinique et l'INR.
E) L'abondance du saignement avec retentissement hémodynamique est un signe de gravité.

Q582. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans Oesophagienne (ETO) :

A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Reflexe vaso-vagale.
D) Accident vasculaire cérébral ischémique.
E) Trouble de rythme.

Q583. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q584. Endocardite infectieuse

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf un lequel ?

A) Une splénomégalie.
B) Un purpura.

C) Un hippocratisme digital.
D) Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts.
E) Des adénopathies cervicales.

Q585. Endocardite infectieuse

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :

A) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
B) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative.
E) En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile.

Q586. IAMI

Le diagnostic positif de l'ischémie aiguë des membres inférieurs :

A) Est souvent clinique.
B) Est basé sur l'apport de l'échocardiographie trans-oesophagienne.
C) Est confirmé par l'échodoppler artériel des membres inférieurs.
D) Est confirmé par l'échodoppler veineux des membres inférieurs.
E) Impose souvent une fibrinolyse par voie générale.

Q587. IAMI

Parmi les signes cliniques locaux suivants, quels sont ceux retrouvés dans la forme sensitivo-motrice de l'ischémie aiguë des membres inférieurs :

A) La douleur.
B) La pâleur.
C) Les paresthésies.
D) La raideur.
E) La disparition d'un ou de plusieurs pouls.

Q588. Traumatisme artériel des membres

Comme complications tardives des traumatismes artériels on peut citer :

A) La fistule artério-veineuse.
B) Le faux anévrysme.
C) Le vrai anévrysme.
D) Le syndrome post-thrombotique.
E) L'ischémie d'effort.

Q589. Varices des membres inférieurs

Les varices des membres inférieurs sont caractérisées par :

A) La prédominance d'atteinte féminine.
B) Le risque de complications trophiques.
C) Le risque de thrombose.
D) Le risque de développer un ulcère artériel.
E) Le risque de développer un syndrome ischémique.

Q590. Varices des membres inférieurs

Parmi les techniques du traitement des varices des membres inférieurs on retrouve :

A) La crossectomie avec stripping et phlébectomie.
B) La sclérothérapie par radiofréquence.
C) La ligature des veines profondes.
D) Le laser endoveineux.
E) La fogartisation.

Q591. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte chez le nouveau-né peut se manifester par :

A) Un tableau d'asystolie.
B) Un tableau d'insuffisance cardiaque.
C) Une hypertension artérielle.
D) La présence de pouls fémoraux et l'absence de pouls radiaux.
E) Un pouls fémoral ample et bondissant.

Q592. Coarctation de l'aorte

Le traitement de la coarctation de l'aorte peut se faire par :

A) Résection du segment rétrécis suivi d'un rétablissement de la continuité par anastomose.
B) Remplacement de toute l'aorte descendante.
C) Dilatation au ballonnet.
D) Vasodilatateur.
E) Sclérothérapie.

Q593. Chirurgie coronaire

Parmi les composants de la Circulation Extracorporelle, on distingue :

A) L'oxygénateur.
B) Le respirateur.

C) La pompe.
D) L'échangeur thermique.
E) L'appareil de contrôle du temps de céphaline activée.

Q594. Chirurgie coronaire

La circulation extracorporelle :
A) Draine le sang artériel vers le réservoir.
B) Draine le sang artériel et veineux vers le réservoir.
C) Ramène le sang désoxygéné vers le patient.
D) Est une dérivation externe de la circulation sanguine.
E) Permet d'ouvrir les cavités cardiaques en toute sécurité.

Q595. Chirurgie coronaire

La protection myocardique consiste à :
A) Maintenir une fréquence cardiaque basse.
B) Diminuer le métabolisme myocardique de base.
C) Eviter la distension des cavités cardiaques par décharge des cavités cardiaques.
D) Arrêter l'activité mécanique du coeur par une solution de cardioplégie.
E) Protéger le coeur contre les traumatismes liés à la manipulation chirurgicale.

Q596. AOMI

A propos de l'artériopathie oblitérante chronique des membres inférieurs (AOMI) :
A) Le tabac est un facteur de risque mineur.
B) Le stade IV correspond au stade de la claudication intermittente.
C) Le stade III correspond au stade de l'ischémie de repos.
D) Le stade I est le stade de l'AOMI asymptomatique.
E) La présence d'une gangrène du gros orteil correspond au stade IV.

Q597. AOMI

Les facteurs de risque de l'AOMI sont :
A) Le tabac.
B) Le diabète.
C) L'hyperuricémie.
D) L'hypertension artérielle.
E) Dyslipidémie.

Q598. AOMI

Patient âgé de 70 ans, tabagique chronique et hypertendu, présentant une gangrène du gros orteil droit : L'examen des pouls trouve un bon pouls fémoral droit, le pouls poplité droit est absent :
A) Il s'agit d'une AOMI stade II.
B) Il s'agit d'une AOMI stade IV.
C) L'échodoppler artériel est le premier examen à demander chez ce patient.
D) L'artériographie est le Gold standard pour avoir une meilleure cartographie artérielle.
E) L'urographie intraveineuse est indiquée.

Q599. AOMI

Le Syndrome de Leriche associe :
A) Une claudication intermittente des deux membres inférieurs.
B) Une paralysie du membre.
C) Un trouble de l'érection.
D) Des douleurs lombaires.
E) L'absence des deux pouls fémoraux.

Q600. AOMI

Parmi les moyens thérapeutiques en cas d'AOMI :
A) La prise d'antiagrégants plaquettaires.
B) La rééducation par la marche.
C) La prise de la colchicine.
D) La correction des facteurs de risques cardiovasculaires.
E) L'angioplastie percutanée.

Q601. Dissection aortique aigue

Le type « B » de la classification de Stanford des dissections aigues de l'aorte correspond à la :
A) Dissection intéressant l'aorte ascendante quelle que soit la situation de la porte d'entrée.
B) Dissection intéressant exclusivement l'aorte thoracique.
C) Dissection qui ne touche pas l'aorte ascendante.
D) Dissection intéressant exclusivement l'aorte abdominale.
E) Dissection intéressant l'isthme aortique.

Q602. Chirurgie valvulaire

Les substituts valvulaire biologiques sont caractérisés par :
A) Un risque élevé de thrombose.
B) Une bonne hémocompatibilité.

C) Une mauvaise hémocompatibilité.
D) Une durabilité dépassant les 30 ans.
E) Une faible durabilité.

Q603. Chirurgie valvulaire

Un enfant âgé de 15 ans qui nécessite un remplacement valvulaire aortique ; quelle prothèse vous lui proposeriez :

A) Une prothèse valvulaire mécanique ou une bioprothèse.
B) Une bioprothèse porcine.
C) Une bioprothèse péricardique.
D) Une prothèse valvulaire mécanique à ailettes.
E) Tube valvulé.

Q604. Chirurgie coronaire

Le principe du pontage coronaire est :

A) De court-circuiter la sténose coronaire par un greffon veineux et/ou artériel.
B) De court-circuiter la sténose coronaire par un greffon prothétique.
C) De reséquer l'artère coronaire obstruée.
D) De remplacer l'artère coronaire obstruée par un greffon veineux et/ou artériel.
E) D'élargir la sténose coronaire par un stent.

Q605. Tamponnade

La tamponnade :

A) Est une compression chronique des cavités cardiaques.
B) Est une urgence diagnostique et thérapeutique.
C) Peut être d'origine infectieuse.
D) Nécessite un drainage péricardique percutané ou chirurgical.
E) Peut être traitée par les anti-inflammatoires.

SEPTEMBRE 2020 (RATTRAPAGE)

Q606. Rétrecissement aortique

Quelle est la valvulopathie à évoquer devant ce tableau ?

A) Maladie Mitrale.
B) Rétrécissement pulmonaire.
C) Insuffisance mitrale.
D) Insuffisance aortique.
E) Rétrécissement aortique.

Q607. Rétrecissement aortique

Parmi les étiologies de cette valvulopathie précisez les 3 étiologies les plus fréquentes :

A) Endocardites.
B) Rhumatisme articulaire aigu.
C) Maladie de Mönckeberg.
D) Dissection aortique.
E) Bicuspidie aortique.

Q608. Rétrecissement aortique

Quel examen permettra de poser le diagnostic et de déterminer la sévérité de cette valvulopathie ?

A) Radiographie thoracique.
B) Scanner cardiaque.
C) Cathétérisme cardiaque.
D) Echocardiographie.
E) Test d'effort.

Q609. Rétrecissement aortique

Quel est le signe clinique, parmi ceux que vous avez retrouvé chez votre patient, qui traduit la sévérité de sa valvulopathie ?

A) Dyspnée.
B) TA à 120/70 mmHg.
C) Choc de pointe dévié à gauche.
D) Crépitants diffus au niveau des deux champs pulmonaires.
E) Abolition du 2ème Bruit au foyer aortique.

Q610. Rétrecissement aortique

Parmi ces complications quelles sont les complications possibles chez ce patient ?

A) L'endocardite.
B) La mort subite.
C) L'insuffisance ventriculaire gauche.
D) Troubles de conduction.
E) Accident vasculaire cérébral.

Q611. Rétrecissement aortique

L'échocardiographie fait partie des examens paracliniques réalisés chez votre patient, quels sont les paramètres qui apprécient la

sévérité de cette valvulopathie ?

A) Une surface aortique < 2cm².
B) Une surface aortique 15mm.
C) Une surface Aortique < 1cm².
D) Un gradient moyen aortique > 40mmHg.
E) Aucun de ces paramètres.

Q612. Rétrecissement aortique

Pour décider de l'opérabilité de votre patient quels sont les examens que vous demanderiez ?

A) Examen gynécologique.
B) Sérologie Hépatite B et C et VIH.
C) Coronarographie.
D) Consultation ORL et Odontologie.
E) Groupage ABO et Rhésus.

Q613. Rétrecissement aortique

Quels sont les moyens thérapeutiques dont vous disposez si jamais une indication d'intervention sur la valve est posée ?

A) Mitra clip.
B) Valvuloplastie percutanée par ballon.
C) Remplacement valvulaire Trans-aortique type TAVI.
D) Commissurotomie à coeur fermé.
E) Remplacement valvulaire par bioprothèse.

Q614. Insuffisance mitrale

A propos de l'insuffisance mitrale Aiguë :

A) Peut être d'origine ischémique.
B) Peut être due à une endocardite.
C) Le ventricule gauche a le temps de s'adapter.
D) Entraîne une augmentation aiguë de la pression au niveau de l'oreillette gauche.
E) Peut être responsable d'un tableau d'oedème aigu pulmonaire.

Q615. Insuffisance aortique

Les 3 principales étiologies de l'insuffisance aortique chronique sont :

A) L'ischémie myocardique.
B) L'endocardite infectieuse.
C) L'aortite syphilitique.
D) Le rhumatisme articulaire aigu.
E) La dégénérescence et la dystrophie de la valve aortique.

Q616. Péricardites aigues

La péricardite aigue est une inflammation du péricarde est définie par la présence de 2 critères des critères suivants sauf deux lesquels :

A) Epaississement péricardique.
B) Douleur thoracique péricardique.
C) Nouveau sus décalage du segment ST diffus ou sous décalage de l'espace PQ sur l'ECG.
D) Turgescence des veines jugulaires.
E) Frottement péricardique.

Q617. Thrombose & Embolie

A propos de l'embolie pulmonaire :

A) La douleur thoracique est souvent présente (75% des cas), elle est de type pleural.
B) Peut se manifester par des crachats hémoptoïques noirâtres.
C) Les gaz du sang sont toujours anormaux.
D) Le dosage des D-Dimères par méthode ELISA a une valeur prédictive positive élevée.
E) L'examen non invasif de première intention est l'angioscanner spiralé multi-Barrettes.

Q618. Thrombose & Embolie

Quelles sont les propositions fausses à propos de la thrombose veineuse profonde surale :

A) Les anomalies constatées à l'examen clinique sont toujours bilatérales.
B) Le signe de Homans traduit l'augmentation de la chaleur locale.
C) Il existe souvent une tachycardie plus importante que le niveau de fièvre.
D) L'échographie veineuse fait le diagnostic en objectivant la disparition de la compressibilité de la veine.
E) La phlébite bleue associe une phlébite à une ischémie artérielle.

Q619. Péricardites chroniques constrictives

La péricardite chronique constrictive est un épaississement du péricarde assimilé à une coque rigide pouvant entraîner :

A) Une augmentation du remplissage cardiaque.
B) Des hépatalgies d'effort.
C) Une dyspnée.
D) Une vibrance péricardique à l'auscultation.
E) Des troubles de rythme supraventriculaires.

Q620. Hypertension artérielle

A propos de l'hypertension artérielle (HTA) :

A) Sa mesure en dehors du cabinet fait appel à deux techniques : la MAPA et l'automesure.

B) Est définie par l'O.M.S comme une pression artérielle systolique (PAS) >= 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) >= 90 mmHg.

C) Le fond d'oeil fait partie du bilan complémentaire initial.

D) La coarctation de l'aorte est une étiologie possible de l'HTA secondaire.

E) Les antihypertenseurs centraux sont des médicaments de première intention dans le traitement de l'HTA.

Q621. Tamponnade

A propos de la tamponnade :

A) C'est une compression chronique des cavités cardiaques par un épanchement péricardique.

B) Réalise un obstacle au remplissage systolique des ventricules.

C) Est caractérisée cliniquement par la triade de Beck.

D) L'examen clé au diagnostic est le scanner cardiaque.

E) L'embolie pulmonaire massive peut constituer un diagnostic différentiel.

Q622. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Dans l'insuffisance cardiaque :

A) La dyspnée est le maître symptôme.

B) L'hypertension artérielle (HTA) peut en constituer une étiologie.

C) Est dite à fraction d'éjection (FE) basse si cette dernière est strictement inférieure à 50%.

D) Dans sa présentation chronique un taux de BNP 35pg/ml rend son diagnostic peu probable.

E) Les diurétiques de l'anse permettent de réduire les signes congestifs.

Q623. Cardiomyopathie restrictive

Dans la cardiomyopathie restrictive :

A) Le remplissage ventriculaire est de type constrictif.

B) Les parois ventriculaires sont toujours épaissies.

C) La principale étiologie est l'amylose.

D) Le principal diagnostic différentiel est la péricardite chronique constrictive.

E) Le traitement de choix est chirurgical se basant sur la décortication des feuillets péricardiques.

Q624. Rétrecissement mitral

Le rétrécissement mitral est :

A) Un obstacle à l'éjection ventriculaire gauche en diastole.

B) Un obstacle au remplissage ventriculaire gauche en diastole.

C) Un obstacle à l'éjection ventriculaire gauche en systole.

D) Un obstacle à l'éjection ventriculaire gauche en systole et en diastole.

E) Aucune des réponses.

Q625. Rhumatisme articulaire aigu

Dans le Rhumatisme articulaire aigu (RAA) :

A) Le traitement se base uniquement sur les anti-inflammatoires.

B) Les antibiotiques sont les seuls traitements.

C) La benzathine pénicilline est utilisable en une seule injection intramusculaire à raison de 1200000 UI quand le poids du patient dépasse 30 kg.

D) L'érythromycine est utilisable en prévention primaire pour traiter les angines streptococciques.

E) La durée minimale de la prophylaxie secondaire après un épisode de RAA sans cardite est de 5 ans.

Q626. Troubles de conduction

Vous réalisez un ECG de repos dont voici le tracé. Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) :

A) Le rythme cardiaque est sinusal.

B) Il existe un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré.

C) Il existe une extrasystole ventriculaire.

D) Il existe une fibrillation auriculaire.

E) Il existe une onde Q de nécrose dans le territoire inférieur.

Q627. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance progressive.

B) Précédée par des prodromes.

C) Accompagnée constamment d'une morsure de langue.

D) Une récupération spontanée après la chute.

E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q628. Endocardite infectieuse

Concernant les lésions caractérisant l'endocardite infectieuse :

A) Elles peuvent survenir sur des valves déjà altérées.

B) Le nodule d'Aschoff représente la lésion pathognomonique.

C) Les végétations sont irrégulières et friables.

D) Elles peuvent se compliquer d'embolisation systémique.

E) Peuvent disparaitre sous traitement adéquat.

Q629. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques : nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q630. Endocardite infectieuse

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :

A) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
B) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative.
E) En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile.

Q631. Endocardite infectieuse

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf un. Lequel ?

A) Une splénomégalie.
B) Un purpura.
C) Un hippocratisme digital.
D) Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts.
E) Des adénopathies cervicales.

Q632. Cardiomyopathie

Parmi les cardiopathies cyanogènes :

A) Communication inter auriculaire.
B) Communication interventriculaire.
C) Canal artériel.
D) Coarctation de l'aorte.
E) Canal atrio ventriculaire.

Q633. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire du premier degré repose sur :

A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme d'échappement inférieur à 30/min.
C) Onde P en dents de scie.
D) Espace PR allongé.
E) Rythme irrégulier.

Q634. Infarctus du myocarde

L'électrocardiogramme en douleur (per critique) peut objectiver :

A) Un sous-décalage du segment ST.
B) Un sus-décalage en AVR.
C) Un Fibrillation auriculaire.
D) Un tracé plat.
E) Rarement un sus-décalage du segment ST.

Q635. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire complet repose sur :

A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme ventriculaire régulier.
C) Onde de PARDEE.
D) Tachycardie régulière.
E) Espace PR allongé.

Q636. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans-Oesophagienne (ETO) :

A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Reflexe vaso-vagale.
D) Paraplégie.
E) Endocardite infectieuse.

Q637. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 6 dérivations de bases.
D) 5 complexes par dérivation.
E) Onde P négative en DI (électrodes non inversés).

Q638. Troubles du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme :
A) Qui peut s'observer dans l'évolution d'une hyperthyroïdie.
B) Qui peut entraîner des embolies systémiques.
C) Qui peut déclencher la survenue d'une insuffisance cardiaque.
D) Qui peut être réduit par les manoeuvres vagales.
E) Qui doit être traité par anticoagulant et antiarythmique.

Q639. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?
A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q640. Hypertension artérielle

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?
A) Tabagisme.
B) Hypertension artérielle.
C) Diabète.
D) Rétrécissement mitral.
E) Activité physique.

Q641. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus du myocarde sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est juste. Laquelle ?
A) Douleur à la palpation.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) Sensible à la trinitrine.
D) Toujours à l'effort.
E) De durée brève.

Q642. Infarctus du myocarde

Précisez deux étiologies de l'infarctus du myocarde :
A) Athérosclérose coronaire.
B) Spasme coronaire.
C) Dissection aortique.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Hyperleucocytose.

Q643. Électrocardiogramme

L'électrocardiogramme est un examen :
A) Indolore.
B) Invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q644. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation inférieure se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation
A) En D2-D3-VF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-VL.
D) De V1 à V6.
E) De V4 à V6.

Q645. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les indications admises de l'Echographie Trans-Oesophagienne (ETO) :
A) Thrombus intra cardiaque.
B) Endocardite.
C) Evaluation d'une Prothèse valvulaire.
D) Infarctus du myocarde.
E) Hypertension artérielle.

Q646. IAMI

Comme conséquences générales de l'ischémie aiguë des membres inférieurs, on peut retrouver :
A) Une hypokaliémie.
B) Une myoglobinémie.
C) Une acidose respiratoire.
D) Choc hypovolémique.
E) Acidose métabolique.

Q647. IAMI

Dans la forme sensitivo-motrice de l'ischémie aiguë des membres inférieurs on retrouve les signes cliniques locaux suivants :
A) La douleur.
B) La pâleur.
C) Les paresthésies.
D) La froideur.
E) La disparition d'un ou de plusieurs pouls.

Q648. IAMI

Parmi les techniques de revascularisation de l'ischémie aiguë des membres inférieurs, on cite :
A) Le pontage.
B) La fogartisation.
C) La fibrinolyse per-opératoire in situ.
D) L'angioplastie.
E) Le stripping.

Q649. Varices des membres inférieurs

Les varices des membres inférieurs peuvent être secondaire à :
A) Un syndrome post-thrombotique.
B) Une compression veineuse extrinsèque chronique.
C) Une insuffisance valvulaire primitive.
D) Une dysgénésie valvulaire.
E) Un traumatisme.

Q650. Varices des membres inférieurs

Parmi les signes cliniques des varices des membres inférieurs on retrouve :
A) Un oedème de stase.
B) Un oedème de rétention hydrosodée.
C) Des phlébectasies.
D) Une froideur des membres inférieurs.
E) Des claudications intermittentes.

Q651. Varices des membres inférieurs

Parmi les complications aigues des varices des membres inférieurs on retrouve :
A) La thrombophlébite superficielle.
B) L'ulcère veineux.
C) La rupture.
D) L'ischémie aigue.
E) La lipodermatosclérose.

Q652. Varices des membres inférieurs

Le traitement endo-veineux des varices comporte :
A) La sclérothérapie.
B) La cryochirurgie.
C) Le laser endo-veineux.
D) L'éveinage.
E) Le traitement par Radiofréquence.

Q653. Coarctation de l'aorte

Parmi les signes suivants, quels sont ceux observés lors d'une coarctation de l'aorte :
A) Un pouls fémoral ample.
B) Une hypertension artérielle systolo-diastolique de l'hémicorps inférieur.
C) Un pouls radial ample.
D) Un souffle continu au niveau de l'espace inter-scapulo-vertébral gauche.
E) Des encoches costales sur la radiographie du thorax.

Q654. Chirurgie valvulaire

La circulation extracorporelle (CEC) permet de :
A) Perfuser principalement les organes viscéraux.
B) Remplacer de façon temporaire la fonction cardiaque et pulmonaire.
C) Remplacer la fonction hépatique.
D) Remplacer la fonction rénale.
E) Réaliser les pontages aorto-coronaires à coeur battant.

Q655. Chirurgie coronaire

La circulation extracorporelle :
A) Draine le sang artériel vers le réservoir.
B) Draine le sang artériel et veineux.
C) Ramène le sang désoxygéné vers le patient.
D) Est une dérivation interne de la circulation sanguine.
E) Permet d'ouvrir les cavités cardiaques en toute sécurité.

Q656. AAA

L'anévrysme de l'aorte abdominale (AAA) se développe préférentiellement au niveau de la :

A) Aorte ascendante.
B) Crosse de l'aorte.
C) Aorte descendante.
D) Aorte abdominale sus rénale.
E) Aorte abdominale sous rénale.

Q657. AOMI

A propos des facteurs de risques de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs :
A) Le diabète.
B) L'hypertension artérielle.
C) L'hyperuricémie.
D) Le tabac.
E) La prise des antiagrégants plaquettaires.

Q658. AOMI

Le diagnostic de l'AOMI repose sur :
A) L'analyse des symptômes cliniques que rapporte le patient.
B) La palpation des axes artériels au niveau des membres inférieurs.
C) La mesure de l'index de la pression systolique (IPS).
D) La radio de poumon.
E) L'Echodoppler artériel.

Q659. AAA

Patient âgé de 70 ans, hypertendu, présentant une masse battante, expansive et soufflante de la région péri-ombilicale :
A) Il faut suspecter un sarcome abdominal.
B) Il faut suspecter un anévrysme de l'aorte abdominale.
C) Cliniquement on peut savoir si l'anévrysme est exclusivement sous rénal.
D) L'anévrysme est sous rénal quand le signe de Homans est positif.
E) L'anévrysme de l'aorte est sous-rénale si le Signe de DeBakey est positif.

Q660. AOMI

Patient âgé de 60 ans, tabagique chronique, présentant une claudication intermittente du membre inférieur droit avec un périmètre de marche de 40 mètres sans troubles trophiques :
A) Il s'agit d'une AOMI stade II.
B) Il s'agit d'une AOMI stade IV.
C) La claudication intermittente est modérée.
D) La claudication intermittente est sévère.
E) Le premier examen à demander chez ce patient est l'Echodoppler artériel des membres inférieurs.

Q661. Chirurgie valvulaire

Parmi les complications des prothèses valvulaires mécaniques on note :
A) Le rejet de greffe.
B) L'hémolyse.
C) La thrombose valvulaire.
D) L'endocardite infectieuse.
E) La thrombophlébite.

Q662. Chirurgie valvulaire

Les substituts valvulaires biologiques sont caractérisés par :
A) Une bonne hémocompatibilité.
B) Une mauvaise hémocompatibilité.
C) Une durabilité dépassant les 30 ans.
D) Un risque élevé de thrombose.
E) Un faible risque de dégénérescence.

Q663. Chirurgie valvulaire

Le remplacement valvulaire par prothèse mécanique nécessite :
A) Une surveillance régulière du temps de céphaline activée (TCA).
B) Une surveillance régulière de l'International Normalized Ratio (INR).
C) Un traitement anticoagulant à base d'antivitamine K.
D) Un traitement antibiotique au long cours.
E) Une antibioprophylaxie lors d'une extraction dentaire.

Q664. Chirurgie coronaire

La chirurgie coronaire peut se faire :
A) En association avec un remplacement valvulaire.
B) Par sternotomie médiane.
C) Par greffons veineux.
D) A coeur arrêté sous circulation extracorporelle.
E) A coeur battant.

Q665. Tamponnade

Le diagnostic positif de la tamponnade repose essentiellement sur :

A) L'échocardiographie transthoracique et/ou transoesophagienne.
B) La radiographie du thorax.
C) L'élévation de la vitesse de sédimentation (VS).
D) L'Holter ECG.
E) La numération formule sanguin (NFS).

JUILLET 2020 (RATTRAPAGE)

Q666. IAMI

L'ischémie aiguë des membres inférieurs est caractérisée par :
A) La latence clinique.
B) L'interruption brutale du flux artériel au niveau d'un segment du membre ou tout le membre inferieur.
C) La présence d'un oedème qui prend le godet.
D) La prédominance de l'étiologie embolique.
E) La régression spontanée.

Q667. IAMI

La Thrombose artérielle aiguë in situ :
A) Peut survenir sur une artère saine.
B) Peut survenir sur un pontage artériel.
C) Peut compliquer une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
D) Complique rarement un traumatisme artériel.
E) Fait partie des étiologies de l'ischémie aiguë des membres inférieurs.

Q668. IAMI

Le diagnostic positif de l'ischémie aiguë des membres inférieurs :
A) Est souvent clinique.
B) Est basé sur l'apport de l'échocardiographie trans-oesophagienne.
C) Est confirmé par l'échodoppler artériel des membres inférieurs.
D) Est confirmé par l'augmentation du taux sanguin des lactates.
E) Impose souvent une fibrinolyse.

Q669. IAMI

Dans la forme non sensitivo-motrice de l'ischémie aiguë des membres inférieurs on retrouve les signes cliniques locaux suivants :
A) La douleur.
B) La pâleur.
C) Les paresthésies.
D) La froideur.
E) La disparition d'un ou de plusieurs pouls.

Q670. Varices des membres inférieurs

Les varices des membres inférieurs sont caractérisées par :
A) La présence de dilatations, tortueuses, permanentes des veines superficielles entravant le retour veineux.
B) L'origine exclusivement primaire.
C) La prédominance d'atteinte féminine.
D) Le risque de complications trophiques.
E) Le risque de développer un syndrome ischémique.

Q671. Varices des membres inférieurs

Parmi les complications chroniques des varices des membres inférieurs on retrouve :
A) La Lipodermatosclérose.
B) La gangrène.
C) L'atrophie blanche de Milian.
D) La dermite pigmentée purpurique.
E) Le syndrome post-thrombotique.

Q672. Varices des membres inférieurs

Parmi les techniques chirurgicales du traitement des varices des membres inférieurs on retrouve :
A) La crossectomie avec stripping et phlébectomie.
B) La phlébectomie.
C) La ligature des veines profondes.
D) La ligature des perforantes incontinentes.
E) La fogartisation.

Q673. Coarctation de l'aorte

La coarctation de l'aorte est une pathologie qui associe :
A) Une hypertension au niveau de l'hémicorps supérieur.
B) Une hypertension au niveau de l'hémicorps inférieur.
C) Une hypertrophie du ventricule gauche.
D) Des circulations collatérales mammaires, épigastriques, et intercostales.
E) Des circulations collatérales fémorales, et brachiales.

Q674. Coarctation de l'aorte

Le traitement de la coarctation de l'aorte peut être :

A) Chirurgical.
B) Endovasculaire.
C) Ne peut être proposé qu'à l âge adulte.
D) Doit être proposé dès le diagnostic.
E) Peut consister en un remplacement de toute l'aorte descendante.

Q675. Chirurgie valvulaire

Parmi les composants de la Circulation Extracorporelle, on distingue :

A) L'oxygénateur.
B) Les canules.
C) La pompe.
D) L'échangeur thermique.
E) L'appareil de contrôle du temps de céphaline activée.

Q676. AAA

L'anévrysme de l'aorte abdominale (AAA) sous rénale est défini par :

A) Simple ectasie de l'aorte.
B) Dilatation focale avec perte de parallélisme des parois.
C) Dilatation focale et permanente sans perte de parallélisme des parois.
D) Sténose focale de l'aorte.
E) Dilatation veineuse.

Q677. AAA

Les examens radiologiques diagnostiques à demander en cas d'un Anévrysme de l'aorte abdominale :

A) Echographie abdominale.
B) Urographie intraveineuse.
C) Angioscanner abdominal.
D) Coronarographie.
E) Echographie vésico-prostatique.

Q678. AAA

Le traitement de l'anévrysme de l'aorte abdominale peut se faire par les techniques suivantes :

A) Stenting de l'artère fémorale.
B) La chirurgie par mise à plat greffe de l'anévrysme.
C) Un pontage fémoro-jambier.
D) Une prothèse totale de hanche.
E) La mise en place d'une endoprothèse aortique.

Q679. AOMI

A propos de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs :

A) Le tabagisme chronique est un facteur de risque mineur.
B) En cas de claudication intermittente la rééducation par la marche est un élément important du traitement.
C) Le traitement par antiagrégant plaquettaire à long court est toujours indiqué.
D) Le traitement par Colchicine est efficace.
E) La mesure de l'index de pression systolique (IPS) complète les données de l'examen clinique.

Q680. AOMI

Patients âgé de 60 ans, tabagique chronique et hypertendu présentant une claudication intermittente des deux membres inférieurs avec à l'examen l'absence des deux pouls fémoraux :

A) Il s'agit d'une artériopathie fémoro-jambière.
B) Il s'agit d'un syndrome de Leriche.
C) Il faut pratiquer un angioscanner thoracique.
D) Il faut demander en premier lieu un Echodoppler artériel des membres inférieurs.
E) Il faut rechercher à l'interrogatoire des troubles de l'érection.

Q681. Dissection aortique aigue

Le type « A » de la classification de Standford des dissections aigues de l'aorte correspond à la :

A) Dissection qui ne touche pas l'aorte ascendante.
B) Dissection intéressant l'aorte ascendante quelle que soit la situation de la porte d'entrée.
C) Dissection intéressant exclusivement l'aorte abdominale.
D) Dissection intéressant exclusivement l'aorte descendante.
E) Dissection intéressant exclusivement l'aorte thoracique.

Q682. Chirurgie valvulaire

Un patient âgé de 80 ans qui nécessite un remplacement valvulaire aortique, quelle prothèse vous lui proposeriez en premier lieu ?

A) Une prothèse valvulaire mécanique à disque.
B) Une prothèse valvulaire mécanique à bille.
C) Une prothèse valvulaire biologique.
D) Une prothèse valvulaire mécanique à double ailettes.
E) Un tube valvé.

Q683. Chirurgie valvulaire

Les trois complications redoutables de la prothèse valvulaire mécanique sont :

A) L'acidose métabolique.
B) L'endocardite.
C) Les accidents thrombo-emboliques.
D) La défaillance structurelle.
E) L'hémorragie.

Q684. Chirurgie coronaire

Le principe du pontage coronaire est :

A) De reséquer l'artère coronaire obstruée.
B) De ligaturer l'artère coronaire obstruée.
C) De remplacer l'artère coronaire obstruée.
D) D'élargir la sténose coronaire par un stent.
E) De court-circuiter la sténose coronaire par un greffon.

Q685. Tamponnade

La tamponnade :

A) Constitue une urgence purement médicale.
B) Peut compliquer une dissection aigue de l'aorte.
C) Ne peut être d'origine infectieuse.
D) Nécessite un drainage péricardique percutané ou chirurgical.
E) Peut être traitée par les diurétiques.

Q686. Insuffisance aortique

Quelle est la valvulopathie à évoquer en premier devant ce tableau (Cas Clinique Ahmed B.) ?

A) Insuffisance Mitrale.
B) Rétrécissement Mitral.
C) Maladie Aortique.
D) Insuffisance Aortique.
E) Insuffisance Pulmonaire.

Q687. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quels sont les signes d'insuffisance ventriculaire gauche parmi ceux que rapporte le patient ?

A) La fièvre.
B) La tension artérielle à 136/42 mmHg.
C) La dyspnée.
D) Les râles crépitants à l'auscultation pulmonaire.
E) L'hyperpulsatilité artérielle.

Q688. Insuffisance aortique

Quels sont cliniquement les signes de sévérité de cette valvulopathie ?

A) Élargissement de la pression artérielle différentielle avec une PAD < 50mmHg.
B) Un souffle diastolique très intense au foyer aortique.
C) Un roulement diastolique de Flint.
D) L'absence de pouls périphériques.
E) L'existence d'un claquement mésosystolique ou pistol-shot.

Q689. Insuffisance aortique

Parmi les paramètres échocardiographiques suivants quels sont ceux qui permettent une quantification de cette valvulopathie ?

A) Le volume régurgitant (VR).
B) La PHT (pressure half time).
C) La vitesse maximale du flux.
D) La surface de l'orifice régurgitant (SOR).
E) Aucune des propositions.

Q690. Insuffisance aortique

Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui signe que cette valvulopathie est sévère échocardiographiquement ?

A) La SOR retrouvée est > 60 mm².
B) La SOR retrouvée est < 60 mm².
C) La SOR retrouvée est entre 20 et 40 mm².
D) La SOR retrouvée est ? 30mm².
E) Aucune de ces propositions.

Q691. Insuffisance aortique

Cette valvulopathie est responsable de :

A) Une surcharge Barométrique (de pression).
B) Une surcharge volumétrique.
C) Une surcharge mixte (barométrique et volumétrique).
D) Aucune surcharge.
E) Aucune des réponses.

Q692. Endocardite infectieuse

Quelle est l'étiologie la plus probable de cette valvulopathie chez ce patient ?
A) Ischémique.
B) Dégénérative.
C) Endocarditique.
D) Dilatation annulaire.
E) Rhumatismale.

Q693. Insuffisance aortique

Le tableau clinique et paraclinique de cette valvulopathie dans sa forme aigue est souvent caractérisé par :
A) Un OEdème aigu pulmonaire.
B) Etat de choc cardiogénique.
C) Hypertrophie ventriculaire gauche quasi-constante à l'ECG.
D) Cardiomégalie quasi-constante à la radiographie thoracique de face.
E) Aucun de ces signes.

Q694. Rhumatisme articulaire aigu

A propos du rhumatisme articulaire aigu :
A) Est une réponse inflammatoire, suppurative due au streptocoque béta hémolytique de type A.
B) La polyarthrite est migratrice et fugace ne donne pas de séquelle articulaire.
C) La fièvre est un critère majeur parmi les critères diagnostiques de JONES modifiés.
D) Un taux d'ASLO > 100UI/ml signe une infection streptococcique récente.
E) La chorée de Sydenham est un critère majeur parmi les critères diagnostiques de JONES modifiés.

Q695. Rhumatisme articulaire aigu

La cardite rhumatismale peut réaliser une pancardite, elle peut être caractérisée par :
A) Une endocardite rhumatismale septique.
B) Un souffle de fuite mitrale.
C) Une péricardite avec frottement péricardique à l'auscultation.
D) Une douleur thoracique traduisant une atteinte myocardique.
E) Aucun de ces signes.

Q696. Insuffisance mitrale

A propos de l'insuffisance mitrale chronique :
A) C'est une valvulopathie fuyante en systole.
B) C'est une valvulopathie fuyante en diastole.
C) Entraine une dilatation du ventricule Gauche.
D) L'intensité du souffle est corrélée à l'importance de la fuite.
E) Elle est Jugée sévère à l'échocardiographie si la SOR ? 30mm².

Q697. Rétrecissement aortique

A propos du Rétrécissement aortique :
A) Peut entrainer une dilatation de l'aorte ascendante.
B) Entraine une surcharge de volume.
C) Donne lieu à un souffle systolique losangique.
D) Est jugé sévère si la surface aortique est < 1cm².
E) Peut se compliquer d'une mort subite.

Q698. Thrombose & Embolie

Une femme de 45 ans obèse, suivie pour cancer du sein sous traitement se présente aux urgences pour Dyspnée d'apparition brutale et d'une hémoptysie, on suspecte une embolie pulmonaire, sa probabilité clinique, en calculant le score de Wells, est jugée intermédiaire :
A) L'angioscanner est le premier examen à demander pour confirmer une embolie pulmonaire.
B) Les d-dimères est le premier examen à demander.
C) La tachypnée est souvent associée en cas d'embolie pulmonaire.
D) L'examen clinique peut être normal en cas d'embolie pulmonaire.
E) Une échographie veineuse des membres inférieurs normale exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire.

Q699. Rétrecissement mitral

Le rétrécissement mitral est un obstacle diastolique, il peut se compliquer de :
A) Mort subite.
B) Fibrillation auriculaire.
C) Infarctus pulmonaire.
D) Accident ischémique transitoire.
E) Insuffisance ventriculaire droite.

Q700. Insuffisance cardiaque de l'adulte

Quels sont parmi les signes suivants les signes cliniques typiques d'insuffisance cardiaque :
A) Dyspnée.
B) Toux nocturne.
C) Confusion mentale.
D) Dyspnée paroxystique nocturne.
E) Respiration sifflante.

Q701. Hypertension pulmonaire

L'Hypertension pulmonaire (HTP) est définie hémodynamiquement par une :

A) Pression artérielle pulmonaire moyenne (PAPm) ? 15 mmHg au repos.
B) Pression artérielle pulmonaire diastolique (PAPd) > 15 mmHg au repos.
C) Pression artérielle pulmonaire moyenne > 25 mmHg au repos.
D) Pression artérielle pulmonaire moyenne > 25 mmHg à l'effort.
E) Aucune des propositions ci-dessus.

Q702. Hypertension artérielle

L'hypertension artérielle systémique est définie par l'OMS comme une :

A) Pression artérielle systolique PAS ? 140 mmHg.
B) Pression artérielle diastolique PAD ? 90 mmHg.
C) Pression artérielle Moyenne PAM ? 90 mmHg.
D) Pression artérielle systolique PAS ? 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ? 90 mmHg.
E) Pression artérielle systolique PAS ? 130 mmHg.

Q703. Hypertension artérielle

Parmi les étiologies de l'HTA secondaire on peut énumérer :

A) La coarctation de l'aorte.
B) L'usage des contraceptifs oestro-progestatifs.
C) Le phéochromocytome.
D) La sténose des artères rénales.
E) La consommation de la réglisse.

Q704. Péricardites aigues

A propos de la douleur thoracique dans les péricardites aigues :

A) Elle est insensible à la trinitrine.
B) Peut mimer un syndrome coronarien aigu.
C) Est calmée par la position penchée en avant.
D) Diminue à l'inspiration profonde.
E) Est rythmée par les repas.

Q705. Cardiomyopathie

La cardiomyopathie hypertrophique est caractérisée par :

A) Une dilatation cavitaire quasi-constante.
B) Une fonction systolique normale ou supranormale.
C) Une obstruction est présente dans la moitié des cas.
D) La complication majeure à craindre est la mort subite.
E) Les traitements médicamenteux de 1ère intention sont les bétabloquants.

Q706. Coarctation de l'aorte

La Tétralogie de Fallot se caractérise par (non inclus dans les sources spécifiques Fallot mais mentionnée en association) :

A) Une communication interventriculaire.
B) Une dextroposition des gros vaisseaux.
C) Une sténose pulmonaire.
D) Une hypertrophie du VD.
E) Une dilatation du ventricule gauche.

Q707. Hypertension pulmonaire

Parmi les cardiopathies non cyanogènes :

A) Communication inter auriculaire.
B) Communication interventriculaire.
C) Canal artériel.
D) Coarctation de l'aorte.
E) Canal atrio ventriculaire.

Q708. Hypertension pulmonaire

La communication inter auriculaire est caractérisée par :

A) Il est responsable d'un shunt gauche-droite.
B) Il entraine une hypertension pulmonaire.
C) Augmente le débit pulmonaire.
D) Entraine une hypertrophie ventriculaire droite et gauche précoce.
E) Peut se présenter sous quatre formes anatomiques.

Q709. Électrocardiogramme

Parmi les critères de bonne qualité d'un ECG :

A) Tracé lisse non parasité.
B) Etalonnage 25mm/s 10mm/1mv.
C) 12 dérivations de bases.
D) 5 complexes par dérivation.
E) Onde P positive en DI (électrodes non inversés).

Q710. Endocardite infectieuse

Concernant les lésions qui caractérisent l'endocardite infectieuse :
A) Elles peuvent survenir sur des valves déjà altérées.
B) Le nodule d'Aschoff représente la lésion pathognomonique.
C) Les végétations sont irrégulières et friables.
D) Elles peuvent se compliquer d'embolisation systémique.
E) Peuvent disparaitre sous traitement adéquat.

Q711. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :
A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques : nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q712. Endocardite infectieuse

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :
A) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
B) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative.
E) En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile.

Q713. Endocardite infectieuse

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf un. Lequel ?
A) Une splénomégalie.
B) Un purpura.
C) Un hippocratisme digital.
D) Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts.
E) Des adénopathies cervicales.

Q714. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus du myocarde sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est fausse. Laquelle ?
A) Douleur intense.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) A irradiations larges.
D) De type constrictif.
E) Calmée par la trinitrine.

Q715. Infarctus du myocarde

Quelles sont les deux complications majeures de la maladie athéroscléreuse ?
A) Valvulopathie.
B) Endocardite infectieuse.
C) Embolie pulmonaire.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Infarctus du myocarde.

Q716. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation antéro-septale se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :
A) D2-D3-VF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-VL.
D) De V1 à V6 et en En D2-D3-VF.
E) De V4 à V6.

Q717. Troubles du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire :
A) Peut avoir un rythme ventriculaire régulier lorsqu'elle s'associe un BAV complet.
B) Est de mécanisme catécholinergique lorsqu'elle survient en période post-prandiale.
C) Est à petites mailles dans le rétrécissement mitral.
D) Est plus fréquente chez le sujet jeune.
E) Permanente, augmente le risque de mortalité par insuffisance cardiaque et AVC.

Q718. Troubles du rythme cardiaque

Le flutter auriculaire :
A) Se définit par une disparition de l'onde P remplacée par l'onde F.
B) Peut être asymptomatique.
C) Est une micro-réentrée.
D) Est une macro-réentrée.
E) Se complique d'AVC.

Q719. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire complet repose sur :
A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme d'échappement régulier.
C) Onde de PARDEE.
D) Tachycardie irrégulière.
E) Flutter.

Q720. Echographie transthoracique

Lors d'une Echocardiographie trans-thoracique, les fenêtres d'exploration possibles sont :
A) Apicale.
B) Sous costale.
C) Sus pubienne.
D) Supra-sternale.
E) Parasternale.

Q721. Infarctus du myocarde

Quelles sont les étiologies des syndromes coronaires sans sus décalage du segment ST (NSTEMI) ?
A) Syndrome de rupture de plaque athéromateuse.
B) Trouble de la microcirculation coronaire.
C) Embolie coronaire.
D) Endocardite.
E) Mort subite.

Q722. Infarctus du myocarde

L'électrocardiogramme dans un SCA sans sus ST peut objectiver :
A) Un sous-décalage du segment ST dans le territoire de l'ischémie.
B) Une Modification de l'onde T régressive après la disparition de la douleur.
C) Un Flutter.
D) Un tracé plat.
E) Rarement un sus-décalage du segment ST.

Q723. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans-Oesophagienne (ETO) :
A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Reflexe vaso-vagale.
D) Accident vasculaire cérébral ischémique.
E) Trouble de rythme.

Q724. Syncope

La syncope se définit par :
A) Perte de connaissance brutale.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une morsure de langue.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q725. Syncope

Parmi les étiologies d'une syncope d'origine cardiaque :
A) Le rétrécissement aortique.
B) L'embolie pulmonaire.
C) Le bloc auriculo ventriculaire.
D) Vaso-vagale.
E) Trouble du rythme ventriculaire (torsade de pointe).

JUIN 2019 (RATTRAPAGE)

Q726. Troubles du rythme cardiaque

La communication interauriculaire (CIA) se caractérise par :
A) Elle est asymptomatique chez le nourrisson.
B) Evolue vers la fermeture spontanée.
C) Entraîne une dilatation du ventricule droit (VD).
D) Entraîne un dédoublement fixe de B2 pulmonaire.
E) Le risque de survenue d'une fibrillation auriculaire (FA).

Q727. Syncope

La Tétralogie de Fallot se caractérise par :
A) Une communication interventriculaire.
B) Une malposition des gros vaisseaux.
C) Une sténose pulmonaire.
D) Une hypertrophie du VD.

E) Une dilatation du ventricule gauche.

Q728. Syncope

Parmi les symptômes de la Tétralogie de Fallot on trouve :

A) La cyanose.
B) L'hypotrophie.
C) Le squatting.
D) Les malaises anoxiques.
E) La transpiration.

Q729. Endocardite infectieuse

Le canal atrioventriculaire (CAV) est caractérisé par :

A) Sa grande fréquence chez les patients ayant une trisomie 21.
B) Il est responsable d'un shunt gauche-droite.
C) Il entraîne une hypertension pulmonaire précoce.
D) Non traité, il évolue vers le syndrome d'Eisenmenger.
E) Peut se fermer spontanément.

Q730. Cardiomyopathie restrictive

La cardiomyopathie restrictive (CMR) se caractérise par :

A) Une altération de la fonction systolique et diastolique du VG.
B) Une insuffisance cardiaque gauche prédominante.
C) La difficulté de diagnostic différentiel avec la péricardite chronique constrictive (PCC).
D) L'échocardiographie est suffisante pour le bilan étiologique.
E) Elle régresse sous traitement spécifique.

Q731. Cardiomyopathie restrictive

L'étiologie principale de la cardiomyopathie restrictive est :

A) L'amylose cardiaque.
B) L'hémochromatose.
C) Le diabète.
D) L'hypertension artérielle.
E) La maladie de Fabry.

Q732. Cardiomyopathie

Les circonstances de découverte d'une cardiomyopathie dilatée (CMD) sont :

A) Lors d'un bilan de myopathie.
B) Une insuffisance cardiaque globale inaugurale.
C) Une enquête familiale autour d'un cas de CMD.
D) Une dissection de l'aorte.
E) Un accident vasculaire cérébral.

Q733. Cardiomyopathie

Parmi les médicaments utilisés dans la CMD on trouve :

A) Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.
B) Les inhibiteurs calciques.
C) Les bêtabloquants.
D) Les diurétiques.
E) Les corticoïdes.

Q734. Hypertension pulmonaire

Les situations à éviter en cas d'hypertension pulmonaire (HTP) sont :

A) Le séjour au bord de la mer.
B) La rachi-anesthésie.
C) La grossesse.
D) Le sport.
E) Le travail.

Q735. Hypertension pulmonaire

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) peut être associée à :

A) La sclérodermie.
B) L'infection par le VIH.
C) L'hypertension portale.
D) La fibrose pulmonaire.
E) La cardiopathie congénitale type shunt gauche-droite.

Q736. Hypertension pulmonaire

Le traitement spécifique de l'HTAP comporte :

A) Les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5.
B) Les inhibiteurs des récepteurs à l'angiotensine.
C) Les antagonistes des récepteurs de l'endothéline.
D) Les inhibiteurs calciques.
E) Les prostacyclines.

Q737. Cardiomyopathie

Parmi les facteurs étiologiques des cardiopathies congénitales on trouve :

A) La trisomie 21.
B) L'éthylisme maternel.
C) La prise des antibiotiques.
D) L'infection maternelle par le virus de la rubéole au cours de la grossesse.
E) La prise de paracétamol.

Q738. Infarctus du myocarde

Sur cet ECG de repos, quelle proposition est exacte ?

A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auricule-ventriculaire complet.
C) Les ondes T sont normalement négatives.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une onde de PARDEE dans le territoire inférieur.

Q739. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans Oesophagienne (ETO) :

A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Réflexe vaso-vagale.
D) Accident vasculaire cérébral ischémique.
E) Trouble de rythme.

Q740. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance brutale.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une morsure de langue.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q741. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques : nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q742. Infarctus du myocarde

Quelles sont les deux complications majeures de la maladie athéroscléreuse ?

A) Valvulopathie.
B) Endocardite infectieuse.
C) Embolie pulmonaire.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Infarctus du myocarde.

Q743. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire complet repose sur :

A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme d'échappement inférieur à 30/min.
C) Rythme d'échappement régulier.
D) Espace PR allongé.
E) Rythme régulier sinusal.

Q744. Troubles du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire :

A) Peut avoir un rythme ventriculaire régulier lorsqu'elle s'associe un BAV complet.
B) Est de mécanisme catécholallergique lorsqu'elle survient en période post-prandiale.
C) Est petites mailles dans le rétrécissement mitral.
D) Est plus fréquente chez le sujet jeune.
E) Permanente, augmente le risque de mortalité par insuffisance cardiaque et AVC.

Q745. Endocardite infectieuse

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf un. Lequel ?

A) Une splénomégalie.
B) Un purpura.
C) Un hippocratisme digital.
D) Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts.
E) Des adénopathies cervicales.

Q746. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus du myocarde sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est fausse. Laquelle ?

A) Douleur intense.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) A irradiations larges.
D) De type constrictif.
E) Calmée par la trinitrine.

Q747. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation antéro-septale se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :

A) D2-D3-VF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-VL.
D) De V1 à V6 et en D2-D3-VF.
E) De V4 à V6.

Q748. Infarctus du myocarde

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?

A) Tabagisme.
B) Hypertension artérielle.
C) Contraceptifs oraux.
D) Rétrécissement mitral.
E) La sédentarité.

Q749. Endocardite infectieuse

Une endocardite Infectieuse doit être soupçonnée :

A) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
B) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative.
E) En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile.

Q750. Endocardite infectieuse

Citez cinq portes d'entrée à rechercher lors d'une endocardite infectieuse.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q751. Endocardite infectieuse

Citez cinq signes cutanéo-muqueux d'une endocardite infectieuse.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q752. Infarctus du myocarde

Citez quatre complications tardives de l'infarctus du myocarde.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q753. Électrocardiogramme

Un homme de 50 ans, diabétique sous insuline et tabagique chronique, se présente aux urgences à la première heure d'une douleur thoracique intense. Décrivez son ECG.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

MAI 2019 (NORMALE)

Q754. Hypertension pulmonaire

L'hypertension pulmonaire (HTP) est caractérisée par :

A) Une pression pulmonaire moyenne ?30mmHg.
B) Est classée en 5 groupes.
C) Le groupe 2 est représenté par l'HTP due aux cardiopathies gauches.
D) Un pronostic bon.
E) Nécessite une prise en charge multidisciplinaire.

Q755. Hypertension pulmonaire

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) peut être :

A) Idiopathique.
B) Héréditaire.
C) Associée à une sclérodermie.
D) Associée à une maladie respiratoire.
E) Associée à une maladie thromboembolique chronique.

Q756. Hypertension pulmonaire

Les signes fonctionnels de l'HTP sont :
A) L'intolérance à l'effort.
B) L'angine de poitrine.
C) Les syncopes à l'effort.
D) Les douleurs thoraciques.
E) Les douleurs abdominales.

Q757. Hypertension pulmonaire

Parmi les bilans à faire devant la suspicion d'HTP, on cite :
A) La radiographie du thorax.
B) L'électrocardiogramme (ECG).
C) L'échocardiographie.
D) La tomographie par émission de positons.
E) L'exploration fonctionnelle respiratoire.

Q758. Cardiomyopathie

Les cardiomyopathies sont caractérisées par :
A) Une dysfonction cardiaque obligatoire.
B) L'association avec une affection valvulaire.
C) Le risque de mort subite.
D) Le caractère souvent familial/génétique.
E) Un bon pronostic.

Q759. Cardiomyopathie

Parmi les types de cardiomyopathies, on trouve :
A) La cardiomyopathie dilatée (CMD).
B) La cardiomyopathie hypertrophique (CMH).
C) La cardiomyopathie hypertensive.
D) La cardiomyopathie restrictive (CMR).
E) La cardiomyopathie arythmogène.

Q760. Cardiomyopathie

Les éléments physiopathologiques d'une CMH sont :
A) Une obstruction systolique par mouvement systolique antérieur de la grande valve mitrale (SAM).
B) Une fonction systolique altérée.
C) Une fonction diastolique normale.
D) Une ischémie myocardique induite par l'effort.
E) Une réactivité vasculaire anormale à l'effort.

Q761. Cardiomyopathie

Parmi les signes électriques (ECG) d'une CMH, on trouve :
A) Une hypertrophie ventriculaire gauche.
B) Un bloc de branche droit.
C) Des ondes T négatives de V1 à V6.
D) Des troubles de rythme ventriculaires.
E) Un bloc auriculo-ventriculaire.

Q762. Cardiomyopathie

Parmi les facteurs étiologiques de la survenue d'une cardiopathie congénitale, on trouve :
A) Le diabète maternel mal équilibré.
B) L'infection par le virus de la rubéole au cours de la grossesse.
C) La trisomie 21.
D) La prise de paracétamol.
E) Le lupus érythémateux disséminé.

Q763. Hypertension pulmonaire

Les conséquences d'un shunt G-D sont :
A) La cyanose.
B) L'augmentation du débit pulmonaire.
C) La déformation thoracique.
D) Les malaises anoxiques.
E) Le retard staturo-pondéral.

Q764. Endocardite infectieuse

La communication interventriculaire se caractérise par :
A) C'est la plus fréquente des cardiopathies congénitales.
B) Peut entraîner une hypotrophie du nourrisson.
C) Peut évoluer vers un syndrome d'Eisenmenger.
D) Peut se fermer spontanément.
E) Ne se complique jamais d'endocardite.

Q765. Coarctation de l'aorte

La transposition des gros vaisseaux se caractérise par :

A) C'est la cardiopathie cyanogène la plus fréquente en période néonatale.
B) L'auscultation cardiaque retrouve un souffle systolique.
C) Se traduit à la naissance par une cyanose avec détresse respiratoire.
D) Nécessite une manoeuvre de Rashkind.
E) Nécessite un Switch artériel au cours des premières semaines de vie.

Q766. Électrocardiogramme

Sur un ECG de repos montrant un sus-décalage du segment ST en II, III et aVF. Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) :
A) Le rythme cardiaque est sinusal.
B) Il existe un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré.
C) Les ondes T sont normalement négatives.
D) Il existe une fibrillation auriculaire.
E) Il existe une onde de PARDEE dans le territoire inférieur.

Q767. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans Oesophagienne (ETO) :
A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Reflexe vaso-vagale.
D) Accident vasculaire cérébral ischémique.
E) Trouble de rythme.

Q768. Endocardite infectieuse

Concernant les lésions qui caractérisent l'endocardite infectieuse :
A) Elles peuvent survenir sur des valves déjà altérées.
B) Le nodule d'Aschoff représente la lésion pathognomonique.
C) Les végétations sont irrégulières et friables.
D) Elles peuvent se compliquer d'embolisation systémique.
E) Peuvent disparaître sous traitement adéquat.

Q769. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :
A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q770. Endocardite infectieuse

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :
A) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
B) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative.
E) En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile.

Q771. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire complet repose sur :
A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme d'échappement inférieur à 30/min.
C) Rythme d'échappement régulier.
D) Nombre d'ondes P supérieur au nombre de QRS.
E) Nombre d'ondes P inférieur au nombre de QRS.

Q772. Troubles du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme :
A) Qui peut s'observer dans l'évolution d'une cardiothyréose.
B) Qui peut entraîner des embolies systémiques.
C) Qui peut déclencher la survenue d'une insuffisance cardiaque.
D) Qui peut être réduit par les manoeuvres vagales.
E) Qui peut être dégradé par la prescription de statine.

Q773. Infarctus du myocarde

La plaque d'athérome :
A) C'est une lésion réversible.
B) Comporte un centre lipidique et une chape fibreuse.
C) Disparaît après traitement hypolipémiant.
D) Peut se compliquer d'une embolie pulmonaire.
E) Peut se calcifier.

Q774. Infarctus du myocarde

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?
A) Tabagisme.

B) Hypertension artérielle.
C) Contraceptifs oraux.
D) Rétrécissement mitral.
E) la sédentarité.

Q775. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications classiques aiguës des SCA ST+ antérieurs?

A) Insuffisance cardiaque gauche.
B) Insuffisance cardiaque droite.
C) Embolie pulmonaire.
D) Rupture septale.
E) Mort subite.

Q776. Syncope

QROC 1 : Citez quatre étiologies des syncopes d'origine cardiaque.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q777. Endocardite infectieuse

QROC 2 : Énumérez les composants physiopathologiques de l'endocardite infectieuse.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q778. Endocardite infectieuse

QROC 3 : Quels sont les principes du traitement de l'endocardite infectieuse ?

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q779. Varices des membres inférieurs

Question rédactionnelle : Décrire les complications des varices des membres inférieurs.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q780. Varices des membres inférieurs

QROC n°1 : Citer les différentes techniques chirurgicales du traitement des varices des membres inférieurs.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q781. IAMI

QROC n°2 : Citer les étiologies de l'ischémie aiguë des membres inférieurs.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q782. IAMI

QROC n°3 : Citer les signes cliniques de l'ischémie aiguë des membres inférieurs dans sa forme non sensitivo-motrice.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

Q783. Chirurgie valvulaire

QROC n°4 : Citer les complications des bioprothèses valvulaires.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas ?

EXCEPTIONNEL 2019

Q784. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les indications admises de l'Echographie Trans Oesophagienne (ETO) :

A) Thrombus intra cardiaque.
B) Endocardite.
C) Prothèse valvulaire.
D) Communication inter auriculaire.
E) Hypertension artérielle.

Q785. Echographie transoesophagienne

Quelles sont les complications possibles lors d'un examen par Echographie Trans Oesophagienne (ETO) :

A) Spasme laryngé.
B) Perforation digestive.
C) Reflexe vaso-vagale.
D) Accident vasculaire cérébral ischémique.
E) Hémorragie.

Q786. Echographie transthoracique

Lors d'une Echocardiographie trans thoracique, les fenêtres d'exploration possibles sont :

A) Apicale.
B) Sous costale.
C) Sus pubienne.
D) Suprasternale.
E) Parasternale.

Q787. Électrocardiogramme

L'Electrocardiogramme est un examen :

A) Indolore.
B) Non invasif.
C) Rapide.
D) Nécessite une anesthésie.
E) Couteux.

Q788. AOMI

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l'athérosclérose ?

A) Tabagisme.
B) Hypertension artérielle.
C) Contraceptifs oraux.
D) Rétrécissement mitral.
E) La sédentarité.

Q789. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus myocardique sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est fausse. Laquelle ?

A) Douleur intense.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) A irradiations larges.
D) De type constrictif.
E) Calmée par la trinitrine.

Q790. Endocardite infectieuse

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf un. Lequel ?

A) Une splénomégalie.
B) Un purpura.
C) Un hippocratisme digital.
D) Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts.
E) Des adénopathies cervicales.

Q791. AOMI

Quelles sont les deux complications majeures de la maladie athéroscléreuse ?

A) Valvulopathie.
B) Endocardite infectieuse.
C) Embolie pulmonaire.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Infarctus du myocarde.

Q792. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire du premier degré repose sur :

A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme d'échappement inférieur à 30/min.
C) Rythme d'échappement régulier.
D) Espace PR allongé.
E) Rythme régulier sinusal.

Q793. Syncope

La syncope se définit par :

A) Perte de connaissance brutale.
B) Précédée par des prodromes.
C) Accompagnée constamment d'une morsure de langue.
D) Une récupération spontanée après la chute.
E) Diminution brutale du débit sanguin cérébral.

Q794. Endocardite infectieuse

Parmi les critères majeurs pour le diagnostic d'une endocardite infectieuse (EI) selon Duke et Li, on note :

A) Deux hémocultures positives à des bactéries successibles de causer une EI.
B) Présences de phénomènes immunologiques: nodosité d'Osler et/ou taches de Roth.
C) Echocardiographie montrant une végétation et/ou un abcès.
D) Souffle cardiaque de rétrécissement aortique.
E) Erythème de Janeway.

Q795. Troubles du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme :

A) Qui peut s'observer dans l'évolution d'une cardiothyréose.
B) Qui peut entraîner des embolies systémiques.
C) Qui peut déclencher la survenue d'une insuffisance cardiaque.
D) Qui peut être réduit par les manoeuvres vagales.
E) Qui peut être dégradé par la prescription de statine.

Q796. Endocardite infectieuse

Concernant les lésions qui caractérisent l'endocardite infectieuse :
A) Elles peuvent survenir sur des valves déjà altérées.
B) Le nodule d'Aschoff représente la lésion pathognomonique.
C) Les végétations sont irrégulières et friables.
D) Elles peuvent se compliquer d'embolisation systémique.
E) Peuvent disparaître sous traitement adéquat.

Q797. Infarctus du myocarde

Quelles sont les complications de l'infarctus du myocarde ?
A) Troubles du rythme.
B) Complications mécaniques.
C) Complications hémodynamiques.
D) Mort subite.
E) Crise d'asthme.

Q798. Infarctus du myocarde

Quelles sont les étiologies de l'infarctus du myocarde :
A) Athérosclérose coronaire.
B) Spasme coronaire.
C) Dissection coronaire.
D) Accident vasculaire cérébral.
E) Après une chirurgie digestive.

Q799. Infarctus du myocarde

L'électrocardiogramme en douleur (per critique) peut objectiver :
A) Un sous-décalage du segment ST dans le territoire de l'ischémie.
B) Modification de l'onde T régressive après la disparition de la douleur.
C) Un Flutter.
D) Un tracé plat.
E) Rarement un sus-décalage du segment ST.

Q800. Infarctus du myocarde

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'infarctus myocardique sont bien connus. Une des propositions ci-dessous est juste. Laquelle ?
A) Douleur à la palpation.
B) De siège thoracique médian rétrosternal.
C) A irradiations vers les membres inférieurs.
D) Toujours à type de brûlure.
E) De durée brève.

Q801. Infarctus du myocarde

Un infarctus de localisation inférieur se traduit sur l'ECG par une onde Q et des troubles de la repolarisation :
A) En D2-D3-VF.
B) De V1 à V4.
C) En D1-VL.
D) De V1 à V6 et en D2-D3-VF.
E) De V4 à V6.

Q802. Endocardite infectieuse

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :
A) En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans.
B) En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile.
C) En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans.
D) En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque.
E) En présence d'un érythème noueux.

Q803. Troubles de conduction

Le diagnostic électrocardiographique du bloc auriculo-ventriculaire complet repose sur :
A) Dissociation auriculo-ventriculaire.
B) Rythme d'échappement régulier.
C) Onde de PARDEE.
D) Tachycardie irrégulière.
E) Flutter.

Q804. Électrocardiogramme

QROC n°1: Citez trois éléments à contrôler pour avoir un ECG de bonne qualité.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q805. Syncope

QROC n°2: Citez trois étiologies des syncopes d'origine cardiaque.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q806. Endocardite infectieuse

QROC n°3: Citez trois portes d'entrée à rechercher lors d'une endocardite infectieuse.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q807. Endocardite infectieuse

QROC n°4: Citez trois signes cutanéo-muqueux d'une endocardite infectieuse.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q808. Troubles du rythme cardiaque

Une femme de 50 ans, diabétique sous insuline et hypertendue, présente des palpitations. L'ECG montre une absence d'ondes P, des intervalles RR irréguliers et des complexes QRS fins. Son rythme cardiaque est-il irrégulier ? Si oui de quelle pathologie s'agit-il ?

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q809. Rhumatisme articulaire aigu

Question rédactionnelle n°1: Enumérer les critères diagnostiques de Jones modifiés et décrire les principes thérapeutiques du Rhumatisme articulaire aigu.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q810. Rétrecissement aortique

Question rédactionnelle n°2: Définir le rétrécissement aortique, citer ses principales étiologies, et décrire les signes auscultatoires dans sa forme pure.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q811. IAMI

Question rédactionnelle: Décrire le diagnostic positif de l'ischémie aiguë des membres inférieurs.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q812. Chirurgie coronaire

QROC n°1: Décrire brièvement trois complications de la circulation extracorporelle (CEC).

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q813. Coarctation de l'aorte

QROC n°2: Citer deux techniques du traitement chirurgical de la coarctation de l'isthme aortique.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q814. Traumatisme artériel des membres

QROC n°3: Citer les tableaux cliniques d'un traumatisme artériel.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q815. Chirurgie valvulaire

QROC n°4: Enumérer les avantages des bioprothèses valvulaires.

A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: A	Q02: A	Q03: A	Q04: C, D	Q05: B
Q06: E	Q07: A, B, C, D	Q08: E	Q09: B, C, D, E	Q10: A, B, C, D
Q11: C	Q12: C, D	Q13: B	Q14: C	Q15: A, C, E
Q16: A, C, D	Q17: B, C	Q18: A, B	Q19: A, B, D	Q20: C, D
Q21: A	Q22: B	Q23: A, D, E	Q24: C, D	Q25: A, B, C, E
Q26: A, B, C, D	Q27: A, B, D	Q28: A, C, D	Q29: A, B, D	Q30: A, B, E
Q31: A, B, C, D, E	Q32: A	Q33: C	Q34: E	Q35: B, D
Q36: A, B, C, D	Q37: B	Q38: E	Q39: E	Q40: A
Q41: B	Q42: A, B, D	Q43: A, B, C	Q44: A, B, D, E	Q45: A, C, D
Q46: A, B, C, D, E	Q47: A, D	Q48: A, C, D	Q49: B, C, E	Q50: B, C, E
Q51: E	Q52: A, C, D	Q53: B	Q54: B	Q55: D
Q56: A	Q57: D	Q58: A, B	Q59: A, B, C, D, E	Q60: B, C, E
Q61: C, D, E	Q62: C, D, E	Q63: E	Q64: A	Q65: A, B, C, D
Q66: C	Q67: A, B, E	Q68: A, B, E	Q69: A, D	Q70: A, C, D
Q71: A	Q72: C	Q73: B	Q74: A, B	Q75: A, C
Q76: A, D, E	Q77: A, B	Q78: A, C, D, E	Q79: C, D	Q80: A
Q81: A, B, C, D	Q82: A, B, C, D, E	Q83: A, B, C, D, E	Q84: A, B, D, E	Q85: C, D
Q86: A, B, C	Q87: A, B, C, D	Q88: A, D, E	Q89: A, C, D, E	Q90: A, C, D, E
Q91: B, D, E	Q92: C	Q93: C, D	Q94: A, B, C, D, E	Q95: A, C, D, E
Q96: A, B	Q97: A, B, C, D, E	Q98: A, C	Q99: B, C, D	Q100: C, D, E
Q101: A, B, C, E	Q102: A, B, D, E	Q103: D	Q104: E	Q105: B, C, D
Q106: B, C, D	Q107: A, D	Q108: A, C, D	Q109: A, B, D	Q110: B, C, E
Q111: A	Q112: A	Q113: A	Q114: A	Q115: A
Q116: A	Q117: A	Q118: B	Q119: C	Q120: B
Q121: E	Q122: E	Q123: D	Q124: A	Q125: A
Q126: B	Q127: B, C, D	Q128: A, D	Q129: B, E	Q130: C, D, E
Q131: B	Q132: D	Q133: E	Q134: A, C, E	Q135: A, E
Q136: B, C, D, E	Q137: C, D, E	Q138: A, B	Q139: A, C, E	Q140: A, B, C, D, E
Q141: A, B, C, D, E	Q142: C	Q143: A, D, E	Q144: A	Q145: B, C
Q146: A, C	Q147: A, B, C	Q148: A, B	Q149: B	Q150: A, B, C, E
Q151: A, B, C, D	Q152: A, B	Q153: A, B, C, D	Q154: B, C	Q155: B
Q156: A, C	Q157: A, B, C	Q158: B, E	Q159: C	Q160: B
Q161: B	Q162: B, C, D, E	Q163: A, C, E	Q164: B, D	Q165: C, D, E
Q166: A, B, C	Q167: C	Q168: A, B, C, D	Q169: B, D	Q170: A, C, D
Q171: A	Q172: B, C, D, E	Q173: A, B	Q174: A, B, D, E	Q175: A, B, E
Q176: D	Q177: A, B, E	Q178: B	Q179: A, B	Q180: B
Q181: B	Q182: B	Q183: E	Q184: E	Q185: C

Q186: B, C, D	Q187: C, E	Q188: B, C, D, E	Q189: B, C, D	Q190: C, E
Q191: A, B, E	Q192: B	Q193: A	Q194: A, B, D, E	Q195: C
Q196: C	Q197: D, E	Q198: A, E	Q199: A, E	Q200: A
Q201: A, C, D, E	Q202: D, E	Q203: B, D	Q204: A, B, C, D	Q205: A, B, D, E
Q206: A, C	Q207: A, B, C, D	Q208: A, B	Q209: A, B, C, E	Q210: A, B
Q211: A, B, C	Q212: B	Q213: A, B, D, E	Q214: A, C	Q215: A, C
Q216: A, E	Q217: A, B, C	Q218: A, C, E	Q219: B, C, D, E	Q220: B, E
Q221: C, D, E	Q222: B, C, D, E	Q223: A, B, C, E	Q224: A, B, C, D, E	Q225: A, B, C, D, E
Q226: C, D, E	Q227: A, B, C, D, E	Q228: A, B, C, D, E	Q229: A, B, C	Q230: A, C, E
Q231: B, D, E	Q232: A, B, D	Q233: B, C, E	Q234: D	Q235: C, E
Q236: B, C, D	Q237: B	Q238: A	Q239: A	Q240: A
Q241: A	Q242: A	Q243: A	Q244: A	Q245: A
Q246: C, E	Q247: C, E	Q248: C	Q249: E	Q250: D
Q251: D	Q252: B, D	Q253: A, B, D, E	Q254: B, D, E	Q255: A, B, D
Q256: E	Q257: A, B	Q258: D, E	Q259: D, E	Q260: A
Q261: B, C	Q262: B, E	Q263: B, D, E	Q264: C, D	Q265: A, B, C, D
Q266: A, E	Q267: A, B, C, E	Q268: A, B, C, D	Q269: C	Q270: A, B
Q271: A, C	Q272: A, B, C	Q273: A, B, D, E	Q274: B, C, D	Q275: A, B, C
Q276: A, B	Q277: A, B, D, E	Q278: B	Q279: A, B, D, E	Q280: A, B, C, D
Q281: A, B, C, D, E	Q282: A	Q283: A, B, C	Q284: A	Q285: A, B, C
Q286: B, C, D	Q287: A, B, C, E	Q288: A, B, E	Q289: A, C, D, E	Q290: A, C, D
Q291: A, B, C, D	Q292: A, C	Q293: A, B	Q294: D	Q295: B, C, D
Q296: C, D	Q297: A, B, C, D	Q298: B, C, E	Q299: A, B	Q300: B, C, D, E
Q301: A, B, C, D, E	Q302: B, C, D, E	Q303: A, C	Q304: A, B, D	Q305: B, C, D, E
Q306: E	Q307: D, E	Q308: B	Q309: E	Q310: D
Q311: C	Q312: D	Q313: B, C	Q314: A, C, D	Q315: C, E
Q316: E	Q317: A, B	Q318: C, D	Q319: D, E	Q320: E
Q321: E	Q322: C	Q323: B, C, D, E	Q324: E	Q325: B, C
Q326: C	Q327: A, C	Q328: C, D, E	Q329: A, B, C, E	Q330: A, B, C, D, E
Q331: A, B, C	Q332: A, C	Q333: A, B, C	Q334: A, B, D, E	Q335: A, B, C, D, E
Q336: B, C, D	Q337: A, B, C, D	Q338: A, B, C, D	Q339: A, B, D	Q340: A, B, C, D, E
Q341: A, C	Q342: A, B, C, D	Q343: A, C	Q344: A	Q345: A, B, C
Q346: A, B, D, E	Q347: A, C	Q348: A, B, C	Q349: A, C, D	Q350: D, E
Q351: A, C, D, E	Q352: A, C, E	Q353: A, B, C	Q354: A, C, D, E	Q355: A
Q356: A, C, D	Q357: A, C, E	Q358: A, D	Q359: A, B, C, D, E	Q360: A, B, C
Q361: B, C, E	Q362: A, C, D, E	Q363: B, C	Q364: B, C, E	Q365: A, D, E
Q366: E	Q367: A, C, D, E	Q368: D	Q369: C	Q370: A
Q371: D	Q372: C	Q373: B, D	Q374: D	Q375: A, B
Q376: E	Q377: A, B, C, D	Q378: B, C, E	Q379: A, B, E	Q380: A, D

Q381: D, E	Q382: B	Q383: D	Q384: C, D, E	Q385: E
Q386: A	Q387: B	Q388: A, C, D, E	Q389: A, B, C, D, E	Q390: A, B
Q391: B, D	Q392: A, B, D	Q393: A, B, C	Q394: A, B, D, E	Q395: A, B, C, D, E
Q396: C	Q397: A, C, D	Q398: D	Q399: A, B, C, D, E	Q400: A, B
Q401: A, B	Q402: A, B	Q403: A, C, D, E	Q404: A, B, C, D	Q405: E
Q406: A, C, D	Q407: A, B, C	Q408: A, B	Q409: D	Q410: E
Q411: A, D	Q412: A, B, C, D, E	Q413: A, E	Q414: A, B, C, D	Q415: A, D, E
Q416: A, C	Q417: B, C, D	Q418: B, D	Q419: A, C, D, E	Q420: A, B, C, D, E
Q421: A, B, C	Q422: C	Q423: A, B, C, E	Q424: A, B, D, E	Q425: B, D
Q426: D	Q427: A, C, D	Q428: B	Q429: B	Q430: D
Q431: A	Q432: A	Q433: C, E	Q434: A, C, D, E	Q435: A, B, C, D
Q436: A, D	Q437: C, D, E	Q438: C, D, E	Q439: B, D, E	Q440: A, D, E
Q441: A, D	Q442: A	Q443: C, D, E	Q444: B, C, D, E	Q445: E
Q446: B	Q447: A	Q448: A, B, C, D, E	Q449: D, E	Q450: B, C
Q451: A, B, C	Q452: A, B, D, E	Q453: A, C	Q454: A, B, C, D	Q455: B
Q456: A, B, C	Q457: A, B, C	Q458: B	Q459: A, B	Q460: A, B, D
Q461: A, C	Q462: E	Q463: A, C, E	Q464: D, E	Q465: A, B, C
Q466: B, D, E	Q467: B, C, E	Q468: A, C, D	Q469: C, D	Q470: A, C, E
Q471: B, C, E	Q472: A, B, D	Q473: A, C, E	Q474: D	Q475: B, D
Q476: B, C, D	Q477: A, C, D, E	Q478: A, C, D	Q479: A, C, D, E	Q480: D, E
Q481: A, C, D	Q482: B, C, D, E	Q483: B, C, D, E	Q484: A, B, D	Q485: A, B, D, E
Q486: D	Q487: B, C, D	Q488: B, E	Q489: E	Q490: D
Q491: A	Q492: A	Q493: B, E	Q494: C, D, E	Q495: B, C, D, E
Q496: A, D	Q497: B	Q498: B, E	Q499: A	Q500: B
Q501: E	Q502: B, C, E	Q503: D	Q504: B, C, E	Q505: A, C
Q506: A, D, E	Q507: A, C, E	Q508: D	Q509: A, B, D, E	Q510: B, E
Q511: A, D	Q512: C	Q513: A	Q514: A, B, C	Q515: A, B, C, D
Q516: A, B, C	Q517: B, C, D, E	Q518: E	Q519: B, C, D	Q520: B, C, E
Q521: C	Q522: C, E	Q523: A, C	Q524: A, B, D, E	Q525: A, B, C
Q526: A, B, E	Q527: A, B, C, D	Q528: C, D, E	Q529: A, C	Q530: A
Q531: B, C, D, E	Q532: A, B, C, D, E	Q533: A, B, C	Q534: B, C, D, E	Q535: A, B, C, D
Q536: A, B, D, E	Q537: A, C, D	Q538: B, C	Q539: A, B, D, E	Q540: A, C, E
Q541: D	Q542: A, B, C, E	Q543: B, C, E	Q544: C	Q545: C, E
Q546: D	Q547: A, B	Q548: B	Q549: A, C, D	Q550: D
Q551: C	Q552: D	Q553: B	Q554: B	Q555: B, C, D
Q556: B, C, E	Q557: B, C, D, E	Q558: B, E	Q559: A, B, C, E	Q560: A
Q561: B	Q562: A, D, E	Q563: C	Q564: A, B, C, D	Q565: C, E
Q566: A, B	Q567: D, E	Q568: B	Q569: A, E	Q570: A, B, D, E
Q571: A, C	Q572: A, B, C, D	Q573: A, B, C, D, E	Q574: A, B, C	Q575: A, B, C

Q576: A, C	Q577: A, B, C, D	Q578: C, E	Q579: B	Q580: A
Q581: C, D, E	Q582: A, B, C, E	Q583: A, C	Q584: E	Q585: A, B, C, D
Q586: A, C	Q587: A, B, C, E	Q588: A, B, E	Q589: A, B, C	Q590: A, B, D
Q591: A, B	Q592: A, C	Q593: A, C, D	Q594: D, E	Q595: B, C, D
Q596: C, D, E	Q597: A, B, D, E	Q598: B, C, D	Q599: A, C, E	Q600: A, B, D, E
Q601: C	Q602: B, E	Q603: D	Q604: A	Q605: B, C, D
Q606: E	Q607: B, C, E	Q608: D	Q609: E	Q610: A, B, C, D, E
Q611: C, D	Q612: B, C, D, E	Q613: B, C, E	Q614: A, B, D, E	Q615: B, D, E
Q616: A, E	Q617: A, B, E	Q618: A, B	Q619: B, C, D, E	Q620: A, C, D
Q621: C, E	Q622: A, B, D, E	Q623: C, D	Q624: B	Q625: C, D, E
Q626: A, C, E	Q627: D, E	Q628: A, C, D, E	Q629: A, C	Q630: A, B, C, D
Q631: C	Q632: E	Q633: D	Q634: A, B, E	Q635: A, B
Q636: A, B, C	Q637: A, B, D	Q638: A, B, C, E	Q639: A, B, C, D	Q640: A, B, C
Q641: B	Q642: A, B	Q643: A, C	Q644: A	Q645: A, B, C
Q646: B, D, E	Q647: A, B, C, D, E	Q648: A, B, C, D	Q649: A, B, C, D	Q650: A, C
Q651: A, C	Q652: A, B, C, E	Q653: C, D, E	Q654: B	Q655: E
Q656: E	Q657: A, B, D	Q658: A, B, C, E	Q659: B, C, E	Q660: A, D, E
Q661: B, C, D	Q662: A	Q663: B, C, E	Q664: A, B, C, D, E	Q665: A
Q666: D	Q667: C, D	Q668: A, C, E	Q669: A, B, D	Q670: D
Q671: C	Q672: C	Q673: A, B	Q674: B, D	Q675: B, C, D
Q676: A, C	Q677: A, C, D, E	Q678: B, C, D	Q679: B, C, D, E	Q680: A, D
Q681: C	Q682: A, B, D	Q683: A, B, C, D, E	Q684: A, B, C	Q685: B, D, E
Q686: A, B, C, D	Q687: A, B, C, D, E	Q688: A, B, C, E	Q689: A, B, C, D, E	Q690: A, C, D, E
Q691: A, C	Q692: A, B, C, D	Q693: E	Q694: E	Q695: D, E
Q696: B	Q697: A, E	Q698: A, B, D, E	Q699: A, B	Q700: A, B, D, E
Q701: A, B, E	Q702: A, B, E	Q703: A, B, C	Q704: A, D, E	Q705: A, B, C, E
Q706: B, D	Q707: A, B, C, E	Q708: A, C	Q709: A, B, D, E	Q710: A, C, D
Q711: A, C, D	Q712: A, B, D	Q713: A, C, D	Q714: A, B, D	Q715: A, B, C, D
Q716: B	Q717: A, C	Q718: B, E	Q719: B, C, E	Q720: B, D, E
Q721: B	Q722: C	Q723: B, C, E	Q724: E	Q725: B, D
Q726: E	Q727: A, C, D	Q728: A, C, D	Q729: A, B, C, D	Q730: C
Q731: A	Q732: A, B, C, E	Q733: A, C, D	Q734: C, D	Q735: A, B, C, D, E
Q736: A, C, D, E	Q737: A	Q738: A, E	Q739: A, B, C, E	Q740: A, D, E
Q741: A, C	Q742: D, E	Q743: A, C	Q744: A, E	Q745: E
Q746: E	Q747: B	Q748: A, B, E	Q749: A, B, C, D	Q750: A
Q751: A	Q752: A	Q753: A	Q754: B, C, E	Q755: A, B, C
Q756: A, B, C, D	Q757: A, B, C, E	Q758: C, D	Q759: A, B, D, E	Q760: A, D, E
Q761: A, B, C, D, E	Q762: A	Q763: B, E	Q764: B, C	Q765: A, C
Q766: A, E	Q767: A, B, C, D, E	Q768: A, C, D, E	Q769: A, C	Q770: A, B, C, D

Q771: A, C, D	**Q772: A, B, C**	**Q773: B, E**	**Q774: A, B, C, E**	**Q775: A, C, D, E**
Q776: A	**Q777: A**	**Q778: A**	**Q779: A**	**Q780: A**
Q781: A	**Q782: A**	**Q783: A**	**Q784: A, B, C, D**	**Q785: A, B, C, E**
Q786: A, B, D, E	**Q787: A, B, C**	**Q788: A, B, C, E**	**Q789: E**	**Q790: E**
Q791: D, E	**Q792: D**	**Q793: A, D, E**	**Q794: A, C**	**Q795: A, B, C**
Q796: A, C, D, E	**Q797: A, B, C, D**	**Q798: A, B, C**	**Q799: A, B**	**Q800: B**
Q801: A	**Q802: A, B, C, D**	**Q803: A, B**	**Q804: A**	**Q805: A**
Q806: A	**Q807: A**	**Q808: A**	**Q809: A**	**Q810: A**
Q811: A	**Q812: A**	**Q813: A**	**Q814: A**	**Q815: A**